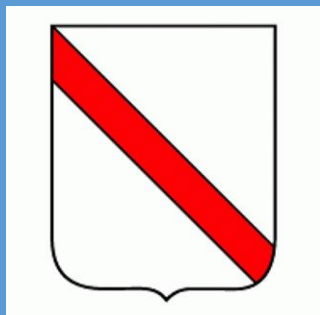




Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) 2023-2027

**Regione
Campania**

Il presente documento è stato redatto dai seguenti dirigenti della UOD Igiene e sanità pubblica veterinaria – Regione Campania come di seguito individuati:

Dott. Vincenzo Barra

Dott.ssa Grazia Brignola

Dott.ssa Gabriella Coppola

Dott. Giuseppe Di Loria

Dott. Maurizio Della Rotonda

Dott. Marco Esposito

Dott.ssa Giovanna Fierro

Dott. Berardino Izzo

Dott.ssa Clotilde La Stella

Dott.ssa Cinzia Matonti

Dott. Renato Pinto

Dott.ssa Laura Pitaro

Dott. Guido Rosato

Dott.ssa Carla Santojanni

Dott.ssa Antonietta Sarnataro

Dott. Giorgio Smaldone

Dott. Piero Tuccillo

in collaborazione con la dr.ssa Germana Colarusso dell'O.R.S.A.

I criteri per la classificazione del rischio degli stabilimenti sono stati elaborati **in collaborazione con i dott. Florentin Blanc, Blerta Guzina e Gordana Ristič dell'OCSE**, nell'ambito del **Progetto RAC** (Rating Audit Control).

Sommario

INTRODUZIONE	1
SEZIONE A - STRUTTURA	1
SEZIONE B – PRINCIPI DI RIFERIMENTO	2
SEZIONE C - PUNTO DI CONTATTO E REFERENTE TECNICO	7
SEZIONE D - SISTEMA INFORMATIVO.....	8
CAPITOLO 1 - OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI	12
CAPITOLO 2 - AUTORITÀ COMPETENTI E LABORATORI REGIONALI DI RIFERIMENTO	20
SEZIONE A - AUTORITÀ COMPETENTI ED ORGANISMI DI CONTROLLO	20
SEZ. A.1. – POLO DIDATTICO INTEGRATO E CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALI	22
SEZIONE B - LABORATORI REGIONALI DI RIFERIMENTO	29
SEZIONE C - MISURE DI COORDINAMENTO	29
SEZIONE D – FORMAZIONE	31
CAPITOLO 3 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI	32
SEZIONE A - MACROAREE E SETTORI	32
SEZIONE B - MACROAREA ALIMENTI E SICUREZZA ALIMENTARE	34
SETTORI 1 e 2: SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, DEGLI ALIMENTI NON DI ORIGINE ANIMALE ED ISPETTORATI MICOLOGICI	34
SETTORI 3, 4 e 5 – QUALITÀ MERCEOLOGICA DEGLI ALIMENTI, PRODUZIONI AGROALIMENTARI REGOLAMENTATE E PRODUZIONI BIOLOGICHE.....	37
SETTORE 6 – ACQUE POTABILI E MINERALI	37
SETTORE 7 – NUTRIZIONE UMANA	37
SETTORE 8 e 9 – FSG E MOCA	38
SEZIONE C - MACROAREA SALUTE ANIMALE	39
SETTORE 10 – ANAGRAFE - SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE: I&R.....	39
SETTORE 11 –MALATTIE INFETTIVE	40
SETTORE 12 – RIPRODUZIONE ANIMALE	50
SEZIONE D - MACROAREA MANGIMI	51
SETTORE 13 –MANGIMI.....	51
SEZIONE E – MACROAREA BENESSERE ANIMALE	51
SETTORE 14 - BENESSERE ANIMALE.....	51
SETTORE 15 - SPERIMENTAZIONE ANIMALE.....	52
SETTORE 16 - INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA).....	53
SEZIONE F - MACROAREA SANITÀ DELLE PIANTE.....	54
SETTORE 17 – ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE	54

SETTORE 18 – PRODOTTI FITOSANITARI.....	56
SEZIONE G - MACROAREA M.S.R., S.O.A. e P.D.....	58
SETTORI 19 e 20 - M.S.R., S.O.A. e P.D.....	58
SEZIONE H - MACROAREA FARMACI VETERINARI.....	59
SETTORE 21 - FARMACOVIGILANZA VETERINARIA	59
SETTORE 22 - FARMACOSORVEGLIANZA VETERINARIA.....	60
SEZIONE I - MACROAREA ALTRO	62
SETTORE 23 – ZONOSI NELL’UOMO E M.T.A.....	62
SETTORE 24 – AMBIENTE	63
SETTORE 25 – IGIENE URBANA VETERINARIA (IUV) E LOTTA AL RANDAGISMO	64
SETTORE 26 – SISTEMA RAPIDO D’ALLERTA	67
SETTORE 27 – OGM.....	69
CAPITOLO 4 - PIANI DI INTERVENTO ED ASSISTENZA.....	70
SEZIONE A - PIANI DI INTERVENTO	70
SEZIONE B - COOPERAZIONE ED ASSISTENZA RECIPROCA.....	71
CAPITOLO 5 – SISTEMA REGIONALE DI AUDIT E VERIFICA DELL’EFFICACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI	72
SEZIONE A – SISTEMA REGIONALE DI AUDIT	72
SEZIONE A.1. - AUDIT EFFETTUATI DAI SERVIZI DIPARTIMENTALI DELLE AA.SS.LL. SULLE PROPRIE STRUTTURE;.....	73
SEZIONE A.2. - AUDIT EFFETTUATI DALLA U.O.D. “PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA” DELLA REGIONE SULLA PROPRIA STRUTTURA	73
SEZIONE A.3. - AUDIT DI SISTEMA EFFETTUATI DALLA U.O.D. “PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA” DELLA REGIONE SUL SISTEMA DI GESTIONE	74
SEZIONE A.4. - AUDIT DI SETTORE EFFETTUATI DALLA U.O.D. “PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA” DELLA REGIONE SUI SERVIZI	74
SEZIONE A.5. - AUDIT EFFETTUATI DAI SERVIZI DIPARTIMENTALI DELLE AA.SS.LL. NEGLI STABILIMENTI/AZIENDE.	75
SEZIONE B - VERIFICA DELL’EFFICACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI	76
CAPITOLO 6 - CRITERI OPERATIVI E PROCEDURE	78
SEZIONE A – RISPETTO DEI CRITERI OPERATIVI.....	78
SEZIONE A.1. - CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI	78
SEZIONE A.1.1. – OTTENIMENTO DI UNA ANAGRAFICA COMPLETA DEGLI STABILIMENTI/AZIENDE E DELLE LINEE D’ATTIVITÀ IN ESSI SVOLTE.....	79
SEZIONE A.1.2. - CATEGORIZZAZIONE DI RISCHIO “QUANTITATIVA” DELLE LINEE DI ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI STABILIMENTI	80
SEZIONE A.1.3. - CATEGORIZZAZIONE DI RISCHIO “QUALITATIVA” DEGLI	84

SEZIONE A.1.4. – IDENTIFICAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI	84
SEZIONE A.1.5. – IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI E LORO CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLE PRIORITÀ (DPA);	84
SEZIONE A.1.6. – APPRONTAMENTO DI UN SISTEMA PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE PERFORMANCE MINIME AD PERSONAM	85
SEZIONE A.1.7. – APPRONTAMENTO DI UN SISTEMA PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE PERFORMANCE MINIME DI STRUTTURA.....	90
SEZIONE A.1.8. – ASSUNZIONE DELLA COMPETENZA AD EFFETTUARE I CONTROLLI PIANIFICATI A LIVELLO REGIONALE CON IL DPA;	91
SEZIONE A.1.9. – PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI A FARSI IN BASE AL NUMERO DELLE PERFORMANCE MINIME IN POSSESSO (DPAT);	91
SEZIONE A.1.10. – SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI	91
SEZIONE A.1.11. – IDENTIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI E DI STRUTTURA	92
SEZIONE A.2. - PERSONALE DELLA A.C. CHE EFFETTUA CONTROLLI UFFICIALI.....	93
SEZIONE A.3 – CONTROLLI UFFICIALI	96
SEZIONE A.4. – ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI.....	102
A.5. - GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ.....	102
SEZIONE C - REGISTRAZIONI DEI CONTROLLI UFFICIALI	110

INTRODUZIONE

SEZIONE A - STRUTTURA

Il presente Piano di Controllo Regionale Pluriennale 2023-2027 (d'ora innanzi denominato PCRP) detta le norme per la pianificazione, programmazione, rendicontazione e pubblicizzazione dei controlli ufficiali effettuati in ambito regionale dalle Autorità Competenti a svolgere i controlli nelle materie elencate all'art. 1, punto 2 del Reg. UE 2017/625 sottoelencate:

- a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
- b) l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
- c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;
- d) le prescrizioni in materia di salute animale;
- e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
- g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- h) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
- i) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
- j) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Oltre a quelle di cui all'elenco sopra riportato, a livello regionale il presente P.C.R.P. definisce norme e procedure per i controlli anche nelle seguenti materie:

- a) sperimentazione animale;
- b) il farmaco veterinario;
- m) igiene urbana veterinaria;
- n) interventi assistiti con gli animali (IAA).

Il P.C.R.P., pertanto, è lo strumento fondamentale su cui si basa il Sistema di Gestione Integrato dei Controlli delle Autorità Competenti.

SEZIONE B – PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il P.C.R.P., come il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (P.C.N.P.), è redatto ai sensi del Titolo V del Regolamento (UE) n. 2017/625, che ne stabilisce l'ambito di applicazione, ed in conformità alla Decisione 2021/C 78/01, che ne individua i requisiti fondamentali. Esso è stato approntato inoltre secondo gli indirizzi stabiliti:

- dal Decreto n. 346 del 7/8/15 del Commissario governativo ad acta per il Piano di Rientro, nonché;
- dall'Accordo Stato-Regioni 7/2/13, n. 46 "Linee guida funzionamento della A.C." recepito con DGRC 27.9.13, n. 380,
- dall'Intesa Stato-Regioni 10/11/2016 n. 212 "Linee guida 882" recepito con DGRC 23.1.17, n. 27.
- dall'Intesa Stato-Regioni Rep. atti 55/CSR del 22/03/2023 "Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027",
- dalla DGRC 25/05/2023, n. 290 "Recepimento Intesa n. 55/CSR della Conferenza Stato Regioni del 22 marzo 2023 "Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027". Determinazioni.
- dall'Intesa Stato-Regioni 6/8/20, n. 127 "Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025".

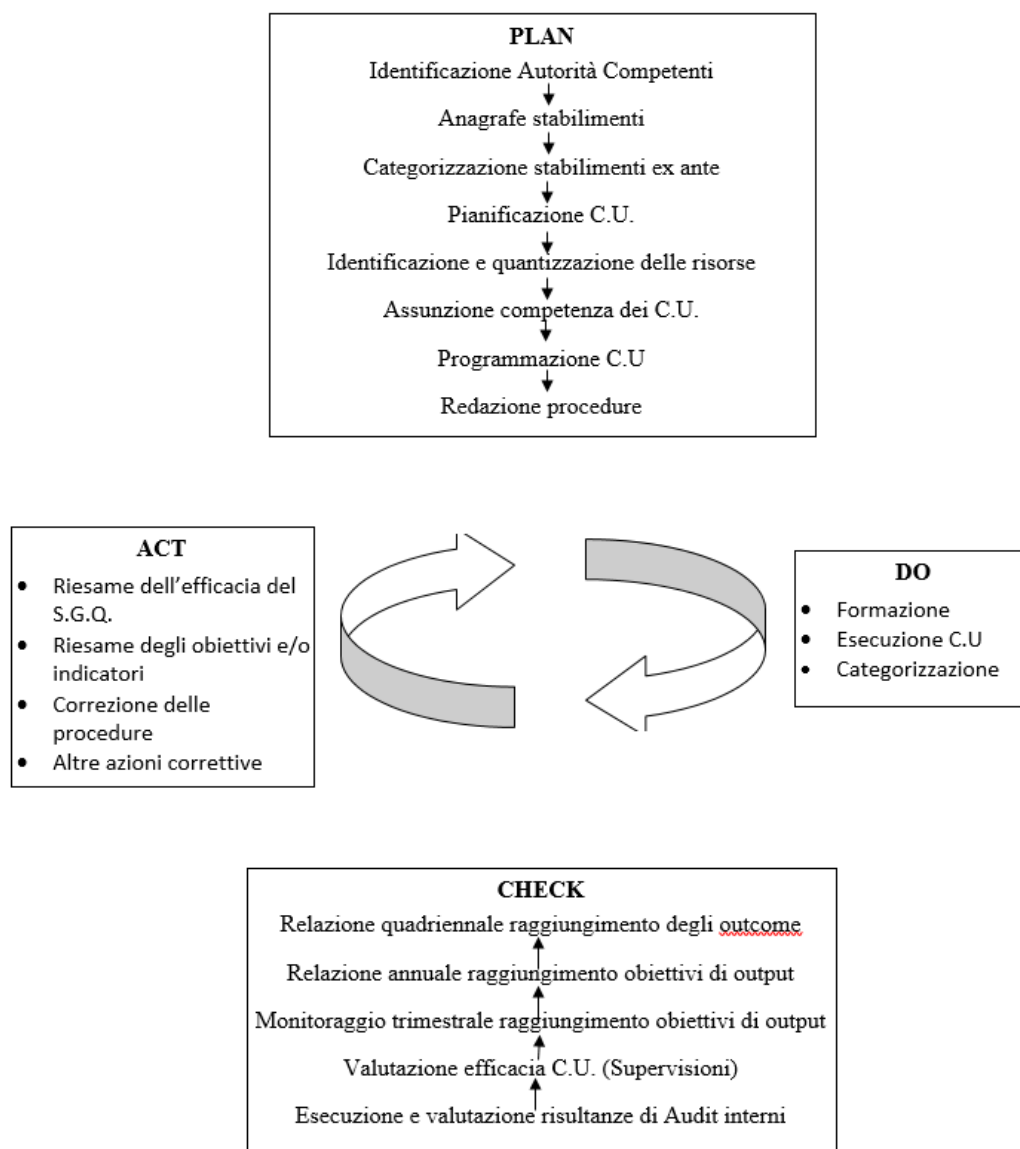
Il Regolamento UE 2017/625 ed il P.C.N.P. prevedono che il P.C.R.P.:

- sia messo a disposizione del pubblico, ad eccezione delle parti del piano la cui divulgazione potrebbe compromettere l'efficacia dei controlli ufficiali;
- venga regolarmente aggiornato durante il periodo di applicazione;
- fissi gli obiettivi strategici e descriva il modo in cui le priorità dei controlli e l'allocazione delle risorse rispecchino tali obiettivi;
- classifichi i controlli ufficiali in base al rischio;
- designi le autorità competenti ed illustri i loro compiti nonché le risorse di cui esse dispongono;
- se del caso, illustri la delega di compiti agli organismi delegati;
- illustri l'organizzazione e il sistema di gestione dei controlli ufficiali, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti;
- illustri i sistemi di controllo applicati ai diversi settori e il coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori;
- preveda le procedure e soluzioni introdotte per garantire la conformità agli obblighi delle autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento;
- descriva le modalità della formazione del personale delle autorità competenti;
- illustri le procedure documentate di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del Regolamento;
- descriva l'organizzazione e il funzionamento generali dei piani di emergenza in conformità della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento;
- promuova un approccio coerente, completo ed integrato ai controlli ufficiali in tutti i campi di competenza del Regolamento;
- individui i criteri per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio.

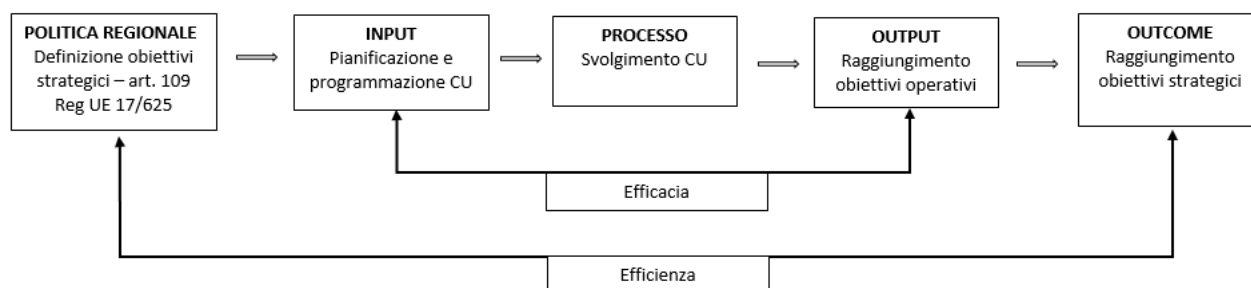
Il P.C.R.P. rappresenta la naturale evoluzione dei Piani Nazionali Integrati e dei Piani Regionali Integrati di cui al Regolamento (CE) 882/2004 succedutisi nel tempo ed ha come punto di partenza la relazione finale al P.C.R.P. 2020-2022, approntata dall'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), nella quale sono stati evidenziati i punti critici, le aree di miglioramento e i punti di forza del sistema regionale di gestione dei controlli ufficiali, unitamente alla necessaria valutazione del rischio regionale.

Esso definisce gli obiettivi e la politica regionale nelle materie di competenza del Regolamento, e descrive il Sistema di Gestione dei Controlli Ufficiali (S.G.C.U.) che verranno svolti in Regione Campania nel quinquennio 2023-2027.

Essendo un Sistema di Gestione, nella redazione del presente P.C.R.P. si tiene conto dei principi su cui si basano i sistemi di gestione della qualità ex ISO 9001:2015 ed in particolare del "ciclo di Deming", di seguito adattato al "Macroprocesso C.U." del presente Sistema di Gestione dei Controlli Ufficiali:



Il “Macroprocesso C.U.” del presente Sistema di Gestione dei Controlli Ufficiali può essere così schematizzato:



L'outcome del presente Piano è il miglioramento dello stato di salute del complesso “*uomo-animale-ambiente*” in un’ottica di One Health.

Nella redazione e nello sviluppo del presente Piano si tiene conto dei seguenti "concetti chiave":

a) Unico - Il Piano dei controlli descrive in un unico documento:

- gli obiettivi strategici;
- gli obiettivi operativi;
- le procedure documentate;
- le risorse.

b) Integrato - Il Piano deve promuovere un approccio integrato dei controlli ufficiali in modo da favorire la loro coerenza, completezza, efficacia ed efficienza. Per soddisfare il requisito dell’approccio integrato non è sufficiente la mera elencazione delle Autorità e Forze di Polizia che a vario titolo svolgono controlli ufficiali, ma occorre definire procedure concordate per l’espletamento di controlli congiunti.

c) Basato sulla valutazione del rischio.

Sebbene il presente P.C.R.P. sia rivolto agli Organi che a vario titolo esplicano controlli ufficiali, la sua applicazione ha indubbie ripercussioni anche su altri portatori d’interesse, altrimenti denominati stakeholder.

Gli stakeholder del presente Piano sono:

- l’intera popolazione della Regione Campania;
- le associazioni di consumatori;
- le associazioni delle imprese operanti nei settori oggetto dei controlli.

Con efficaci ed appropriate modalità che tengano conto dei dettami ex art. 11 Reg. UE 2017/625, il presente piano viene pubblicizzato in modo da portare a conoscenza degli stakeholders:

- quali siano le Autorità Competenti a svolgere i controlli e la loro mission;
- gli indirizzi strategici adottati;
- le risorse utilizzate;
- risultati in termini di efficacia ed efficienza raggiunti.

Il presente P.C.R.P. può essere inquadrato quale “bilancio sociale” delle Pubbliche Amministrazioni che operano i controlli ufficiali nelle materie di cui alla Sezione A, in quanto prevede la comunicazione periodica agli stakeholders degli esiti delle attività di tali P.A., non limitandosi ai soli aspetti contabili ma alle ricadute sugli stakeholders stessi.

Per quanto riguarda in particolare la sicurezza alimentare, nella formulazione del P.C.R.P., si è tenuto conto della politica strategica dell’Unione Europea, la quale si fonda sui seguenti principi:

- i controlli non devono essere concentrati sul prodotto finale, ma distribuiti lungo tutto il processo di produzione, con una visione complessiva “dai campi alla tavola”;
- la diminuzione delle malattie trasmesse dagli alimenti (MTA) e dei danni derivanti dal consumo di alimenti ad alto rischio deve essere garantita attraverso un nuovo e moderno approccio culturale che coinvolga tutti gli attori della filiera alimentare dalla fase produttiva a quella distributiva, i quali diventano “responsabili giuridici”, ciascuno per la propria parte, della sicurezza dei prodotti;
- le attività di controllo devono essere pianificate e programmate in maniera trasparente ed integrale, devono essere basate sulla valutazione del rischio e devono avere come *outcome* un aumento dello stato medio di salute del consumatore.

Il P.C.R.P. è stato redatto in modo da estendere l’approccio sopra descritto a tutte le materie elencate nella sezione A in modo da dare in tutti della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria ampia applicazione dei dettami dell’art. 9 del Reg. UE 2017/625, che stabilisce controlli ufficiali eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata.

Per quanto riguarda il S.S.R. (Strutture Regionali ed AA.SS.LL.), il P.C.R.P. rappresenta lo strumento basilare da utilizzare affinché i controlli ufficiali siano programmati e svolti secondo principi di integrazione e ottimizzazione. Inoltre, esso:

- stabilisce per le suddette A.C. requisiti minimi di funzionalità ed efficienza tesi a garantire la conformità delle stesse al Regolamento UE 2017/625 ed all’Accordo Stato-Regioni 7/2/13, n. 46;
- detta i criteri per monitorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli effettuati dalle suddette A.C.;
- uniforma le procedure e la modulistica utilizzate dalle suddette A.C. per l’effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;
- definisce procedure univoche in uso ai Dipartimenti di Prevenzione per la programmazione annuale dei controlli e la loro rendicontazione, in modo da verificare il raggiungimento degli obiettivi operativi;
- detta indicazioni alle AA.SS.LL. in merito alle modalità di categorizzazione degli stabilimenti/aziende in base al rischio, in modo da consentire di:
 - ✓ determinare un’efficace selezione degli interventi sulla base dei rischi;
 - ✓ utilizzare in maniera efficiente le risorse tramite una loro razionale distribuzione;

- prevede la formazione del personale afferente alle suddette A.C., dando disposizioni affinché possiedano le qualifiche e le competenze necessarie per effettuare i controlli ufficiali in modo efficace.

Si ritiene necessario definire preliminarmente cosa si intende nel P.C.R.P. per:

a) Pianificazione (planning)= individuazione degli obiettivi strategici stabiliti in base alla valutazione del rischio (riskbased). La pianificazione viene definita con il presente Piano. Nell'ambito della pianificazione si intende per:

- indice: un'informazione sintetica capace di descrivere lo stato di un elemento specifico del sistema oggetto di studio (es. prevalenza, incidenza);
- indicatore: grandezza espressa in forma numerica (valore assoluto o rapporto o percentuale) finalizzata a rappresentare in modo sintetico un fenomeno complesso (processo, attività o risultato);
- tasso: indice matematico di una quantità.

b) Programmazione (programming) = l'individuazione degli obiettivi operativi che ciascuna delle A.C. deve svolgere per il raggiungimento degli obiettivi strategici; essa è la traduzione operativa della pianificazione e deve essere esplicitata in appositi documenti programmatici regionali e territoriali emanati con atto formale. Per quanto riguarda lo specifico campo dei controlli in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria svolti dalle AA.SS.LL., la programmazione consta:

- nell'individuazione numerica minima dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da effettuare;
- nell'individuazione dei tempi per il loro svolgimento;
- nell'individuazione delle modalità del loro svolgimento.

c) Finanziamento (budgeting) = indicazione dei costi e dei mezzi finanziari per la loro copertura per procedere all'espletamento dei controlli ritenuti necessari al raggiungimento degli obiettivi strategici.

SEZIONE C - PUNTO DI CONTATTO E REFERENTE TECNICO

Come richiesto dal Ministero della Salute, il presente P.C.R.P. deve prevedere l'indicazione di un Punto di Contatto Regionale e di un referente tecnico, che vengono regolarmente riportati sotto:

PUNTO DI CONTATTO REGIONALE	
Responsabile Unità Operativa Dirigenziale 01 <i>"Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"</i> incardinata nella D.G. 04 <i>"Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale"</i>	
Indirizzo:	Centro Direzionale Isola C 3 - 80143 – Napoli Tel 081 7969399 mail: flussi.veterinaria@pec.regione.campania.it

REFERENTE TECNICO DEL PIANO	
<i>Dr. Carla Santojanni</i> Dirigente Veterinario presso l'Unità Operativa Dirigenziale 01 <i>"Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"</i> della D.G. 04 <i>"Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema Sanitario Regionale"</i>	
Indirizzo:	Centro Direzionale Isola C 3 - 80143 – Napoli Tel 081 7969397 mail: carla.santojanni@regione.campania.it

In particolare, il **Punto di contatto regionale** cura:

- la convocazione del Tavolo Tecnico con le Autorità interessate;
- l'approvazione del Piano pluriennale;
- la trasmissione del Piano alle Autorità coinvolte ed agli stakeholder;
- la redazione della relazione annuale e la sua trasmissione alle Autorità Competenti centrali e territoriali e alle Forze di Polizia coinvolte;
- la modifica del Piano alla luce delle evidenze scaturite dall'analisi dei risultati annuali;
- la redazione della relazione finale e la sua trasmissione alle Autorità Competenti centrali e territoriali e alle Forze di Polizia coinvolte ed agli stakeholder.

Il **Referente Tecnico** cura:

- l'analisi degli input da parte delle A.C. e da parte delle altre Autorità e Forze dell'Ordine;
- l'approntamento del Piano pluriennale;
- l'inserimento delle attività regionali nel P.C.N.P.

SEZIONE D - SISTEMA INFORMATIVO

Il presente Piano è supportato dal Sistema informativo *gestionale per la Sicurezza alimentare e Sanità Pubblica veterinaria* (nel seguito chiamato GISA), che fa parte del più ampio ecosistema software regionale open source denominato “G.I.S.A. Campania”. Esso consente, tramite il digitale, di pianificare, programmare, gestire e valutare le attività e le performance connesse a quanto previsto dal P.C.R.P., ad eccezione di quelle per le quali è già prevista l'utilizzazione di sistemi informatici nazionali (BDN, SANAN, SIMAN, ecc.). In tali casi le procedure documentate utilizzate durante le ispezioni, gli audit e i monitoraggi specificano l'utilizzo di sistemi informativi diversi da GISA.

Il personale delle AA.SS.LL. è tenuto a inserire in GISA tutte le informazioni sugli stabilimenti, sulla loro categorizzazione in base al rischio, sulle attività di controllo ufficiale svolte, sulle non conformità accertate e su qualsiasi altro debito informativo richiesto dal sistema, comprese le informazioni relative alle attività di campionamento.

Il sistema GISA è in grado di cooperare con i sistemi informativi dei laboratori ufficiali e, attraverso la funzione di “preaccettazione dei campioni”, garantire la tracciabilità dei campioni eseguiti ed il relativo esito analitico.

La preaccettazione dei campioni è una procedura di interoperabilità fra il sistema GISA e quelli dei laboratori dell'IZSM e dell'ARPAC per consentire il passaggio automatico di tutte le informazioni relative al campionamento. All'atto d'inserimento di un campione in GISA, l'utente ASL attraverso una funzione specifica potrà inviare, in tempo reale, le informazioni nei sistemi di laboratorio creando una preaccettazione del campione. Tale operazione verrà richiamata in fase di consegna del campione alle sedi accettanti. La preaccettazione è attuabile da desktop o in tempo reale da dispositivo mobile previa installazione di specifico applicativo “Preaccettazione GISA” sviluppato per sistemi Android ed iOS (documento *preaccettazione GISA guida utente - rev 5 del 03-10-2022*).

In considerazione di quanto disposto dalla L. 116/14 per quanto riguarda le aziende agricole, alimentari e mangimistiche, e dall'allegato alla DGRC n. 623/14 e ss.mm.ii. sugli illeciti amministrativi, anche alle altre Autorità e Forze di Polizia è previsto l'accesso al GISA per consentire alle stesse:

- di avere un quadro sempre più completo ed unico sullo stato del rischio in Regione Campania;
- di avere un quadro aggiornato della valutazione del rischio dei singoli stabilimenti;
- di ottimizzare il sistema dei controlli evitando inutili duplicazioni;
- di avere un registro unico regionale dei trasgressori in ottemperanza alla L.R. 13/1983;

Il sistema informativo, accessibile anche dal sito istituzionale dell'O.R.S.A., consente quindi:

- la gestione completa del processo ispettivo, ivi inclusa la gestione ed il monitoraggio dei pagamenti delle sanzioni tramite PagoPA;
- la consultazione dell'anagrafica unica di tutti gli stabilimenti/aziende siti in Regione Campania che ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria;
- la georeferenziazione degli stabilimenti/aziende e delle non conformità in base ai parametri prescelti;
- la consultazione dell'anagrafica unica regionale dei cani identificati e dei loro

- proprietari (altrimenti detta Banca Dati Regionale – BDR);
- la visualizzazione di tutti gli accertamenti sanitari compiuti sui piccoli animali vaganti, sinantropi, animali spiaggiati, sia in vivo che su carcasse (sistema informatico VAM - Veterinary Activity Management).

L'estrazione dei dati dalla suddetta reportistica è lo strumento che, in base ai dati aggregati richiesti, permette alla Regione ed alle AA.SS.LL. il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività svolte, del raggiungimento degli obiettivi operativi, nonché la valutazione dell'idoneità del P.C.R.P. ad affrontare le problematiche di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria e sanità delle piante.

L'inserimento dei dati, così come richiesti dal sistema GISA, deve essere effettuato con diligenza da tutti gli operatori abilitati trattandosi per massima parte di verbali redatti da pubblici ufficiali e come tali costituenti atti pubblici ai sensi dell'art. 2699 c.c..

Le AA.SS.LL. devono fornire agli operatori del controllo ufficiale adeguati supporti informatici affinché gli stessi possano adempiere diligentemente a tale obbligo. Gli inadempimenti o gli abusi sono sanzionabili sotto il profilo della responsabilità dirigenziale, disciplinare e penale.

Il sistema informativo è accessibile attraverso il Sistema Pubblico di identità Digitale (SPID) o la Carta d'identità Elettronica (CIE), previa profilazione dell'operatore sulla base del livello di autorizzazione che gli compete. Ad esempio, le AA.SS.LL. sono autorizzate a vedere e inserire/modificare/integrare dati relativi al solo territorio di propria competenza, mentre alle Forze di Polizia l'ambito di azione è relativo a tutto il territorio regionale. In ottemperanza alle norme in materia di digitalizzazione della P.A., ed in particolare al D.Lgs. 82/05 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - aggiornato dal Decreto-Legge 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 70/2022 e dal D.L. 13/2023, il sistema informativo GISA Campania è predisposto all'interoperabilità ed alla cooperazione applicativa. È obiettivo della Regione implementare sempre di più tale modalità in modo da dare completa applicazione alle norme in materia di semplificazione, dematerializzazione, efficienza, efficacia ed economicità della P.A. nel rispetto del principio di leale cooperazione istituzionale sancito dall'art.22 comma 5 della legge n.241/90 e ribadito anche dall'art. 12 del D.Lgs. n. 27/2021, e in coerenza con i principi declinati nell'European Interoperability Framework (EIF) oggetto della Comunicazione COM (2017) 134 della Commissione Europea, adottata il 23 marzo 2017.

Nell'ambito del Sistema Informativo è disponibile il servizio digitale GISA Autovalutazione che è una web application, accessibile da Portale della Regione Campania e fruibile anche da smartphone, attraverso cui imprese e operatori economici che già operano nel settore alimentare o veterinario, oppure chi intende aprire un'attività commerciale in questo campo, potranno effettuare un'autovalutazione volontaria sulla conduzione della propria attività, rispondendo alle domande delle stesse check list utilizzate dalle AA.SS.LL. durante i controlli ufficiali. In questo modo, le imprese già attive potranno accrescere la consapevolezza sui rischi connessi alla linea attività intrapresa e risolvere fattori critici prima dei controlli ufficiali, mentre coloro che intendono avviare una nuova attività potranno ottenere informazioni e suggerimenti utili per adottare modalità operative e gestionali corrette. Ulteriori approfondimenti su GISA Autovalutazione sono riportati nelle sezioni A.1.2. e A.2.3.

SEZIONE E – ACRONIMI

A.C.	<i>Autorità Competenti</i>
A.D.	<i>Agenzia delle Dogane</i>
AGEA	<i>Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura</i>
ARPAC	<i>Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania</i>
Alimenti O.A.	<i>Alimenti di Origine Animale</i>
A.S.L.	<i>Azienda Sanitaria Locale</i>
BDAR	<i>Banca Dati Apistica Regionale</i>
BDN	<i>Banca dati Nazionale per l'anagrafe zootecnica</i>
BDR	<i>Banca Dati Regionale per l'anagrafe dei cani/gatti/furetti</i>
CE	<i>Comunità Europea</i>
CIE	<i>Certificato d'Impianto Embrionale</i>
CIF	<i>Certificato d'Intervento fecondativo</i>
C.N.L.	<i>Contratto Nazionale di Lavoro</i>
C.P.	<i>Codice Penale</i>
C.P.P.	<i>Codice di Procedura Penale</i>
C.R.R.	<i>Centro Regionale Radioattività</i>
CC NAC	<i>Carabinieri Nucleo Politiche Agricole Alimentari</i>
CC NAS	<i>Carabinieri Nucleo Tutela della Salute</i>
Ce.R.V.En.E.	<i>centro Regionale per la Prevenzione e la Gestione delle Emergenze</i>
C.RI.B.BA.M	<i>Centro di riferimento regionale per la biosicurezza il benessere animale e di contrasto al maltrattamento</i>
C.RI.P.A.T.	<i>Centro di riferimento regionale per la sicurezza nella ristorazione pubblica e collettiva e nelle produzioni agroalimentari tradizionali</i>
C.RISSAP	<i>Centro di riferimento regionale per la Sicurezza Sanitaria del Pescato</i>
C.R.I.U.V.	<i>Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria</i>
C.RE.S.AN	<i>Centro di riferimento regionale per la Sanità Animale</i>
C.S.N.	<i>Centro Servizi Nazionale</i>
DPAR	<i>Documento di Programmazione Annuale Regionale</i>
DPAT	<i>Documenti di Programmazione Annuale Territoriale</i>
FSG	<i>Food for Specific Goup (Alimenti per gruppi specifici di consumatori)</i>
G.C.	<i>Corpo Capitaneria di Porto - Guardia Costiera</i>
G.d.F	<i>Guardia di Finanza</i>
HUB	<i>centro di riferimento della Rete, attività di secondo livello</i>
IAA	<i>Interventi Assistiti con gli Animali</i>
I.C.C.Q.R.F.	<i>Ispettorato Centrale Controllo Qualità e Repressione Frodi</i>
IZSM	<i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno</i>
LNR	<i>Laboratori Nazionali di Riferimento</i>
MBV	<i>Molluschi bivalvi vivi</i>
MIPAAF	<i>Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali</i>
MOCA	<i>Materiali a contatto con gli alimenti</i>
MSR	<i>Materiale Specifico a Rischio</i>
MTA	<i>Malattie trasmesse dagli alimenti</i>
N.C.	<i>Non Conformità</i>
NU.RE.C.U.	<i>Nucleo Regionale Controlli Ufficiali</i>
O.E.R.	<i>Osservatorio Epidemiologico Regionale</i>

O.E.V.R.	<i>Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale</i>
O.R.S.A.	<i>Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare</i>
O.S.A.	<i>Operatore del Settore Alimentare</i>
O.S.M.	<i>Operatore del Settore Mangimistico</i>
P.A.T.	<i>Prodotti Agroalimentari Tradizionali</i>
P.G.	<i>Polizia Giudiziaria</i>
P.C.F.	<i>Posti di Controllo Frontalieri</i>
P.D.	<i>Prodotti Derivati</i>
P.M.A.	<i>Polizia Municipale Annonaria</i>
P.N.A.A.	<i>Piano Nazionale Alimentazione Animale</i>
P.N.B.A.	<i>Piano Nazionale Benessere Animale</i>
P.C.N.P.	<i>Piano dei Controlli Nazionale Pluriennale</i>
P.N.R.	<i>Piano Nazionale Residui</i>
P.N.P.	<i>Piano Nazionale della Prevenzione</i>
P.R.P.	<i>Piano Regionale della Prevenzione</i>
P.C.R.P.	<i>Piano dei Controlli Regionale Pluriennale</i>
PSR	<i>Piano sanitario Regionale</i>
REV	<i>Ricetta Elettronica Veterinaria</i>
R.R.I.M.	<i>Rete Regionale Ispettorati Micologici Hub/Spoke</i>
SANAN	<i>Sistema Informativo Sanità Animale</i>
SCIA	<i>Segnalazione Certificata di Inizio Attività</i>
SGCU	<i>Sistema di Gestione Controlli Ufficiali</i>
SGQ	<i>Sistema di Gestione della Qualità</i>
S.I.A.N.	<i>Servizio Igiene degli alimenti e Nutrizione</i>
SIMAN	<i>Sistema Informativo Malattie Animali</i>
S.I.N.	<i>Sito di Interesse Nazionale</i>
S.O.A.	<i>Sottoprodotti di origine animale</i>
SPOKE	<i>ispettorato Micologico della Rete, attività di primo livello</i>
S.S.R.	<i>Sistema Sanitario Regionale</i>
SUAP	<i>Sportello Unico per le Attività Produttive</i>
TSE	<i>Encefalopatie trasmissibili</i>
T.A.R	<i>Tribunale Amministrativo Regionale</i>
USMAF	<i>Ufficio Sanità Marittima ed aerea Frontaliera</i>
UE	<i>Unione Europea</i>
U.I.P.	<i>Unità Ispettiva di Persona</i>
U.P.S.	<i>Unità di Performance di Struttura</i>
UVAC	<i>Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari</i>
V.A.M.	<i>Veterinary Activity Management</i>

CAPITOLO 1 - OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI

Al fine di tutelare la salute umana, animale e dei vegetali, il presente P.C.R.P. è strutturato in modo che le attività da esso regolamentate siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali e di quelli stabiliti dal P.C.N.P. e dal P.N.P.

Sia gli obiettivi strategici nazionali che regionali devono essere considerati come processi tesi al miglioramento della situazione attuale; essi possono essere definiti target o gold standard e dovrebbero essere misurabili, come previsto dall'art. 1, comma 1 del D.M. 24 luglio 1995 dal titolo *"Contenuti e modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità del SSN"*.

Pertanto, per ogni obiettivo strategico regionale sono previsti almeno:

- ✓ un indicatore di outcome;
- ✓ la fonte da cui estrapolare i dati relativi agli indicatori.

Più semplicemente, come ormai riportato in letteratura in materia di obiettivi, anche gli obiettivi strategici del presente Piano devono essere SMART e cioè possedere le seguenti caratteristiche:

Specific	SPECIFICO	deve essere chiaro cosa, dove, quando e come la situazione verrà cambiata
Measurable	MISURABILE	deve essere possibile quantificare gli oggetti e i benefici
Accepted	ACCESSIBILE	deve essere presumibilmente possibile raggiungere gli obiettivi
Realistic	REALISTICO	deve essere presumibilmente possibile ottenere il livello di cambiamento riflesso dall'obiettivo
Timely	TEMPORIZZABILE (Temporalment e definito)	deve essere indicato il periodo di tempo in cui ogni obiettivo verrà raggiunto

Al fine di descrivere le modalità pratiche per il raggiungimento del target, ogni obiettivo strategico prevede uno o più obiettivi operativi, a loro volta recanti:

- un indicatore per la verifica del loro raggiungimento;
- la fonte da cui estrapolare i dati relativi agli indicatori.

Tali strumenti sono necessari per verificare, tra l'altro, l'appropriatezza della scelta degli obiettivi operativi quali strumento per il raggiungimento degli obiettivi strategici.

Al fine di programmare i controlli tesi al raggiungimento degli obiettivi operativi il presente P.C.R.P. prevede la redazione di:

- Documenti di Programmazione Annuale Regionale (DPAR) redatti dal Punto di Contatto regionale; nel periodo di vigenza del presente P.C.R.P., il DPAR prevede esclusivamente i controlli che devono effettuare le A.C. che fanno parte del SSR; pur tuttavia il Punto di Contatto ha il compito di porre le basi per la predisposizione di un unico DPAR congiunto con tutte le Autorità che effettuano controlli, siano essi appartenenti o meno al SSR. Nel DPAR viene riportato il numero minimo di controlli a farsi calcolati sulla base della valutazione del rischio o così come imposti da disposizioni nazionali e/o comunitarie:
 - per tutti i piani di monitoraggio e le attività per i quali è possibile procedere ad una reale programmazione,
 - per tutti i piani di monitoraggio ed attività che prevedono l'effettuazione di controlli ufficiali che possono essere programmati solo in base ai dati storici, in quanto risentono di variabili indipendenti dalla volontà di chi li programma. In fase di rendicontazione il numero di controlli non può costituire l'elemento in base al quale stabilire il raggiungimento di obiettivi operativi.

Poiché è palese che per evidenti limiti delle risorse non è possibile sottoporre a controllo tutte le attività che quotidianamente le imprese svolgono, per stabilire il numero minimo di controlli a farsi si procede ad effettuare una propedeutica valutazione del rischio; il numero minimo di controlli non solo deve essere statisticamente significativo per poter essere efficacemente rappresentativo del settore da controllare, ma deve graduarsi in base alle decisioni politiche le quali possono lecitamente stabilire aumenti, diminuzioni o reindirizzamenti dell'impegno delle P.A. deputate all'effettuazione di controlli ufficiali, in base alle esigenze ed al volere della popolazione rappresentata. Il numero minimo di controlli riportato nei DPAR costituisce pertanto il dato "politico" della programmazione dei controlli nelle materie oggetto del presente Piano. Dal numero di controlli stabilito dal DPAR discende, quindi, anche il fabbisogno di forza lavoro necessario all'effettuazione dei controlli stessi.

- Documenti di Programmazione Annuale Territoriale (DPAT) redatti dalle singole Aziende sanitarie secondo le procedure interne e la cui responsabilità di attuazione è della Direzione Generale delle stesse; alla luce degli obiettivi operativi regionali descritti annualmente nel DPAR, nei DPAT vengono stabilite e pubblicizzate le attività da svolgersi localmente. Nel caso vi sia un divario negativo tra il numero dei controlli programmati nel DPAR ed il numero programmato nel DPAT, è compito della Direzione strategica della ASL adottare gli opportuni provvedimenti per il rafforzamento o la redistribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per adeguarsi alla programmazione del DPAR. L'adozione o meno di tali provvedimenti rappresenta una delle fonti per la valutazione dell'operato dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. ai fini dell'applicazione del sistema dei controlli e di sanzioni stabilito dalle normative vigenti tra le quali i commi 6, 7 e 7 bis dell'art. 3 bis del D.Lgs. 30/12/92, n. 502 e s.m.i.. L'accertamento da parte della Regione del mancato adeguamento alla programmazione del DPAR costituisce per il Direttore Generale delle AA.SS.LL. grave inadempimento contrattuale.

Al fine di:

- dare evidenza del raggiungimento o meno degli obiettivi operativi,
- dare evidenza del raggiungimento o meno degli obiettivi strategici,
- verificare l'appropriatezza degli indicatori di outcome quali evidenza del raggiungimento degli obiettivi strategici, il presente P.C.R.P. prevede:
 - Relazioni annuali redatte dall'ORSA e ratificate con decreto del Punto di contatto. La Relazione annuale, redatta in conformità all'art. 113 del Reg. UE 2017/625 e della Decisione 2008/654/CE, riporta il resoconto dei controlli svolti, le criticità riscontrate e la valutazione del rischio regionale. Essa rappresenta un duplice strumento operativo, di verifica dell'attività svolta e di orientamento dell'attività futura. Infatti, sulla base delle evidenze emerse dalla relazione annuale viene valutata l'opportunità di modificare il sistema dei controlli nel suo insieme anche mediante la rimodulazione degli obiettivi operativi e delle modalità di integrazione tra le diverse Amministrazioni coinvolte. Le Relazioni annuali, dando evidenza del raggiungimento o meno degli obiettivi operativi riportati nei DPAT, rappresentano una delle fonti per la valutazione dell'operato dei Direttori Generali delle AA.SS.LL.
 - Relazione finale redatta dall'ORSA, entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quelli di durata del Piano, e ratificate con decreto del Punto di contatto. Essa dà l'evidenza sul raggiungimento o meno degli obiettivi strategici, sulle attività svolte per il loro raggiungimento, sulle criticità rilevate, sulla valutazione del rischio regionale e, identificando gli elementi di miglioramento nella pianificazione, programmazione e svolgimento dei controlli ufficiali, fornisce le opportune indicazioni per il Piano successivo.

L'elenco degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi per il quinquennio 2023-2027 viene riportato nella seguente tabella:

FONTE NORMATIVA	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE DI OUTCOME	FONTE DATI	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO	COMPETENZA DELL'OBIETTIV	FONTE DATI
Piano triennale di Sviluppo e Riqualificazione del Sistema Sanitario Campano -Piano Nazionale di Prevenzione (P.N.P.) - Piano dei Controlli Nazionale Pluriennale (P.C.N.P.) 2023-2027 -Piano dei Controlli Regionale Pluriennale (P.C.R.P.) 2023-2027	Tutelare la salubrità di alimenti e acque e la salute dei consumatori	Categorizzazione del rischio di tutti gli operatori del settore alimentare	ORSA	Riduzione del livello di rischio assegnato alle linee d'attività svolte negli stabilimenti condotti dalle imprese del settore agro-alimentare	Variazione triennale della classe di rischio calcolato in base ai criteri dinamici in seguito a controlli ufficiali senza rilevazione di non	ASL	GISA
		Livello di coordinamento delle attività dei laboratori ufficiali	UOD 01	Assicurare un'appropriata capacità dei laboratori ufficiali	garantire che entro la fine del 2027 IZSM e ARPAC assicurino un panel di analisi routinarie per la diagnosi di malattie trasmissibili con gli alimenti (almeno il set di patogeni previsti dalla direttiva 2003/99), conforme ai migliori standard	UOD 01	IZSM-ARPAC
		Valutazione del trend delle Non Conformità nei controlli ufficiali e nei campionamenti	ORSA	Riduzione delle Non conformità analitiche per criteri di sicurezza alimentare riscontrate durante i campionamenti ufficiali	Quantificazione del numero e del tipo di non conformità sui campioni per anno	ASL	GISA
				Riduzione delle Non conformità per tipologia riscontrate durante i controlli ufficiali	Quantificazione del numero e del tipo di non conformità sui controlli ufficiali per anno		
		Valutazione del trend delle Non Conformità rilevate attraverso il monitoraggio ordinario delle acque di rete	ORSA	Riduzione delle Non conformità rilevate attraverso i campioni effettuati sulle acque di rete	Quantificazione del numero e del tipo di non conformità sui controlli ufficiali per anno	ASL	GISA
		Assolvimento dei debiti informativi necessari per la gestione delle attività di controllo tramite il Sistema Informativo Regionale GISA	ORSA	Raggiungere la percentuale minima del 2% di controlli cui hanno partecipato almeno n. 2 diverse A.C. o Enti o Servizi	Conteggio dei controlli cui hanno partecipato almeno n. 2 diverse A.C. o Enti o Servizi	ASL	GISA
				Inserimento dei controlli ufficiali sul sistema informativo entro 5 giorni dalla data di esecuzione	Conteggio del numero di giorni intercorsi fra esecuzione del controllo ed inserimento sul sistema		
				Utilizzo del modulo pre-accettazione in almeno l'80 % dei campionamenti di alimenti previsti dal PCRP	Conteggio del numero di campioni accettati con pre-accettazione		
				Raggiungimento del 30% della registrazione dei Gestori Acque di rete nel sistema informativo GISA ai fini dell'inserimento dei Controlli Interni acque di rete nella sezione dedicata.	Rapporto fra numero dei Gestori acque di rete registrati nel sistema informativo che inseriscono i Controlli Interni e numero totale di gestori acqua di rete presenti sul territorio		

FONTE NORMATIVA	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE DI OUTCOME	FONTE DATI	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO	COMPETENZA DELL'OBIETTIVO	FONTE DATI
Piano triennale di Sviluppo e Riquadificazione del Sistema Sanitario Campano -Piano Nazionale di Prevenzione (P.N.P.) - Piano dei Controlli Nazionale Pluriennale (P.C.N.P.) 2023-2027 -Piano dei Controlli Regionale Pluriennale (P.C.R.P.) 2023-2027	Tutelare la salubrità di alimenti e acque e la salute dei consumatori	Aumento della conoscenza circa la diffusione delle malattie trasmesse da alimenti	UOD 01	Avviare una integrazione a livello regionale e locale con il Centro regionale di riferimento MTA sviluppando un sistema di sorveglianza integrato fra: Laboratori di microbiologia per matrici umane, IZS e ARPA per matrici alimentari, notifiche sanitarie.	Numero di protocolli di integrazione fra enti diversi	Centro regionale di riferimento MTA – IZS-ARPA-OER- Laboratori di microbiologia per matrici umane-SEP	UOD 01
		Miglioramento della formazione/informazione degli	UOD 01	Agevolare il contatto fra gli operatori addetti al controllo	Numero di iniziative ed interventi di formazione	POLO DIDATTICO	UOD 01
		Miglioramento della formazione/informazione degli operatori del controllo ufficiale	UOD 01	Realizzazione di un programma regionale di formazione che coinvolga tutti i Dipartimenti Aziendali delle AASSLL	Numero di iniziative ed interventi di formazione specifici su tematiche connesse alla sicurezza degli alimenti e alla nutrizione	POLO DIDATTICO INTEGRATO-CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALI-AASSLL	UOD 01
		Miglioramento della tutela della salute dei consumatori assicurando il loro diritto all'informazione	UOD 01	Definire appropriati canali di comunicazione nei confronti dei cittadini e delle loro Associazioni per aumentarne la consapevolezza e la capacità di scelta in materia di consumi alimentari.	Effettiva presenza sul sito web istituzionale regionale dell'ORSA di materiale informativo/divulgativo sulle malattie trasmesse da alimenti	POLO DIDATTICO INTEGRATO-CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALI-AASSLL-ORSA/OERV	ORSA/OERV
		Migliorare le conoscenze atte a documentare lo stato di nutrizione della popolazione	UOD 01	Coordinamento tra regione e ASL per il raccordo con le attività del TaSiN (Tavolo sicurezza Nutrizionale)	Acquisizione di informazioni sullo stato di nutrizione della popolazione con particolare riferimento alla malnutrizione per eccesso e per difetto	POLO DIDATTICO INTEGRATO-CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALI-AASSLL.	TaRSiN
		Prevenzione delle intossicazioni da funghi	SPOKE e HUB ispettorato micologico	Controllo ufficiale dei funghi spontanei freschi, con relativa certificazione, destinati alla vendita presso mercati ortofrutticoli, esercizi di vendita e ristoranti	Variazione dei numeri di intervento per "sospetta intossicazione da funghi"	SPOKE e HUB della Rete degli Ispettorati Micologici	HUB ispettorato micologico

FONTE NORMATIVA	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE DI OUTCOME	FONTE DATI	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO	COMPETENZA DELL'OBIETTIVO	FONTE DATI
Piano triennale di Sviluppo e Riqualificazione del Sistema Sanitario Campano -Piano Nazionale di Prevenzione (P.N.P.) - Piano dei Controlli Nazionale Pluriennale (P.C.N.P.) 2023-2027 -Piano dei Controlli Regionale Pluriennale (P.C.R.P.) 2023-2027	Acquisire e mantenere i requisiti per la qualifica di territorio ufficialmente indenne da BRC e TBC	BRUC BOV-BUF Riduzione della prevalenza media della BRC bovina/bufalina del 10% nel triennio di riferimento nei territori N.I.	VETINFO SIGLA/OEVR	Mantenimento della percentuale di copertura dei controlli sulle aziende bovine per BRC	100% controlli programmati sulle aziende e sugli animali	ASL	VETINFO SIGLA/OEVR
				Rispetto dei tempi di ricontrollo nei focolai e negli stabilimenti Indenni	Valutazione dei tempi di controllo/ricontrollo	ASL	VETINFO SIGLA/OEVR
		BRUC BOV-BUF Mantenimento dello status di indenne nel triennio di riferimento nei territori Indenni.	VETINFO SIGLA/OEVR	Mantenimento della percentuale di copertura dei controlli sugli stabilimenti bovini /bufalini per BRC	100% controlli programmati, basati sull'analisi del rischio, sugli stabilimenti e sugli animali	ASL	VETINFO SIGLA/OEVR
				Rispetto dei tempi di ricontrollo negli stabilimenti Indenni	Valutazione dei tempi di controllo/ricontrollo	ASL	VETINFO SIGLA/OEVR
		BRUC OVI-CAPRINA riduzione della prevalenza media della BRC ovi-caprini del 10% nel triennio di riferimento	VETINFO SIGLA/OEVR	Mantenimento della percentuale di copertura dei controlli sulle aziende ovi-caprine per BRC	100% controlli programmati sulle aziende e sugli animali programmati	ASL	VETINFO SIGLA/OEVR
				Rispetto dei tempi di ricontrollo nei focolai e negli stabilimenti Indenni	Valutazione dei tempi di controllo/ricontrollo	ASL	VETINFO SIGLA/OEVR
		MTBC RIDUZIONE prevalenza media dellaTBC bovina-BUFALINA del 10% nel triennio di riferimento	VETINFO SIGLA/OEVR	Mantenimento della percentuale di copertura dei controlli sulle aziende BOV-BUF per TBC	100% controlli programmati sulle aziende e sugli animali programmati	ASL	VETINFO SIGLA/OEVR
				Rispetto dei tempi di ricontrollo nei focolai e negli stabilimenti Indenni	Valutazione dei tempi di controllo/ricontrollo	ASL	VETINFO SIGLA/OEVR
	Mantenere i requisiti per la qualifica di territorio ufficialmente indenne da LEB	Effettivo mantenimento della qualifica di indenne da LEB bovina e bufalina per le 5 Province	OERV	Mantenimento della percentuale di copertura dei controlli sulle aziende bovine e bufaline per LEB	Controllo basato sull'analisi del rischio	ASL	VETINFO SANAN

FONTE NORMATIVA	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE DI OUTCOME	FONTE DATI	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO	COMPETENZA DELL'OBIETTIVO	FONTE DATI
Piano triennale di Sviluppo e Riqualificazione del Sistema Sanitario Campano -Piano Nazionale di Prevenzione (P.N.P.) - Piano dei Controlli Nazionale Pluriennale (P.C.N.P.) 2023-2027 -Piano dei Controlli Regionale Pluriennale (P.C.R.P.) 2023-2027	Mantenimento di un elevato livello di protezione della salute degli animali	Individuazione precoce della presenza dei vettori (<i>Culicoides</i> spp), della circolazione virale e/o della presenza di animali viremici, secondo quanto disposto dal piano di sorveglianza predisposto dal Centro di referenza per le malattie esotiche.	OERV	Sorveglianza attiva delle malattie infettive animali trasmesse da vettori	90% n. campioni effettuati trimestralmente nelle aziende con animali sentinella / n. campioni programmati annualmente nelle aziende con sentinelle in tutte le province della Regione	ASL	VETINFO portale BlueTongue
		Riduzione della prevalenza dei sierotipi rilevanti di Salmonellosi riportati dalla normativa Comunitaria	OERV	Effettuazione dei controlli inerenti le malattie infettive animali zoonosiche	100% n° gruppi programmati nella categoria <i>OVAIOLE, BROILER, RIPRODUTTORI</i> da Piano Nazionale vigente	ASL	VETINFO Sistema informativo Salmonellosi
		Rafforzamento della biosicurezza per prevenire la diffusione di malattie infettive	OERV	Effettuazione dei controlli delle misure di biosicurezza per ridurre la diffusione delle malattie infettive animali, zoonosiche o meno	Effettuazione del 90% dei controlli programmati annualmente per i suini	ASL	GISA
					Effettuazione del 90% dei controlli programmati annualmente per i bovini-bufalini	ASL	GISA
		Raggiungimento qualifica ufficialmente indenne da malattia di Aujeszky	OERV	Acquisizione qualifica indenne	Effettuazione del 90% dei controlli programmati annualmente per l'attività B9	ASL	VETINFO SANAN
		Mantenimento qualifica ufficialmente indenne da malattia di Aujeszky	OERV	Mantenimento qualifica	Effettuazione del 90% dei controlli programmati annualmente per l'attività B9	ASL	VETINFO SANAN
		Migliorare le condizioni di benessere negli allevamenti	UOD 01	Miglioramento della formazione degli operatori del settore	Erogazione di almeno 1 corso all'anno	ASL	ORSA
				Miglioramento della formazione degli operatori del controllo ufficiale	Erogazione di almeno 1 corso all'anno	ASL	ORSA
			GISA	Riduzione del numero di non	Calcolo del numero di non	ASL	ORSA
		Contrasto al fenomeno dell'antibiotico-resistenza	ORSA	Valutazione dell'appropriatezza della prescrizione rispetto alla diagnosi	Estrazione dei dati sulle prescrizioni presenti sul sistema VETINFO e valutazione pluriennale	ASL	ORSA

FONTE NORMATIVA	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE DI OUTCOME	FONTE DATI	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO	COMPETENZA DELL'OBIETTIVO	FONTE DATI
Piano triennale di Sviluppo e Riqualificazione del Sistema Sanitario Campano -Piano Nazionale di Prevenzione (P.N.P.) - Piano dei Controlli Nazionale Pluriennale (P.C.N.P.) 2023-2027 -Piano dei Controlli Regionale Pluriennale (P.C.R.P.) 2023-2027	Ridurre l'impatto ambientale delle popolazioni di animali selvatiche e sinantropie mediante misure specifiche di contenimento di aspetti emergenziali	Attuazione di Piani di sorveglianza in popolazioni di animali selvatici	OERV/IUV	Effettuazione controlli sulla fauna selvatica	Effettuazione dei piani di Sorveglianza su animali selvatici rinvenuti vivi, deceduti e soggetti di attività venatoria per il monitoraggio almeno delle seguenti malattie infettive: Brucellosi, Tubercolosi, West Nile, Influenza aviaria, Rabbia, Aujeszky.	ASL	GISA/VAM
		Early detection su carcasse di suidi selvatici rinvenute per il monitoraggio della Peste Suina Africana (PSA)	OERV/IUV	Effettuazione controlli sulla fauna selvatica	Effettuazione dei piani di Sorveglianza sul 100% delle carcasse di cinghiale rinvenute annualmente.	CRIUV / ASL	GISA/VAM
		Erogazione di attività formativa alla popolazione target	ORSA/IUV	Formazione e informazione alla popolazione target sul corretto rapporto uomo/animale	Svolgimento di almeno 10 eventi/anno di comunicazione alla popolazione	ASL/CRIUV	GISA
		Effettuazione della sorveglianza nel 100% dei canili presenti sul territorio	ORSA/IUV	Effettuazione dei controlli inerenti l'igiene urbana veterinaria	Effettuazione di 1 controllo annuale per canile per la sorveglianza del benessere, dello stato infettivo e parassitologico, dell'anagrafe dei cani ospitati, della corretta gestione della struttura	ASL/CRIUV	GISA/VAM/BDU
		Monitoraggio delle cause di morte e delle patologie infettive, zoonotiche e non, e delle patologie legate all'ambiente.	ORSA/IUV	Effettuazione di diagnostica necroscopica	Effettuazione di almeno il 5% delle necroscopie su cani/gatti/sinantropi rinvenuti morti	ASL/CRIUV	VAM
		Miglioramento del benessere psicofisico in popolazione target	ORSA/IUV	Effettuazione dei programmi IAA	Implementazione dei programmi IAA rivolti a popolazione sensibile	CRIUV / ASL	GISA

CAPITOLO 2 - AUTORITÀ COMPETENTI E LABORATORI REGIONALI DI RIFERIMENTO

SEZIONE A - AUTORITÀ COMPETENTI ED ORGANISMI DI CONTROLLO

I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali contemplati dal presente Piano e previsti dal Reg. UE 2017/625, sono attuati dalle Autorità Competenti (A.C.). Nel campo della sicurezza alimentare l'art. 2 del D.Lgs. 193/07 e ssmmii, ha identificato il Ministero della Salute, le Regioni e le AA.SS.LL. quali A.C. a svolgere i controlli ufficiali. Ai sensi della normativa vigente e come ribadito nel P.C.N.P., i compiti e le responsabilità delle suddette A.C. sono estese anche ai settori di cui alle lettere a), c), d), e), f) e h) della sezione A dell'introduzione.

Nello specifico, il livello apicale dell'A.C., al quale spetta tra l'altro l'emanazione delle linee guida, è rappresentato dal Ministero della Salute che opera:

- a livello centrale con:
 - la Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione;
 - la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari;
- a livello territoriale con i propri uffici periferici, ovvero i PCF (PIF che comprendono gli USMAF), gli UVAC, nonché i CC NAS i quali, pur avendo strutture articolate a livello periferico, hanno competenza su tutto il territorio nazionale e operano soprattutto nell'ambito della repressione degli illeciti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.

Ai sensi dell'art.2 del D.Lvo 02 febbraio 2021 n. 27, e nell'ambito di rispettiva competenza, sono elencate le autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni.

Il livello regionale dell'A.C. è articolato nel seguente modo:

- Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – D.G. 04;
- Unità Operativa Dirigenziale “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” – U.O.D. 01 afferente alla D.G. 04 di cui sopra;
- Nucleo Regionale per i Controlli Ufficiali (Nu.Re.C.U.), istituito con DGRC N. 1957 del 16/11/2007;
- Direzione Generale Ambiente e Ecosistema e dalla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali sulla sanità delle piante;
- Centro di Riferimento Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV);
- Centro Riferimento per la Sicurezza Sanitaria del Pescato (CRISSAP);
- Centro di Riferimento Veterinario Emergenze Non Epidemiche (CERVENE);

- Centro di Riferimento sulla sicurezza alimentare della Ristorazione pubblica e collettiva e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (CRIPAT);
- Centro di Riferimento Regionale Sanità Animale (CRESAN);
- Centro di Riferimento Regionale sulla Biosicurezza, il Benessere Animale ed il Maltrattamento (CRiBBAM).

La descrizione dei ruoli e delle competenze dei Centri di riferimento è riportata nella sottostante Sezione A.1..

Per le attività di monitoraggio, programmazione e valutazione del rischio, l'A.C. regionale si avvale dei sottoelencati organismi regionali:

- Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare;
- Osservatorio Epidemiologico Regionale;
- Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario.

Il livello territoriale dell'A.C. si identifica con le strutture individuate dalle singole AA.SS.LL. confluenti nel Dipartimento di Prevenzione e competenti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, previste nell'art. 7 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i..

Le AA.SS.LL. in Regione Campania sono le seguenti:

- A.S.L. Avellino;
- A.S.L. Benevento;
- A.S.L. Caserta;
- A.S.L. Napoli 1 Centro;
- A.S.L. Napoli 2 Nord;
- A.S.L. Napoli 3 Sud;
- A.S.L. Salerno.

I rispettivi territori di competenza sono quelli stabiliti dalle Delibere di attuazione della L.R. 28/11/2008 n. 16 e dalla L.R. 4/2011.

SEZ. A.1. – POLO DIDATTICO INTEGRATO E CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALI

Con delibera di Giunta Regionale n. 867 del 14/12/2010 è stato istituito il “Polo Didattico Integrato per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di elevata complessità, la didattica e la ricerca finalizzata in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale”, di seguito denominato Polo Integrato. Gli Enti che costituiscono il Polo Didattico Integrato sono la Regione Campania, le AA.SS.LL., l'Università Federico II e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Il Polo Integrato ha come finalità, in ossequio al principio della coesistenzialità del sistema pubblico di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione, la realizzazione del *“Polo Integrato (P.I.) per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di elevata complessità, la didattica e la ricerca finalizzata in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale”* con i seguenti obiettivi:

- incremento della ricerca ed il collegamento tra la didattica e l'assistenza, secondo la legislazione universitaria e sanitaria;
- convergenza di competenze ed esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali di gruppi e/o di singoli operatori sanitari;
- aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli operatori sanitari di ogni livello, anche ai fini dell'assistenza sanitaria sempre più qualificata;
- ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali.

L'operatività del P.I. è assicurata dai Centri di Riferimento regionali in materia di Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria, allocati presso un'ASL capofila. Ad essi è attribuita la competenza a svolgere quelle attività ufficiali ad elevata complessità, cosiddette di II livello in tutto il territorio regionale. Essi sono anche d'ausilio per le attività svolte dalle AA.SS.LL. avvalendosi anche di personale dell'Università e dell'IZSM.

I Centri di Riferimento operanti in Campania sono:

- Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.)
- Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Sanitaria del Pescato (C.Ri.S.Sa.P.)
- Centro di Riferimento Regionale per la sicurezza della Ristorazione Pubblica e Collettiva e Prodotti Agroalimentari Tradizionali (C.RI.P.A.T.)
- Centro di Riferimento Regionale Sanità Animale (C.RE.S.AN.)
- Centro di Riferimento Regionale per le Emergenze Veterinarie non Epidemiche (CERVENE).
- Centro di Riferimento Regionale sulla Biosicurezza, il Benessere Animale ed il Maltrattamento (CRiBBAM).

Ce.R.VE.n.E. - Il Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche (CeRVEnE) è stato attivato presso l'ASL di Salerno, con DGRC n. 114 del 7 marzo 2017, allo scopo di creare un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno delle stesse ASL, finalizzato a fornire assistenza tecnico-scientifica nella redazione di piani di emergenza e relativi manuali operativi da rendere disponibili in caso di emergenze non

epidemiche, con specifico riferimento alla sanità e benessere animale e alla sicurezza alimentare, nonché promuovere la ripresa delle attività produttive in relazione ad eventi calamitosi (Business continuity planning).

Il quadro di riferimento normativo legato alle attività di previsione e prevenzione per la mitigazione dei rischi e per la gestione delle emergenze è costituito dai LEA (allegato B14), dal PNP e dal PRP. Nello specifico il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, inserisce anche il soccorso e la tutela degli animali tra le attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

In relazione alla sicurezza alimentare il CeRVEnE sostiene la formazione, la predisposizione di manuali e organizza simulazioni/esercitazioni sulla sicurezza alimentare nelle emergenze ambientali, nelle emergenze naturali (terremoto, esondazioni, incendi), nelle emergenze chimiche, radiologiche e nucleari, nelle emergenze bioterroristiche (Antrace, sabotaggio industriale) nella gestione delle cucine campali in situazioni di emergenza (tendopoli) e nelle attività nelle crisi internazionali sulla sicurezza alimentare (campi profughi, nei teatri di crisi politica/sociale/economica).

L'attività del CeRVEnE è rivolta non solo al personale delle AASSLL, dell'IZS, dell'Università ma anche ai volontari e agli operatori degli Enti locali impegnati nelle attività di Protezione civile.

Per mettere in qualità i processi decisionali in caso di emergenza (UCL), le procedure e i manuali operativi, il CeRVEnE supporta le AASSLL anche attraverso delle simulazioni interattive in loco su eventi calamitosi specifici per conformazione o particolari condizioni dei territori.

C.Ri.P.A.T. - Il Centro di Riferimento Regionale per la sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e delle produzioni agroalimentari tradizionali, istituito con DGRC n. 97 del 28.02.2017, rispettivamente presso le sedi operative della ASL Napoli 1 Centro e della ASL di Avellino, è una struttura che opera funzionalmente a supporto delle attività d'indirizzo e programmazione delle competenti strutture della Regione.

Il Centro si avvale della partecipazione dei Partner istituzionali Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e Università Federico II di Napoli - Dipartimento di Sanità Pubblica e Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali

Presso la ASL Napoli 1 Centro insiste la sede operativa "Ristorazione", articolata in tre Aree di Attività:

- Area "gestione degli aspetti nutrizionali "
- Area "gestione degli aspetti di sicurezza alimentare"
- Area "gestione degli aspetti di sicurezza alimentare dei novel food"
- Presso la ASL di Avellino è attiva la sede operativa "Prodotti Agroalimentari Tradizionali", articolata in due Aree di Attività:
 - Area "gestione del rischio delle filiere dei prodotti agroalimentari tradizionali",
 - Area "formazione, informazione e ricerca applicata".

- Entrambe le sedi operative perseguono i seguenti obiettivi:
- sviluppo di modelli di gestione del rischio nelle fasi di preparazione e somministrazione di alimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, e la messa a punto di strategie applicabili in tutte le Aziende Sanitarie regionali;
- supporto ai Servizi territoriali per le attività correlate alla sicurezza alimentare negli ambiti di specifico interesse;
- monitoraggio sull'applicazione da parte dei presidi territoriali delle strategie elaborate dal Centro stesso;
- ricerca scientifica applicata alla sicurezza alimentare ed a nuove tecnologie di produzione.

Per gli approfondimenti sulle attività del CRIPAT si rimanda alla DGRC n. 97 del 28.02.2017 e successiva DGRC n. 517 del 25.11.2020 di approvazione del protocollo d'intesa per la prosecuzione delle attività del Centro.

C.RE.S.AN. - Il Centro di riferimento Regionale per le malattie degli animali domestici (C.Re.San) è stato istituito con DGR Campania n. 859 del 29/12/2015, modificato con Protocollo d'Intesa (IN. 2019 0000014) del 09/08/2019 tra Regione Campania, Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ASL Salerno ed Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Esso è stato istituito al fine di perseguire in maniera più efficace ed efficiente gli obiettivi strategici regionali in materia di sanità animale attraverso:

- la ricerca, lo studio e l'approfondimento epidemiologico nella gestione delle malattie infettive e parassitarie degli animali comprese quelle ad andamento zoonotico
 - la gestione degli eventi emergenziali epidemici
 - la gestione sanitaria delle popolazioni animali problematiche vaganti ed inselvatichite
- Nello specifico il CRESAN cura l'approntamento e mette in atto procedure per:
- implementare i sistemi informativi regionali e delle relative banche dati in collaborazione con ORSA e OEVRG;
 - sviluppare nuovi modelli e tecnologie applicate al controllo delle malattie parassitarie ed infettive di interesse per la Sanità Pubblica Veterinaria;
 - supportare i Servizi territoriali delle ASSLL in occasione di eventi straordinari ed emergenziali;
 - promuovere ed analizzare nuove aree di sviluppo, anche organizzativo, in particolare nel campo delle emergenze epidemiche;
 - effettuare la ricerca applicata all'individuazione ed alla gestione dei pericoli correlati agli animali domestici in materia di sicurezza alimentare e di profilassi e gestione delle malattie infettive e parassitarie, comprese quelle trasmesse da vettori;
 - supportare i Servizi veterinari territoriali nella gestione sanitaria delle popolazioni animali problematiche;
 - formare, aggiornare ed informare il personale delle AA.SS.LL. addetto al controllo ufficiale sulle malattie infettive e parassitarie degli animali.

C.Ri.S.Sa.P. - Il Centro di Riferimento per la Sicurezza Sanitaria del Pescato (C.Ri.S.Sa.P.), istituito con delibera di Giunta Regionale n. 98 del 13/3/2015, è una struttura afferente al Polo Didattico Integrato, funzionalmente correlato alla competente struttura della Regione. Esso rappresenta il fulcro di un'azione sinergica e di raccordo tra Enti competenti sulla sicurezza sanitaria del pescato e sulla profilassi delle malattie delle specie ittiche, quali le AA.SS.LL., l'IZSM, il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e l'A.R.P.A.C., che svolge attività connesse al controllo sull'ambiente marino e delle acque interne.

Il Centro, attraverso attività di secondo livello, ordinariamente non svolte dalle AA.SS.LL., coordina le attività di controllo, diagnosi e ricerca attinenti le produzioni ittiche, promuove e valorizza le produzioni ittiche regionali e promuove la formazione degli operatori del controllo ufficiale e del settore produttivo ed all'informazione ai consumatori.

Le attività del C.Ri.S.Sa.P., che ha il Nucleo di coordinamento presso Regione e due sedi operative, rispettivamente presso l'ASL Salerno, con la direzione tecnica dell'Area "Pesca e piscicoltura", e presso l'ASL Napoli 2 Nord, con la direzione tecnica dell'Area "Molluschicoltura". Le relative attività sono svolte da personale delle AASSLL, dell'A.R.P.A.C., dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno del Mezzogiorno, dell'Università di Napoli Federico II e dell'A.R.P.A.C.

Il Nucleo di Coordinamento del C.Ri.S.Sa.P. è costituito da:

- Responsabile della U.O.D. regionale "Prevenzione e sanità pubblica veterinaria", o suo delegato, che lo presiede;
- Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Napoli Federico II, o suo delegato;
- due Direttori Tecnici delle sedi operative del C.Ri.S.Sa.P.;
- Direttore Tecnico dell'A.R.P.A.C.;
- Direttore Sanitario dell'IZS del Mezzogiorno.

L'attività del CRiSSaP in materia di pesca e piscicoltura, sia delle acque marine che interne, viene svolta prevalentemente presso la sede operativa individuata nell'A.S.L. di Salerno e consiste, in particolare, in:

- controllo su patologie delle specie ittiche selvatiche ed allevate;
- riconoscimento e gestione delle Zone/Aziende ai sensi del D.L.vo 148/2008;
- tutela ambientale delle aree di pesca (segnalazione aree con reti abbandonate, reste in plastica abbandonate sui fondali nelle aree di molluschicoltura, sviluppo della posidonia);
- controllo dei contaminanti microbiologici, chimici, biotossicologici in specie ittiche selvatiche;
- controllo e supporto per il soccorso, la raccolta, esami biologici e smaltimento di cetacei e tartarughe spiaggiati o morti;
- monitoraggi specifici sulla produzione primaria;
- supporto alle AASSLL per i controlli nelle fasi di commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici;
- controllo sui punti di sbarco;
- controllo sugli allevamenti di specie ittiche;

- diagnostica finalizzata alla profilassi delle malattie dei pesci;
- sviluppo di nuove tecnologie applicate alla filiera del settore della pesca e della piscicoltura tese a migliorarne le condizioni di sicurezza alimentare e di profilassi delle malattie dei pesci;
- controllo sul riconoscimento delle specie ittiche, alla luce dei continui rinvenimenti di specie atipiche potenzialmente tossiche o velenose che potrebbero essere immesse nella filiera alimentare;
- formazione, aggiornamento ed informazione del personale addetto al controllo ufficiale su tematiche inerenti la sicurezza alimentare del pescato e la profilassi delle malattie dei pesci;
- formazione ed informazione agli operatori del settore della pesca e della piscicoltura finalizzata alla sicurezza alimentare ed al controllo delle malattie dei pesci;
- educazione sanitaria ed informazione ai consumatori sulla corretta gestione ai fini alimentari del pescato.
- L'attività del CRISaP in materia di molluschicoltura viene svolta prevalentemente presso la sede operativa individuata nell'A.S.L. Napoli 2 Nord e consiste, in particolare, in:
 - individuazione, ai fini della classificazione, delle aree nelle quali crescono naturalmente specie di molluschi bivalvi e gasteropodi che possono essere oggetto di raccolta per la commercializzazione;
 - attività di monitoraggio periodico per la valutazione dei parametri biotossicologici, chimici, microbiologici sulle aree di produzione di molluschi bivalvi in concessione e sui banchi naturali di raccolta di molluschi bivalvi;
 - controllo sulle fioriture di plancton potenzialmente tossico nelle acque regionali;
 - controllo delle acque e dei molluschi in particolare in prossimità delle fonti di contaminazione accertate e attraverso campionamenti per rilevare impreviste ed improvvise condizioni di inquinamento che possono condizionare la sicurezza del pescato;
 - controllo per ricerca di eventuali fonti di contaminazione non accertate;
 - attività di vigilanza costante e interventi repressivi sulla presenza di attività di molluschicoltura e di raccolta in aree di produzione precluse;
 - controllo sui centri di spedizione di molluschi galleggianti;
 - supporto alle AA.SS.LL. nelle fasi di commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di molluschi bivalvi;
 - controllo sui punti di sbarco;
 - sviluppo di nuove tecnologie applicate alla filiera del settore della molluschicoltura tese a migliorarne le condizioni di sicurezza alimentare e profilassi delle malattie dei pesci;
 - formazione, aggiornamento ed informazione del personale addetto al controllo ufficiale su tematiche inerenti la sicurezza alimentare e la profilassi delle malattie dei molluschi;

- formazione ed informazione agli operatori del settore finalizzata alla sicurezza alimentare ed alle malattie dei molluschi;
- educazione sanitaria ed informazione ai consumatori sulla corretta gestione e sul consumo alimentare dei molluschi.

C.R.I.U.V. - La disomogeneità degli interventi in materia di IUUV sul territorio regionale ha determinato una condizione diversificata per cui si è reso necessario armonizzare i comportamenti e le azioni delle A.C. al fine di apportare correttivi e garantire il medesimo livello delle prestazioni erogate, in conformità ai Livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 17\1\2017. In tal senso la Giunta Regionale della Campania con la Delibera n. 1940 del 29.12.2009, ha istituito il Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) quale strumento operativo della Regione che attraverso l'U.O.D. 01 esercita funzioni di indirizzo, verifica e controllo.

Il CRIUV persegue le seguenti finalità:

- creazione di una rete di collaborazione tra le Aziende Sanitarie per la gestione delle popolazioni animali sinantropiche attraverso metodiche di contenimento delle stesse;
- approfondimento epidemiologico sulle realtà di tipo parassitario, infettivistico ed ambientale con particolare riferimento ai contaminanti, utilizzando tali popolazioni come sentinelle ambientali e, quindi, a salvaguardia della salute pubblica;
- realizzazione di una rete di referenti C.R.I.U.V. presso le AASSLL da dedicare alla mappatura delle aree oggetto di elevata frequenza di determinate patologie;
- erogazione delle Attività di II Livello Assistenziale in favore degli animali senza padrone, per rispondere al principio di uniformità ed economicità di spesa, avendo come riferimento una struttura centralizzata per attività cliniche e di diagnosi con attrezzature onerose e di difficile gestione in forma non associata;
- attivazione della rete di collaborazioni per la diagnostica cadaverica con l'allestimento di presidi presso le ASL per le indagini diagnostiche su animali vivi e necroscopiche su animali deceduti;
- attivazione della degenza sanitaria per volatili ed altri sinantropi al fine di approfondimenti di tipo epidemiologico;
- realizzazione di programmi di formazione ed informazione al personale medico e di comparto addetto alle linee di attività proprie del CRIUV (AASSLL, IZSM, Università);
- realizzazione di modelli operativi per l'erogazione di interventi assistiti con gli animali (IAA), anche attraverso gruppi misti di lavoro AASSLL/CRIUV.

Nella prima fase il CRIUV fornisce assistenza alle realtà territoriali più disagiate, ne incentiva la crescita e promuove forme temporanee di collaborazioni interaziendali con altre realtà più dotate, con l'obiettivo di uniformare i livelli prestazionali relativi alle attività di I Livello assistenziale che restano di esclusiva competenza dei Servizi veterinari territoriali:

Il CRIUV eroga le seguenti prestazioni di II livello per conto delle AASSLL che non sono in grado di erogarle in proprio:

- diagnostica e prestazioni clinico-chirurgiche di elevata complessità in regime di

ricovero per cani e gatti senza padrone, e nei seguenti casi:

- pronto soccorso;
- primo soccorso presso i canili pubblici;
- diagnostica necroscopica di particolare complessità, finalizzata all'acquisizione di conoscenze sulle cause di morte, sulla prevalenza di patologie di natura infettiva/zoonosica o di possibile origine ambientale, negli animali a vita sinantropica;
- realizzazione di programmi di formazione ed informazione di livello regionale per il personale medico e di comparto addetto alle linee di attività proprie del CRIUV (AASSLL, IZSM, Università);
- Il CRIUV è anche sede del Registro Tumori Animali (**RTA**) della Campania che opera in correlazione con il registro tumori animali nazionale, in correlazione con il centro nazionale di riferimento per l'oncologia veterinaria e comparata con sede presso la sezione di Genova dell'IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. L'RTA è strutturato per interfacciarsi con altre banche dati nazionali e regionali nonché con il Registro tumori umani. Sono fruitori ed alimentatori dell'RTA della Campania, oltre agli Enti costituenti il CRIUV (IZSM – Università) anche altri soggetti quali:
- AASSLL in particolare attraverso i reperti al macello;
- Veterinari LLPP attraverso i casi clinici nonché le relative diagnosi di laboratorio;
- laboratori diagnostici medico-veterinari.

I dati dell'RTA sono inseriti nei sistemi informativi regionali per le elaborazioni di natura epidemiologica a cura del centro di riferimento e dell'Osservatorio regionale. Infatti, a norma di legge, il RTA deve fornire informazioni epidemiologiche utili anche all'oncologia umana, ai sensi della legge regionale n. 9 del 25/02/2014 recante modifiche alla Legge Regionale n. 19/2012 "Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania".

CRI.B.BA.M. La Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 135 del 14.4.2021, ha istituito il Centro di Riferimento per la Biosicurezza, il Benessere Animale ed il Contrasto al Maltrattamento (C.RI.B.B.A.M.), rispettivamente presso le sedi operative dell'ASL di Caserta e dell'ASL di Benevento, al cui funzionamento contribuiscono a vario titolo l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) ed il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

La sede operativa di Caserta è articolata in due aree funzionali:

- Biosicurezza;
- Formazione ed informazione sulla biosicurezza.

La sede operativa di Benevento è articolata in tre aree funzionali:

- Benessere Animale;
- Prevenzione del maltrattamento e contrasto ai reati a danno degli animali;
- Attività di Formazione, informazione sul benessere ed il maltrattamento degli Animali.

SEZIONE B - LABORATORI REGIONALI DI RIFERIMENTO

In ottemperanza dell'art. 37 del Reg. UE 2017/625, i laboratori ufficiali di riferimento regionali cui inviare i campioni sono:

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno con le relative Sezioni provinciali;
- l'A.R.P.A.C. con le relative Sezioni provinciali.

I predetti laboratori effettuano presso le proprie sedi esclusivamente le analisi per le quali sono state completate le procedure di accreditamento ISO 17025, sia per il parametro richiesto che per la matrice campionata. Per tutti gli altri esami, i laboratori provvederanno ad inviare i campioni nell'ambito della rete di integrazione nazionale dei laboratori ufficiali tenendo presente l'elenco dei Laboratori Nazionali di Riferimento.

È compito della Regione verificare preventivamente la potenzialità dei laboratori e della rete in occasione della programmazione dei piani di monitoraggio e delle attività.

Al fine di privilegiare l'azione preventiva delle A.C. rispetto alla meno efficace azione repressiva che si sostanzia con la sola irrogazione di provvedimenti punitivi, è compito dei laboratori adeguare i tempi di analisi in modo che siano compatibili con la vita commerciale del prodotto. Solo in tal modo si ottiene un'efficace azione di tutela della salute che rappresenta la mission dell'intero SGCU.

SEZIONE C - MISURE DI COORDINAMENTO

L'integrazione dei controlli tra le varie Autorità, anche se circoscritti all'ambito della propria competenza, favorisce l'efficienza del sistema stesso dei controlli. Tenendo presente che questo principio deve essere poi tradotto a livello pratico, il presente P.C.R.P. è stato approntato per favorire ed attuare:

1. lo scambio di informazioni tra le varie Autorità;
2. l'esecuzione di controlli coordinati e/o congiunti tra le varie Autorità.

Per quanto riguarda il punto 1, il principale nodo di scambio di informazioni è rappresentato dal Punto di contatto del P.C.R.P. che costantemente riceve dalle varie Autorità le segnalazioni dei pericoli accertati nel territorio regionale e li pubblicizza dopo averne analizzato il rischio.

Un'ulteriore fonte di scambio di informazioni è il database fornito dal sistema informatico GISA, nel quale le Autorità in maniera volontaria, ad eccezione delle ASL per le quali è obbligatorio, immettono i dati dei loro controlli e consultano i dati dei controlli effettuati dalle altre Autorità.

Per quanto riguarda il punto 2, è necessario porre in essere meccanismi volti a garantire un efficace coordinamento tra le Autorità e favorirne la cooperazione. La prima fase dell'integrazione passa necessariamente per l'istituzione di tavoli tecnici speciali, riferiti a singole problematiche.

A livello regionale l'integrazione sull'intera sfera d'azione del P.C.R.P. è garantita da un **tavolo tecnico integrato**, il cui coordinamento è attribuito al Punto di contatto, ed al quale partecipano le Autorità e le Forze di polizia di cui alla precedente sezione 2.

Tra i compiti principali del tavolo vi sono l'identificazione delle problematiche più urgenti nonché la pianificazione di controlli coordinati necessari alla loro risoluzione.

La pianificazione deve identificare i criteri per la programmazione dei controlli congiunti che risulta necessaria al fine di evitare di ostacolare il normale svolgimento delle attività istituzionali già programmate da ciascuna delle Autorità coinvolte.

I Servizi dipartimentali delle AASSLL, per mandato, sono tenuti ad effettuare controlli ufficiali ed altre attività ufficiali previste dal Regolamento UE n. 2017/625 per il raggiungimento degli obiettivi regionali di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare, alcuni dei quali indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia al fine di assicurare ai cittadini Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.).

Le attività che sono tenute a svolgere le AASSLL per il raggiungimento degli obiettivi regionali sono incluse nel documento di programmazione annuale regionale (D.P.A.R.), che ciascuna di esse deve rimodulare a livello territoriale nel documento di programmazione annuale territoriale (D.P.A.T.).

È prevista la massima integrazione dei controlli tra i SIAN ed i Servizi Veterinari, i quali dovranno operare congiuntamente nell'ambito di attività che ne prevedano la competenza di entrambi, come nel caso di controlli nei casi di MTA.

Interventi congiunti con forze dell'ordine o con altre autorità nel settore della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria, in assenza di espressa delega dell'Autorità Giudiziaria, come confermato dallo stesso Ministero della Salute con nota n. 002513-P del 30/01/2012, devono essere subordinati ad una programmazione condivisa a livello regionale o, su direttive di quest'ultimo, a livello locale per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi regionali.

Pertanto, interventi effettuati dalle AASSLL su richiesta estemporanea o occasionale di altri organi di controllo, non oggetto di una programmazione preventiva e non effettuati su delega dell'Autorità Giudiziaria, saranno presi in considerazione previa valutazione regionale.

SEZIONE D – FORMAZIONE

In linea generale, tutti coloro cui è demandato il compito di svolgere controlli devono essere obbligatoriamente formati e aggiornati. Per quanto riguarda nello specifico le A.C., tale obbligo è stabilito dall'art. 5 punto 4 del Reg. UE 2017/625 e dall'Accordo Stato-Regioni n. 46 del 7.2.13 i quali stabiliscono che l'A.C. deve assicurare che il personale addetto ai controlli ufficiali:

- riceva una formazione adeguata,
- sia regolarmente aggiornato,
- mantenga nel tempo una adeguata qualificazione per le attività di audit,
- abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare.

Deve essere cura dell'AC regionale e territoriale assicurare, per quanto di competenza, che il personale addetto ai controlli ufficiali a loro afferente sia fornito delle quattro succitate prerogative.

La formazione professionale per il personale addetto ai controlli ufficiali assume un ruolo essenziale per una coerente integrazione delle professionalità e per favorire l'ottimizzazione delle risorse umane. I percorsi e le azioni formative, sia a livello regionale che territoriale, vanno quindi necessariamente elaborati in coerenza con gli obiettivi nazionali, regionali e locali e si fondano su adeguate analisi relative al bisogno formativo delle diverse figure professionali.

La formazione professionale per il personale addetto ai controlli ufficiali deve essere svolta tenendo conto delle tematiche elencate nell'allegato II Capo I del Reg UE 2017/625. Come stabilito dal Cap. 2 dell'Accordo Stato-Regioni n. 46 del 7.2.13, la formazione e l'addestramento del personale afferente alle A.C. è suddiviso in tre percorsi formativi.

Pertanto, spetta alle A.C.:

- organizzare direttamente corsi per la formazione e l'addestramento del personale che effettua controlli ufficiali, oppure
- fare in modo che il proprio personale partecipi a corsi per la formazione e l'addestramento;
- mantenere aggiornato nell'organigramma riportato nel DPAT la qualifica raggiunta da ogni funzionario come prevista dal Cap. 2 dell'Accordo Stato-Regioni n. 46 del 7.2.13.

La Regione organizza corsi per la formazione e l'addestramento del personale sia delle A.C. regionali che territoriali, redigendo un piano formativo annuale sulla base delle esigenze emerse in occasione delle attività di controllo, ovvero derivanti da nuove normative o procedure.

Per garantire l'uniformità del livello formativo, le A.C. territoriali e/o la Regione possono organizzare specifici corsi avvalendosi della collaborazione dei Centri di Riferimento Regionali che operano nell'ambito del Polo Integrato.

CAPITOLO 3 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI **CONTROLLI UFFICIALI**

Al fine di procedere ad una corretta organizzazione e gestione dei controlli ufficiali, è necessario procedere preliminarmente ad un'identificazione dei campi di competenza del presente Piano. L'insieme di tali campi è suddiviso in Macroaree e Settori.

È necessario inoltre identificare i criteri per la programmazione dei controlli tra i quali la categorizzazione di rischio degli stabilimenti ed i carichi di lavoro.

SEZIONE A - MACROAREE E SETTORI

Pur rispettando l'architettura del P.C.N.P., è necessario a livello regionale applicare un'articolazione più specifica e dettagliata che rappresenti meglio la realtà e gli obiettivi regionali prevedendo la classificazione delle attività soggette a controllo in macroaree e settori. Tale elenco funge anche quale *"audit universe"*, cioè definisce le tematiche oggetto degli audit interni di settore ex art. 6 del Reg UE 2017/625.

Si riporta di seguito l'elenco e la descrizione:

MACROAREE								
	Alimenti	Sanità Animale	Alimentazione Animale	Benessere animale	Sanità delle piante	M.S.R., S.O.A. e P.D.	Farmaci Veterinari	Altro
SETTORI	1. Sicurezza degli alimenti di O.A.	10. Anagrafe	13. Mangimi	14. benessere Animale	17. Organismi nocivi delle piante	19. S.O.A. e P.D.	21. Farmaco vigilanza	23. Zoonosi nell'uomo e M.T.A.
	2. Sicurezza degli alimenti NON di O.A. ed Ispettorati Micologici	11. Malattie infettive		15. Sperimentazione animale	18. Fitosanitari	20. M.S.R.	22. Farmaco sorveglianza	24. Ambiente
	3. Qualità merceologica	12. Riproduzione animale		16. Interventi assistiti con gli animali				25. Igiene urbana veterinaria e lotta al randagismo
	4. Produzioni Agroalimentari Regolamentate							26. Sistema rapido d'allerta
	5. Produzione biologiche							27. OGM
	6. Acque Potabili e Minerali							
	7. Nutrizione umana							
	8. FSG							
	9.MOCA							

SEZIONE B - MACROAREA ALIMENTI E SICUREZZA ALIMENTARE

SETTORI 1 e 2: SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, DEGLI ALIMENTI NON DI ORIGINE ANIMALE ED ISPETTORATI MICOLOGICI

Ai sensi del Reg. CE 178/02, è sull'OSA (definizione ripresa dal Regolamento di Esecuzione UE 2019/627) che ricade la responsabilità legale della sicurezza degli alimenti ed in generale di tutto ciò che accade nel proprio stabilimento.

Alle A.C. spetta invece il compito di:

- verificare il rispetto della normativa da parte dell'OSA;
- valutare l'efficacia delle procedure adottate dall'OSA;
- accertare eventuali non conformità.
- adottare le misure consequenziali all'accertamento della non conformità

La competenza della materia è attribuita alle A.C. regionali, alle AA.SS.LL., al CRIPAT, al CRISSAP ed ai CC NAS quali organo operativo del Ministro della Salute.

Il presente P.C.R.P. intende, tra l'altro, favorire l'esecuzione di controlli congiunti tra le varie A.C., e tra queste e le altre Autorità e Forze di Polizia che effettuano controlli collaterali in materia di sicurezza alimentare. Particolare attenzione deve essere posta all'integrazione tra i Servizi Medici ed i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. in modo da garantire una visione completa degli aspetti che definiscono il rischio di uno stabilimento. Infatti, il vigente contesto normativo e le esigenze di natura commerciale, rendono assolutamente anacronistica una distinzione netta degli stabilimenti in due categorie, cioè quelle soggette al controllo esclusivo dei Servizi Medici e quelle soggette al controllo esclusivo dei Servizi Veterinari.

Tale visione non comporta una *diminutio* delle rispettive competenze, che vengono mantenute inalterate, ma tende a incrementare l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli ufficiali, nell'ottica di una ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili. Tale impostazione ha lo scopo di promuovere l'integrazione tra le varie A.C. in modo da evitare sovrapposizioni di controlli, evenienza che crea disorientamento sia agli operatori dei settori oggetto di controllo, che nella stessa pubblica opinione.

Si ritiene utile riportare uno schema sull'attribuzione delle competenze nell'esecuzione dei controlli ufficiali:

	COMPETENZA DEI SERVIZI MEDICI	COMPETENZA DEI SERVIZI VETERINARI
Igiene degli alimenti <u>non</u> di origine animale	X	
Igiene degli alimenti di origine animale e degli alimenti a base di prodotti di origine animale *		X
Approvvigionamento idrico	X	
Rifiuti ed oli esausti	X	
M.S.R., S.O.A. e P.D.		X
Fumi	X	
Igiene del personale	X	X
Requisiti igienici dei locali e/o attrezzature	X	X
Autocontrollo	X	X
Tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura degli alimenti <u>non</u> di origine animale	X	
Tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura degli alimenti di origine animale		X
Materiali a contatto alimenti	X	X
Ispettorato micologico	X	
Documentazione	X	X

*per alimenti di origine animale ed alimenti a base di prodotti di origine animale, si intendono gli alimenti di cui al Reg. CE 853/04 e quelli che, comunque, contengono alimenti di origine animale oltre il **20 % del loro peso o volume** e quelli in cui un alimento di origine animale **rappresenta l'ingrediente caratterizzante del prodotto alimentare**

Tale schema è valido per tutte le categorie settoriali di impresa, dalla produzione primaria alla trasformazione, alla commercializzazione, alla somministrazione, al trasporto.

Ispettorati Micologici

Gli Ispettorati Micologici, istituiti presso i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL svolgono attività di controllo micologico mirato all'identificazione delle specie fungine consumate e commercializzate al fine di ridurre l'incidenza delle intossicazioni alimentari per l'avvelenamento da funghi non commestibili o velenosi.

L'attività di prevenzione dalle intossicazioni da funghi consiste nel verificare l'edibilità dei funghi freschi spontanei raccolti da privati cittadini, raccoglitori o consumatori, e nel garantire la commestibilità e l'idoneità al consumo dei funghi spontanei, freschi, secchi e conservati destinati alla commercializzazione ed alla somministrazione. L'edibilità dei funghi è correlata all'identificazione di specie, la cui determinazione consente di esprimere il giudizio di

commestibilità o tossicità, nonché allo stato di conservazione e quindi all'aspetto igienico sanitario dei funghi, in quanto alimento. La Giunta regionale con deliberazione n.587/2018 ha istituito la Rete Regionale degli Ispettorati Micologici già attivi presso i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL, le cui funzioni trovano fonte normativa nella Legge n 352/1993 e nella Legge regionale n. 8/2007. Obiettivo della Rete è rafforzare l'attività di prevenzione attraverso una connessione funzionale ed efficace secondo il modello HUB/SPOKE, con un laboratorio di riferimento, che l'atto normativo regionale ha ubicato presso la ASL di Benevento, nodo centrale della Rete, in grado di garantire indagini di secondo livello per la necessaria consulenza ospedaliera nei casi di intossicazione e per il supporto tecnico scientifico agli SPOKE, che svolgono le attività previste integrandosi e relazionandosi con l'HUB.Attività svolte dagli SPOKE, secondo specifiche procedure operative:

- assistenza gratuita ai cittadini raccoglitori per il controllo, riconoscimento e determinazione dei funghi (esame di commestibilità);
- consulenza ad ospedali e strutture di emergenza in occasione di presunti casi di intossicazione;
- controllo, con relativa certificazione, dei funghi spontanei freschi destinati alla vendita presso mercati ortofrutticoli, esercizi di vendita e ristoranti;
- rilascio dell'attestazione di idoneità per l'identificazione delle specie fungine agli esercenti che intendono vendere funghi spontanei freschi allo stato sfuso;
- controllo alla importazione dei funghi.

Tali attività sono svolte da micologi in possesso di specifico attestato di formazione.

Attività svolte dagli HUB:

- supporto tecnico scientifico agli SPOKE di Rete;
- indagini di secondo livello per la consulenza ospedaliera in caso di intossicazione da funghi;
- elaborazione protocollo di intesa con strutture ospedaliere;
- monitoraggio dell'andamento epidemiologico delle intossicazioni da funghi;
- attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati Micologici;
- promozione dello studio della micologia anche attraverso forme di collaborazione con altri enti, quali le associazioni micologiche e l'ISPRA per la mappatura sul territorio delle specie fungine.

SETTORI 3, 4 e 5 – QUALITÀ MERCEOLOGICA DEGLI ALIMENTI, PRODUZIONI AGROALIMENTARI REGOLAMENTATE E PRODUZIONI BIOLOGICHE

L'ICQRF del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste è individuato quale Autorità Competente ad eseguire controlli ufficiali sugli aspetti merceologici degli alimenti in genere e delle produzioni agroalimentari regolamentate e delle produzioni biologiche.

Sono individuati inoltre Organismi di Controllo (O.d.C.) autorizzati che operano, in agricoltura biologica e sui consorzi di tutela, per la verifica della corretta applicazione delle procedure e delle certificazioni approvate dal MASAF.

Le produzioni agroalimentari regolamentate individuate nel Reg. UE n. 1151/2012 includono:

- i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP);
- i prodotti con indicazioni geografica protetta (IGP);
- le specialità tradizionali garantite (STG)

Altra categoria di prodotti agroalimentari regolamentati dal Reg. CE n. 2074/2005 sono i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT).

Tutti gli aspetti inerenti la sicurezza alimentare sono di competenza del Ministero della Salute e delle sue articolazioni territoriali (Assessorato Regionale alla Sanità, anche attraverso i propri Centri di Riferimento ed i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.).

Il Sistema di Gestione Integrato dei Controlli, richiamato nel presente P.C.R.P., prevede la collaborazione delle Autorità Competenti coinvolte, per la gestione dei rispettivi aspetti di pertinenza.

SETTORE 6 – ACQUE POTABILI E MINERALI

Il controllo igienico-sanitario delle acque destinate al consumo umano nonché di quelle minerali riveste grande interesse nell'ambito della sanità pubblica, ai fini della prevenzione per patologie, acute e croniche, derivanti da situazioni di non conformità chimica, fisica o microbiologica dell'acqua. Il controllo è fondamentale, soprattutto in considerazione del numero elevato di persone esposte, delle modalità e del tempo d'esposizione, della velocità con cui l'acqua potrebbe veicolare inquinanti fisici, chimici, virus e batteri patogeni. Le Autorità Competenti all'esecuzione dei controlli in materia di acque potabili e minerali sono i SIAN ed i SISP delle AA.SS.LL. nonché i CC NAS. I controlli vengono svolti sia nei punti di prelievo per le acque di rete sia negli stabilimenti che producono alimenti.

SETTORE 7 – NUTRIZIONE UMANA

Nell'ambito della nutrizione, le A.C. sono i S.I.A.N. i quali per l'Area funzionale igiene della nutrizione svolgono compiti di:

1. **SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE:** Sorveglianza nutrizionale: raccolta mirata di dati epidemiologici (mortalità, morbosa), consumi ed abitudini alimentari, rilievi dello stato nutrizionale per gruppi di popolazione.

2. **EDUCAZIONE ALIMENTARE:** Interventi di prevenzione nutrizionale per la diffusione delle conoscenze di stili alimentari corretti e protettivi alla popolazione generale e per gruppi di popolazione (genitori, insegnanti, alimentaristi, infanzia ed età evolutiva, anziani e altre specificità) con l'utilizzo di tecniche e strumenti propri dell'informazione e dell'educazione sanitaria. Consulenza per l'aggiornamento in tema nutrizionale per il personale delle strutture di ristorazione pubbliche e private (scuola, attività socio-assistenziali, assistenza domiciliare, mense aziendali, ecc.) compreso gli interventi di informazione-formazione per gli operatori della ristorazione collettiva su aspetti di sicurezza nutrizionale in relazione anche ad esigenze dietetiche.
3. **NUTRIZIONE COLLETTIVA:** Interventi Nutrizionali per la ristorazione collettiva quali predisposizione, verifica e controllo sulle tabelle dietetiche, indagini sulla qualità nutrizionale dei pasti forniti e consulenza sui capitolati per i servizi di ristorazione con l'apporto tecnico degli altri Servizi ed Unità Operative di competenza (Servizi Veterinari, U.O. Igiene Alimenti e Bevande); Controllo della ristorazione collettiva, anche sulla base delle linee guida nazionali e Regionali (ristorazione scolastica), con attenzione alla ristorazione in strutture sanitarie;
4. **DIETETICA PREVENTIVA:** Interventi di prevenzione nutrizionale per la diffusione delle conoscenze di stili alimentari corretti e protettivi alla popolazione generale e per gruppi di popolazione (genitori, insegnanti, alimentaristi, infanzia ed età evolutiva, anziani, e altre specificità) con l'utilizzo di tecniche e strumenti propri dell'informazione e dell'educazione sanitaria. Consulenza dietetico - nutrizionale e counselling rivolta a gruppi a rischio, alle comunità, ed in particolare nella formazione degli operatori finalizzata alla motivazione al cambiamento verso stili di vita sani, la prevenzione di sovrappeso, obesità e malattie croniche;

Al fine del raggiungimento di tali obiettivi sarà necessario prevedere:

- A. rapporti di collaborazione e consulenza con strutture specialistiche (es. Pediatri Libera Scelta e Medici Medicina Generale);
- B. Elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario e tecnico afferente all'area della nutrizione.

Per il miglioramento delle attività nel settore, si perseguiranno i seguenti obiettivi:

- Integrazione con altri settori per la rilevazione dati sullo stato nutrizionale, sugli stili di vita della popolazione;
- Divulgazione dei risultati delle rilevazioni e delle altre attività svolte in ambito di sorveglianza nutrizionale.

SETTORE 8 e 9 – FSG E MOCA

Le Autorità Competenti all'esecuzione dei controlli in materia di FSG e MOCA sono i SIAN ed i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. nonché i CC NAS.

La produzione di FSG prevede un apposito riconoscimento dello stabilimento da ottenere secondo le procedure dettate dalla D.G.R.C. 318/15 e s.m.i.

SEZIONE C - MACROAREA SALUTE ANIMALE
SETTORE 10 – ANAGRAFE - SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E

REGISTRAZIONE: I&R

Il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorità competenti alla programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali in materia di sistema I&R, nonché all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, e all'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.

Il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del Reg. (UE) 2016/429, ed è responsabile del coordinamento delle altre autorità competenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali in attuazione delle disposizioni in materia di sistema I&R in conformità al regolamento, ai suoi atti delegati e di esecuzione, nonché al regolamento (UE) n. 2017/625, e al D.lgs n.134/2022.

Nell'attuazione delle norme di cui al Reg. (UE) 2016/429 e al D.lgs n.134/2022 è fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dall'articolo 2, commi 8, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

Attualmente è previsto un sistema di identificazione gli animali appartenenti alle seguenti specie:

- Bovini;
- Ovini;
- Caprini;
- Suini;
- Cinghiali allevati;
- Equini;
- Camelidi;
- Cervidi;
- Cani, gatti e furetti;
- Volatili in cattività;
- Animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali

I controlli vengono svolti sia negli stabilimenti zootecnici che di macellazione, sugli operatori e sui trasportatori, negli stabilimenti che detengono animali da compagnia di cui all'allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, inclusi i centri di raccolta per cani, gatti e furetti, i rifugi per animali, sia da compagnia che di altra tipologia, le collezioni faunistiche di qualsiasi tipo, inclusi i giardini zoologici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, i circhi e le esibizioni di animali, sia itineranti che a sede fissa, i posti di controllo, gli stabilimenti con status confinato, gli stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale, gli stabilimenti di materiale germinale, gli

stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente.

Per i controlli negli stabilimenti zootecnici, il Ministero della Salute ha approntato apposite check list ad uso dei Servizi Veterinari che devono essere conservate agli atti per almeno tre anni.

I dati dei controlli di identificazione e registrazione, le check list devono essere inseriti nella Banca Dati Nazionale.

E' compito dei Servizi Veterinari verificare la correttezza dei dati riguardanti gli stabilimenti presenti in BDN; tale verifica è un'attività fondamentale per poter dimostrare corrispondenza tra i dati inseriti nella BDN e il lavoro di campionamento svolto negli stabilimenti.

La frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali negli stabilimenti che detengono bovini, ovini e caprini, effettuati dall'autorità competente, in particolare ispezioni, sull'identificazione e sulla registrazione di bovini, ovini e caprini ogni anno civile in almeno il 3 % degli stabilimenti presenti nel suo territorio che detengono tali animali, sono determinate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/160 della commissione del 4 febbraio 2022.

Banca Dati Apistica Regionale

Nel sistema GISA è stata istituita la Banca Dati Apistica Regionale, che, ai sensi del D.D. n. 230 del 14/07/2015 (BURC n. 45 del 20/07/2015) rappresenta il nodo regionale di riferimento per la Banca Dati Apistica Nazionale. La B.D.A.R. viene implementata anche per soddisfare le attività previste dalla Legge Regionale n. 7 del 29 marzo 2006 "Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura"

SETTORE 11 –MALATTIE INFETTIVE

La competenza in materia di controlli sulle malattie infettive degli animali è di esclusiva competenza dei Servizi Veterinari delle ASL e del Centro di Riferimento Regionale Sanità Animale (CRESAN).

SISTEMI INFORMATICI DEI CONTROLLI DELLE MALATTIE INFETTIVE ANIMALI

Il sistema dei controlli delle malattie infettive animali si avvale di sistemi informativi nazionali che, in attesa della possibilità di scambio dati in cooperazione applicativa, talora sostituiscono il sistema regionale GISA. Tali sistemi sono il SIMAN ed il SANAN.

Il SIMAN viene utilizzato per la notifica dei focolai di malattie infettive animali soggette a denuncia e prevede l'inserimento dei dati epidemiologici relativi all'insorgenza degli stessi da parte dei Servizi Veterinari (S.V.) delle AA.SS.LL. Esso prevede l'identificazione di due tipi di focolaio:

- *focolaio primario*: focolaio epidemiologicamente non correlato con nessun altro focolaio situato all'interno della stessa provincia. In tal caso la notifica deve essere inviata entro le 24 ore dall'evento;
- *focolaio secondario*: focolaio epidemiologicamente correlato con un altro situato

nella stessa provincia. In tal caso la notifica deve essere inviata entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana.

- il SIMAN consente di inserire anche i casi sospetti di malattie infettive per i quali è prevista o la conferma del focolaio o l'eliminazione del sospetto in seguito alle indagini specifiche.

Il SANAN consente la registrazione dei dati concernenti tutte le attività di profilassi svolte dai S.V. delle AA.SS.LL. Con l'O.M. 2015 e sue ssmmii è stato reso obbligatorio l'utilizzo del SANAN in tutto il territorio nazionale per la registrazione dei dati inerenti le attività di controllo delle malattie animali, al fine di rendere più efficace il flusso informativo e per meglio monitorare le attività territoriali.

Con Nota MINSAL del 10 agosto 2015, il suddetto sistema informativo deve essere altresì implementato, sempre da parte dei S.V., per tutte le attività inerenti alle vaccinazioni (effettuate dal 1° agosto 2015) nei confronti della Blue Tongue.

Con la DGRC n.104/2022, viene riconosciuto l'obbligo di inserimento in SANAN delle vaccinazioni per Brucellosi con vaccino RB51.

Il sistema sarà, altresì, ampliato con la sezione "autocontrollo", utilizzabile dai veterinari Aziendali, per la richiesta di esami su determinate matrici biologiche.

Si riportano di seguito alcune sintetiche indicazioni delle principali malattie infettive animali di interesse regionale:

TUBERCOLOSI BOVINA/BUFALINA

Malattia batterica causata da *Mycobacterium bovis* e *Mycobacterium caprae*, colpisce l'uomo e gli animali e si presenta con decorso per lo più cronico depauperante, è caratterizzata da processi produttivi di tipo granulomatoso con formazione di noduli (tubercoli) e di processi essudativi. La malattia è ancora presente in alcune zone della Campania, dove risulta di difficile eradicazione per le caratteristiche intrinseche del microorganismo in termini di resistenza all'ambiente esterno e per la tipologia di allevamento improntato alla monticazione e transumanza.

La TBC è classificata come malattia di categoria BDE secondo la classificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della commissione del 3 dicembre 2018 e viene considerata come patologia con effetti socio-economici e di salute pubblica di notevole rilevanza e con impatto potenzialmente significativo nei confronti del commercio internazionale di animali e prodotti animali.

Negli ultimi anni, grazie agli interventi normativi, l'attività di formazione sul campo e l'implementazione di sistemi atti alla verifica puntuale dell'attività svolta sul territorio, si è assistito ad un miglioramento della situazione epidemiologica con riduzione del numero di focolai.

Il serbatoio epidemiologico è il bovino ed è considerato l'ospite naturale e serbatoio principale della malattia; tuttavia, è dimostrato che alcune specie selvatiche possono fungere da reservoir per *M. bovis*/*M. caprae*. In particolare, il tasso, il cinghiale (*Hardstaff et al. 2014, Res. Vet. Sci. 97: S86-S93*) e il cervo (*Fink et al. 2015, Emerg. Inf. Disease 21: 464-467*).

In Italia cervo e cinghiale sono stati descritti con il ruolo di spill over "ospiti accidentali" di *M.*

bovis (Serraino et al. 1999. *J. Clin. Microbiol.* 37: 2766-2771; Chiari et al. 2016) con trasmissione da bovini infetti.

Programma di eradicazione e Azioni di controllo

Nell'anno 2022 è stato elaborato un programma di Eradicazione per la Tubercolosi bovina e bufalina, presentato alla Commissione europea per l'approvazione ed il cofinanziamento, che prevede l'esecuzione di controlli negli allevamenti di bovini e bufalini, annuali per i territori non indenni, con cadenze diverse per i territori indenni; viene inoltre effettuata l'ispezione presso gli impianti di macellazione.

Con l'emanazione del "Programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina in Regione Campania " (DGR n.104 dell' 08/03/2022) che prevede ulteriori misure straordinarie da applicare in alcune zone denominate "aree cluster d'infezione", sono state introdotte procedure maggiormente efficaci per l'eradicazione della tubercolosi bufalina che prevedono l'utilizzo del gamma/interferone come prova non più di conferma, per l'eradicazione al fine di ottimizzare le procedure e velocizzare i tempi di eradicazione, in ottemperanza al Reg. Del. (UE) 2020/689.

Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso:

- Verifica della corretta iscrizione nella BDN di tutte gli stabilimenti e di tutti i capi in essi presenti
- Identificazione elettronica di tutto il patrimonio bufalino
- Realizzazione della banca genetica regionale della specie bufalina
- Controllo delle movimentazioni
- Controllo annuale del 100% della popolazione bufalina controllabile e rispetto della periodicità dei controlli così come previsto dalla normativa vigente
- Registrazione nel S.I. SANAN di tutte le operazioni di profilassi e relativo aggiornamento della qualifica sanitaria degli stabilimenti
- Abbattimento dei capi infetti entro i termini previsti, dalla notifica di positività, differenziati in base allo status del territorio
- Inserimento dei casi sospetti e/o confermati di malattia nel S.I. SIMAN
- Attuazione di un sistema di vigilanza idoneo a garantire l'esclusione dal consumo umano del latte di animali infetti
- Attività di monitoraggio trimestrale e semestrale, attraverso la costituzione di nuclei di monitoraggio, co-partecipati dal Ministero della Salute e dai Centri di Riferimento Nazionali.

Normativa regionale:

- Delibera Della Giunta Regionale N° 104 Del 08/03/2022: "Programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina in Regione Campania", e ssmmi che sostituiscono integralmente la deliberazione della Giunta regionale n. 207/2019 ed include, opportunamente modificate, le istruzioni operative per le profilassi di Stato, fornite alle AASSLL. Alle AASSLL sono fornite, con decreto Dirigenziale gli elenchi rimodulati degli stabilimenti ricadenti in aree cluster, con

cadenza almeno semestrale. Il suddetto programma prevede oltre ad alcune misure straordinarie per il contenimento e l'eradicazione delle malattie soggette a profilassi di stato, i requisiti minimi di biosicurezza aziendale ed ambientale degli stabilimenti bovini ai fini del ripopolamento in seguito ad abbattimento totale.

<https://www.oevcampania.it/index.php/2022/03/10/dgrc-104-2022-approvazione-del-programma-obbligatorio-di-eradicazione-delle-malattie-infettive-delle-specie-bovina-e-bufalina-in-regione-campania/>

Procedure documentate regionali:

- procedura documentata dell'attività obbligatoria AO5, il cui scopo è l'organizzazione delle attività di monitoraggio e la standardizzazione delle procedure operative relative al controllo negli stabilimenti di macellazione nei confronti della brucellosi e della tubercolosi in regione Campania.
- L'attività di monitoraggio, oltre a consentire la raccolta di informazioni circa l'eventuale presenza di Mycobacterium Tuberculosis complex (MTBC) e Brucella spp. (BRC) in Regione Campania, ha l'obiettivo di rilevare quanto prima l'eventuale introduzione della malattia nei territori attualmente indenni al fine di adottare adeguate misure di gestione del rischio, nonché quello di definire l'andamento epidemiologico nei territori Non Indenni.
- PROCEDURA PIANO B2, riguardante l'attività di controllo ufficiale ai fini del rilascio del nulla osta al ripopolamento degli stabilimenti dopo stamping out, il cui scopo è l'organizzazione e la standardizzazione delle attività previste per la riapertura ed il ripopolamento degli stabilimenti sottoposti a provvedimenti di abbattimento totale (Stamping-out) nei confronti della brucellosi e della tubercolosi in regione Campania.
- PROCEDURA PIANO A1 relativa all'eradicazione della TBC, BRC e LEB nei bovini e bufalini, il cui scopo è scopo è l'organizzazione delle attività di monitoraggio e la standardizzazione delle procedure operative relative al controllo degli stabilimenti zootecnici nei confronti della brucellosi e della tubercolosi in regione Campania.

Normativa Comunitaria:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della commissione del 3 dicembre 2018
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della commissione del 17 dicembre 2019
- Regolamento D(UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016

Normativa Comunitaria:

- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136

BRUCELLOSI BOVINA E OVI-CAPRINA (BRC)

La Brucellosi è una malattia causata da un batterio Gram negativo, molto piccolo, immobile, privo di capsula. Il genere *Brucella* comprende sei specie classiche, nell'ambito delle quali sono riconosciuti diversi biotipi: *B. abortus*, *B. melitensis*, *B. suis*, *B. canis*, *B. ovis* e *B. neotomae*. Le specie *B. abortus*, *B. melitensis*, *B. suis* e *B. neotomae* sono in fase liscia (S, smooth), mentre *B. canis* e *B. ovis* sono in fase rugosa (R, rough).

Negli allevamenti di animali domestici l'infezione entra di solito con l'introduzione di soggetti infetti che diffondono la malattia velocemente attraverso aborti, espulsione di placenta ed escreti contaminati. Raramente l'infezione si trasmette per via venerea in quanto il seme utilizzato in fecondazione artificiale è sottoposto a rigorosi controlli, mentre è possibile in caso si impieghi ancora la monta naturale.

Un importante fattore di rischio per il diffondersi dell'infezione è la promiscuità; la condivisione degli stessi pascoli all'aperto per lunghi periodi facilita la trasmissione dell'infezione da allevamenti infetti ad allevamenti sani attraverso la contaminazione ambientale dovuta a feti abortiti, placente, lochiazioni, essudati e secrezioni utero-vaginali dei soggetti infetti. L'infezione dopo la prima fase acuta in cui causa elevate proporzioni di aborti negli animali gravidi, può diventare endemica con manifestazioni cliniche meno eclatanti, con aborti sporadici e calo di fertilità generale, ma con la costante presenza di animali infetti ed eliminatori. Gli animali infetti diffondono *B. abortus* attraverso il colostro e il latte conseguenti al parto; l'escrezione può proseguire in maniera intermittente per molti mesi e in alcuni casi anche per più di due anni. La mammella degli animali infetti rappresenta l'organo più frequentemente colonizzato dalle brucelle.

B. melitensis è l'agente eziologico primario della brucellosi ovi-caprina. L'infezione si trasmette per le stesse vie descritte per la brucellosi bovina, in particolare per via venerea, in quanto la monta naturale è metodo comune di riproduzione, determinando batteriemia e colonizzazione della milza, delle ghiandole mammarie e quasi sempre dell'utero e della mammella nei soggetti gravidi. Negli ovi-caprini l'aborto si manifesta tra il 3° e il 4° mese di gravidanza ed è molto spesso seguito da ritenzioni degli invogli. Solitamente l'attività riproduttiva non risulta compromessa, almeno nelle capre nelle quali solo raramente si osserva l'aborto. Sia nella pecora che nella capra la mastite può manifestarsi con segni evidenti, quali presenza di noduli mammari di varia grandezza e alterazione della secrezione latte.

La BRC è classificata come malattia di categoria BDE secondo la classificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della commissione del 3 dicembre 2018

Programma di eradicazione e Azioni di controllo

Nell'anno 2022 è stato elaborato un programma di Eradicazione per la Brucellosi bovina, presentato alla Commissione europea per l'approvazione ed il cofinanziamento, che prevede l'esecuzione di controlli negli allevamenti di bovini e bufalini, con cadenze diverse per i territori indenni e non indenni; viene inoltre effettuata l'ispezione presso gli impianti di macellazione.

Con l'emanazione del "Programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive delle

specie bovina e bufalina in Regione Campania ” (DGR n.104 dell’ 08/03/2022) che prevede ulteriori misure straordinarie da applicare in alcune zone denominate “aree cluster d’infezione”, sono state introdotte procedure maggiormente efficaci per l’eradicazione della tubercolosi bufalina che prevedono l’utilizzo del gamma/interferone come prova non più di conferma, per l’eradicazione al fine di ottimizzare le procedure e velocizzare i tempi di eradicazione, in ottemperanza al Reg. Del. (UE) 2020/689.

Le operazioni di controllo della Brucellosi ovi-caprina si svolgono in conformità alla legislazione regionale e comunitaria e s.m. e O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.

Normativa regionale:

- Delibera Della Giunta Regionale N° 104 Del 08/03/2022: “Programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina in Regione Campania”, che sostituisce integralmente la deliberazione della Giunta regionale n. 207/2019 ed include, opportunamente modificate, le istruzioni operative per le profilassi di Stato, fornite alle AASSLL. Alle AASSLL sono fornite, con decreto Dirigenziale gli elenchi rimodulati degli stabilimenti ricadenti in aree cluster, con cadenza almeno semestrale.

Procedure documentate regionali:

- procedura documentata dell’attività obbligatoria AO5, il cui scopo è l’organizzazione delle attività di monitoraggio e la standardizzazione delle procedure operative relative al controllo negli stabilimenti di macellazione nei confronti della brucellosi e della tubercolosi in regione Campania.

L’attività di monitoraggio, oltre a consentire la raccolta di informazioni circa l’eventuale presenza di Mycobacterium Tuberculosis complex (MTBC) e Brucella spp. (BRC) in Regione Campania, ha l’obiettivo di rilevare quanto prima l’eventuale introduzione della malattia nei territori attualmente indenni al fine di adottare adeguate misure di gestione del rischio, nonché quello di definire l’andamento epidemiologico nei territori Non Indenni.

- PROCEDURA PIANO B2, riguardante l’attività di controllo ufficiale ai fini del rilascio del nulla osta al ripopolamento degli stabilimenti dopo stamping out, il cui scopo è l’organizzazione e la standardizzazione delle attività previste per la riapertura ed il ripopolamento degli stabilimenti sottoposti a provvedimenti di abbattimento totale (Stamping-out) nei confronti della brucellosi e della tubercolosi in regione Campania.
- PROCEDURA PIANO A1 relativa all’eradicazione della TBC, BRC e LEB nei bovini e bufalini, il cui scopo è scopo è l’organizzazione delle attività di monitoraggio e la standardizzazione delle procedure operative relative al controllo degli stabilimenti zootecnici nei confronti della brucellosi e della tubercolosi in regione Campania.

Normativa nazionale:

- Ordinanza Ministeriale del 28/05/2015 e ss.mm.ii
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136

Normativa Comunitaria:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della commissione del 3 dicembre 2018
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della commissione del 17 dicembre 2019
- Regolamento D(UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016

LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LEB)

La decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2017/1910 del 17 ottobre 2017 ha riconosciuto all'Italia la qualifica di ufficialmente indenne da Leucosi Bovina Enzoetica (LEB). Tale riconoscimento è stato raggiunto perché è stato possibile dimostrare che gli allevamenti infetti nel territorio italiano sono inferiori dello 0,2% e, di conseguenza, il rischio di diffusione dell'infezione al di fuori dei pochi cluster ancora persistenti è stato valutato come trascurabile.

Grazie al mutato quadro normativo ed epidemiologico, a partire dal 2018 tutte le regioni italiane possono quindi applicare un piano di sorveglianza con l'obiettivo di mantenere la qualifica di territorio Indenne. Ciò vale anche per le regioni in cui sono presenti ancora cluster di infezione che però dovranno gestire queste residue situazioni con piani specifici il cui obiettivo rimane l'eradicazione della LEB.

I criteri per il mantenimento di status Regionale di Indenne da LEB sono contenuti nei Reg (UE) 2016/429 e dal Regolamento Delegato (UE) 2020/689, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della commissione, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.

La LEB è classificata come malattia di categoria BDE secondo la classificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della commissione del 3 dicembre 2018

BLUETONGUE (BT)

Considerata la situazione epidemiologica venutasi a determinare in conseguenza della diffusione dei sierotipi BTV1 e BTV4 in gran parte del territorio nazionale e dell'introduzione del BTV3 nelle Regioni Sicilia e Sardegna il sistema di sorveglianza nazionale vigente tiene conto della mutata situazione epidemiologica e nell'attuazione degli atti delegati discendenti dal regolamento (UE) 429/2016, sono state aggiornate le regole per la movimentazione degli animali delle specie sensibili all'interno del territorio nazionale tenendo conto del nuovo sistema di sorveglianza; il provvedimento Dirigenziale 17522 del 26/06/2019 con i relativi Allegati A, B, C, D ed E, disciplina le misure di controllo e gestione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sul territorio nazionale.

A livello regionale, il territorio campano è suddiviso in celle di 45 km lato dove trimestralmente devono essere testati per provincia, affinché il territorio non risulti sconosciuto, almeno l'80% dei capi secondo la numerosità campionaria da tabella allegata alla nota DGSAF n° 20176 "MISURE DI CONTROLLO E GESTIONE SUL TERRITORIO Nazionale - 0017522-26/06/2019-DGSAF-MDS-P".

Per evitare la dichiarazione di "Territorio epidemiologicamente sconosciuto", attribuito su base provinciale, l'attività di controllo deve essere ben programmata e svolta in maniera regolare, in rispetto degli obblighi informativi.

In caso di positività all'esame sierologico effettuato in prima istanza dall'IZS del Mezzogiorno i campioni relativi vengono inviati a Teramo per la conferma, da effettuarsi con metodo di sieroneutralizzazione o PCR.

Normativa comunitaria:

- Regolamento (UE) 2016/429;
- Regolamento Delegato (UE) 2020/687;
- Regolamento Delegato (UE) 2020/688;
- Regolamento Delegato (UE) 2020/689

Normativa Nazionale:

- Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. 17522 del 26/06/2019;
- Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. 5809 del 5 marzo 2021.
- Nota ministeriale prot. n. 31193 del 23/12/2022 comunica l'elenco dei territori stagionalmente liberi per il periodo 2022-2023."

MALATTIA DI AUJESZKY (ADV)

La ADV è categorizzata come malattia di categoria C D E secondo la classificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della commissione del 3 dicembre 2018.

Con la Delibera n°289 del 15/06/2020 viene approvato il Piano regionale di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Campania.

Considerato che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto lo status sanitario di indenne per malattia di Aujeszky e che, in caso di difficoltà nell'ottenere analoga qualifica, il comparto produttivo suinicolo campano subirebbe significative penalizzazioni, e che l'applicazione delle disposizioni previste dalle norme nazionali ha determinato nel patrimonio suinicolo della Regione Campania una sensibile diminuzione della prevalenza di aziende positive agli accertamenti diagnostici, la Regione Campania, con la nota PG/2023/0211318 del 20/04/2023, al fine di tutelare le attività commerciali degli allevamenti regionali, ha ritenuto necessario attuare un percorso di eradicazione che, permetta l'eradicazione e l'acquisizione di indennità del territorio regionale dalla malattia di Aujeszky.

Nello specifico, il programma prevede:

- la verifica e il monitoraggio della presenza e della circolazione del virus della MA negli allevamenti suini della Regione Campania;
- l'aumento della percentuale degli allevamenti in possesso della qualifica di indenne da MA, attraverso il risanamento delle aziende infette;
- protocolli operativi per l'assegnazione e il mantenimento della qualifica e per l'applicazione delle misure di biosicurezza.

Normativa Comunitaria:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della commissione del 3 dicembre 2018;
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della commissione del 17 dicembre 2019;
- Regolamento D(UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016.

SALMONELLOSI

Le Salmonelle sono un gruppo di microrganismi che possono causare malattie sia negli animali che nell'uomo. Al genere *Salmonella* appartengono diverse specie, sub-specie e sierotipi, i quali in determinate circostanze possono dare malattia nell'uomo, soprattutto attraverso il consumo di alimenti di origine animale.

Sono considerati serbatoi di salmonella in particolare gli avicoli e i suini, eliminatori di microrganismi attraverso le feci anche in assenza di sintomatologia. È inclusa nelle categorie D+E dell'elenco di cui all'allegato art 2 del Reg di esecuzione 2018/1882.

I dati aggiornati a livello europeo sul numero di casi umani, dimostrano che gli alimenti principalmente coinvolti in episodi di malattia alimentare sono uova ed ovoprodotti, e che una parte non indifferente dei casi è riconducibile al consumo di alimenti a livello domiciliare.

Al fine di limitare i casi di salmonellosi umana riconducibili ad alimenti di origine animale, i Paesi Europei applicano dal 2007 dei piani di controllo nazionali a livello di produzione primaria che interessano il settore avicolo. A seguito dell'applicazione di questi piani di controllo il numero di casi di salmonellosi si è ridotto in modo significativo nel tempo.

Normativa Nazionale:

Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2022-2024

Scopo del piano è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo delle salmonelle potenzialmente responsabili di zoonosi a livello di produzione primaria, ai fini della riduzione della prevalenza e del pericolo per la sanità pubblica.

È obbligatorio, su tutto il territorio nazionale, per i gruppi degli allevamenti avicoli a carattere commerciale delle seguenti specie e orientamenti produttivi:

- riproduttori *Gallus gallus*;

- ovaiole *Gallus gallus*;
- polli da carne *Gallus gallus*;
- tacchini da riproduzione *Meleagris gallopavo*;
- tacchini da ingrasso *Meleagris gallopavo*.

Le attività di controllo del piano sono finalizzate al raggiungimento dell'**obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza dei sierotipi** di Salmonella **rilevanti** per la salute pubblica pari all'1% o meno per i gruppi di riproduttori e di polli da carne *Gallus gallus* e per i tacchini da riproduzione e da ingrasso, e al 2 % o meno per i gruppi di ovaiole in deposizione.

Il piano prevede che i gruppi di animali debbano essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti per territorio nell'ambito dell'attività ufficiale, secondo modalità individuate

Tali Piani prevedono anche l'effettuazione di ispezioni e visite periodiche in allevamento. Fermo restando che i Servizi Veterinari devono validare e verificare le attività previste in autocontrollo, i cui risultati vanno inseriti in un sistema informativo nazionale a cura degli allevatori, il controllo ufficiale presuppone in ogni caso la verifica della correttezza dei dati riguardanti gli allevamenti avicoli presenti in BDN; attività fondamentale per poter dimostrare corrispondenza tra i dati inseriti nella BDN e il lavoro di campionamento svolto negli allevamenti.

Link utili:

https://www.anmvioggi.it/images/PIANO_NAZIONALE_DI_CONTROLLO_SALMONELLOSI_AVICOLI_2022-2024.pdf

SETTORE 12 – RIPRODUZIONE ANIMALE

Il Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n. 52, relativo la "Disciplina della riproduzione animale", stabilisce i criteri generali e gli aspetti organizzativi cui devono fare riferimento le attività relative alla riproduzione animale per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina. In attesa degli adempimenti che competono all'Amministrazione statale, per quelli che fanno capo alle Regioni con la DRGC n.318/2015 e s.m.i. e con DGRC n.605 del 08/11/2016, sono dettagliatamente individuate le procedure per la notifica ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare ed alla sanità pubblica veterinaria, nonché con la modifica dell'allegato alla DGRC n.318/15 e s.m.i. le attività di controllo, in ambito della riproduzione animale, individuando peraltro le autorità abilitate ad erogare le sanzioni. Secondo le rispettive competenze, tali autorità sono riconosciute nei Carabinieri Forestali, i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. ed il personale afferente alla D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione con le sue strutture territoriali provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. Al fine di verificare il rispetto delle norme di igiene sanità, in attesa di disposizioni attuative statali e regionali tenuto conto delle disposizioni in materia di sanità animale e di riconoscimento degli stabilimenti di produzione di materiale germinale, di cui al regolamento (UE) n. 429/2016, richiamato nel predetto D.L.vo n. 52/18, si ricorre alla precedente programmazione dei controlli di cui all'articolo 38 del DM n.403/2000, che prevede che almeno una volta all'anno le AASSLL effettuino un controllo nelle stazioni di fecondazione pubblica, nei centri di magazzinaggio e negli allevamenti suinicoli che praticano l'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale, e almeno due volte all'anno nei centri di produzione di materiale seminale, nei gruppi di raccolta di embrioni e nei centri di produzione di embrioni.

Inoltre, su richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei centri di produzione di sperma, le AASSLL effettuano controlli annuali sullo stato sanitario dei riproduttori nelle stazioni e centri medesimi, per constatare l'assenza di malattie infettive e diffusive a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/11/2016 sono state definite le procedure regionali per la notifica degli stabilimenti e l'inserimento nel sistema regionale GISA con particolare riferimento:

- alla tenuta dell'elenco degli operatori di fecondazione artificiale distinto nelle sezioni medici veterinari ed operatori pratici;
- alle attività di controllo.

L'attività di controllo è svolta presso le strutture autorizzate, e persegue le finalità di seguito indicate:

- contrasto alle attività clandestine;
- verifica del possesso dei requisiti previsti da parte dei riproduttori impiegati presso le strutture autorizzate (iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico, autorizzazione da parte dell'Associazione di razza alla inseminazione naturale o artificiale, ecc);
- verifica della corretta tenuta delle scritture e della documentazione prevista.

SEZIONE D - MACROAREA MANGIMI

SETTORE 13 –MANGIMI

Le Autorità Competenti all'esecuzione dei controlli in materia di mangimi sono i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., i CC NAS nonché i Carabinieri Forestali.

Nella materia relativa a tale settore, le A.C. territoriali espletano i controlli come programmati dalla Regione in base alle indicazioni contenute dal Piano nazionale (di monitoraggio) sull'alimentazione degli animali (PNAA).

SEZIONE E – MACROAREA BENESSERE ANIMALE

SETTORE 14 - BENESSERE ANIMALE

Le Autorità Competenti all'esecuzione dei controlli in materia di benessere animale sono i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., i CC NAS, i Carabinieri Forestali nonché le Guardie zoofile accreditate presso la Regione per quanto riguarda gli animali d'affezione. Compete, in ogni caso ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., la completa valutazione di stato di salute e di benessere, disagi fisici ed etologici e anche la certificazione sulle reali condizioni di maltrattamento degli animali.

Nella materia relativa a tale settore, le A.C. territoriali espletano i controlli come programmati dalla Regione in base alle indicazioni contenute dal Piano nazionale (di monitoraggio) sul benessere animale (PNBA).

I controlli ufficiali sul benessere animale si basano sulla:

- verifica del grado di applicazione delle misure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di benessere animale;
- rilevazione delle principali criticità dei metodi di allevamento con riferimento al benessere animale;
- utilizzo, quando obbligatorio, di apposite check-list redatte dal Ministero, le quali devono essere allegate ai Mod 5 di ispezione.

I controlli in materia di Benessere animale vengono effettuati essenzialmente nelle seguenti direttrici:

- in allevamento;
 - di animali da compagnia;
 - di animali da reddito;
- al macello;
- durante il trasporto;
 - di animali da compagnia;
 - di animali da reddito.

Controlli in allevamento: nella scelta degli allevamenti da sottoporre a controllo sono

privilegiati quelli indicati da CLASSYFARM, con l'applicazione dei criteri di rischio indicati dal ministero oltreché in quelle strutture dove sono state accertate, in passato, non conformità in materia.

Controlli durante la macellazione: il veterinario addetto a tale controllo deve redigere le apposite check-list redatte dal Ministero per la valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali degli impianti di macellazione.

Controlli durante il trasporto: poiché il presente Piano non prevede la categorizzazione di rischio dell'attività di trasporto, per la programmazione delle attività di controllo si dovrà tener conto di:

- direttrici di trasporto per le quali in passato si è registrata un'elevata percentuale di irregolarità;
- irregolarità ripetute da parte di talune imprese di trasporto;
- incremento della movimentazione di determinate specie animali in alcuni periodi dell'anno, come ad esempio di agnelli in prossimità della Pasqua e del Natale;
- segnalazioni dai Punti di contatto di cui all'art. 24 del regolamento (CE) n. 1/2005;
- trasporto di specie animali per le quali il regolamento richiede particolari requisiti tecnici dei mezzi, come nel trasporto di equidi domestici su lunga distanza;
- trasporto di animali in situazioni climatiche avverse, come facilmente riscontrabili in inverno ed in estate.

SETTORE 15 - SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Ai sensi della normativa vigente è il Ministero della Salute l'A.C. competente al rilascio delle autorizzazioni agli stabilimenti che intendono utilizzare animali vivi a fini scientifici e di ricerca, non essendo intervenuta alcuna delega alle regioni. Invece l'attivazione di allevamenti di animali da utilizzare a fini scientifici e di quelli che forniscono animali utilizzati a fini scientifici (fornitori) è di competenza dei Comuni e avviene con una SCIA condizionata.

In ogni caso, Regioni ed AASSLL sono investite di precise responsabilità per quanto attiene ai controlli in tali stabilimenti; infatti, ai sensi dell'art 4 comma 3, del D.Lgs. 26/2014, è l'ASL (territorialmente competente ove ha sede lo stabilimento) l'autorità competente a svolgere attività di controllo in tutte le tipologie di stabilimenti nel campo dell'impiego di animali a fini scientifici, compresi quelli che impiegano gli organi o tessuti di animali ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro.

In tutti i casi il controllo di tali stabilimenti viene effettuato anche per la verifica dell'eventuale presenza di animali con sintomi di malattie infettive e/o zoonosi, del rispetto delle condizioni di benessere oltreché per la verifica delle condizioni igieniche generali e di gestione degli stabilimenti.

SETTORE 16 - INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)

Basi Giuridiche Regionali:

- DGRC n. 82 del 21/02/2017 “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee Guida Nazionali per gli IAA”
- D.D. n. 291 del 3/12/2018 “Procedura di autorizzazione allo svolgimento di corsi non finanziati riconosciuti dalla Regione Campania e iscrizione agli elenchi regionali di centri specializzati, centri non specializzati, figure professionali e operatori “ – Allegato A: “Linee guida vincolanti per l’istituzione dell’elenco delle Agenzie/Enti abilitati ad erogare formazione in materia di IAA ai sensi dell’Accordo Stato Regioni”; Allegato B: “Registrazione di centri specializzati, strutture non specializzate ospitanti IAA, figure professionali e operatori”; Allegato C: “Scheda supplementare n. 125 per Agenzie/Enti che effettuano corsi di formazione per figure professionali ed operatori in IAA”

Gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e prevedono l’impiego di animali domestici, quali ad es. cane, cavallo, asino, gatto e coniglio. L’utilizzo degli animali a fini terapeutici si inserisce nel più ampio ambito del rapporto uomo- animale. È ormai diffusa la nozione che un animale da compagnia, oltre a garantire la sostituzione di affetti mancanti o carenti, possa favorire i contatti interpersonali attraverso meccanismi di facilitazione sociale. Negli ultimi decenni, infatti, è stato dimostrato un effetto diretto del legame con un animale da compagnia (pet) su parametri psicofisiologici collegati alla salute umana.

In base agli ambiti di attività, gli IAA si classificano in:

- Terapia Assistita con gli Animali (TAA): Intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura dei disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale. L’intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l’impiego del cavallo.
- Educazione Assistita con gli Animali (EAA): Intervento di tipo educativo, al fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale e di relazione, rivolto sia a soggetti sani che diversamente abili o a persone affette da disturbi del comportamento.
- Attività Assistita con gli Animali (AAA): Intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione, finalizzato al miglioramento della qualità di vita e di interazione uomo-animale.

La competenza in materia di controlli sui programmi di IAA spetta ai Servizi veterinari territoriali delle AASSLL. Pertanto, il Centro di Riferimento di Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) persegue la realizzazione di modelli operativi per l’erogazione degli IAA anche attraverso gruppi misti di lavoro. Infatti, sono in essere Progetti di EAA realizzati mediante la stipula di Protocolli di Intesa tra il Centro di Riferimento di Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) e diversi istituti scolastici insistenti sul territorio della città di Napoli.

SEZIONE F - MACROAREA SANITÀ DELLE PIANTE

SETTORE 17 – ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

L'Autorità Competente a svolgere controlli sulla sanità delle piante relativamente alla presenza di organismi nocivi delle piante, è la D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – UOD 10 "Fitosanitario regionale". Il personale ad esso afferente svolge controlli ufficiali previsti da norme nazionali e/o comunitarie, diversi dai Piani specifici comunitari, con organizzazione e programmazione regionale, secondo le competenze attribuite dall' art.50 del D.Lgs. n. 214/2005.

In particolare, le attività sono articolate in:

- A. controlli ufficiali sul territorio;
- B. controlli ufficiali su vegetali e prodotti vegetali in esportazione;
- C. controlli ufficiali su vegetali e prodotti vegetali in importazione.

A) CONTROLLI UFFICIALI SUL TERRITORIO

A1 - Sono previsti controlli ufficiali finalizzati alla sorveglianza fitosanitaria del territorio effettuati con organizzazione e programmazione regionale, con ispezioni visive e test diagnostici sui parassiti e patogeni delle piante realizzati presso il Laboratorio fitopatologico regionale, secondo protocolli ufficiali.

Il Servizio fitosanitario regionale per le nuove avversità e gli organismi a rischio di introduzione nella regione, per le quali sono in vigore specifiche norme di emergenza fitosanitaria, effettua la vigilanza fitosanitaria, individua i territori interessati, stabilisce gli interventi ritenuti necessari nelle zone focolaio eventualmente individuate, adotta specifici piani regionali per l'eradicazione e/o il controllo degli organismi nocivi, effettua la sorveglianza sull'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente. Annualmente sono notificati al Servizio fitosanitario centrale i risultati dei controlli effettuati.

A2) Sono previsti controlli ufficiali per accertare nella filiera produttiva e di commercializzazione la presenza di organismi nocivi regolamentati, al fine di **accertare l'idoneità alla produzione**, commercializzazione e circolazione di vegetali e prodotti vegetali (Piante, parti di piante, Patate ed agrumi con peduncolo e foglie). In questa tipologia di controlli rientrano:

- **il controllo fitosanitario nella filiera produttiva e di commercializzazione della patata.**
- **il controllo della filiera di produzione e commercializzazione di piante e materiale di propagazione delle piante, Titolo III del D.Lgs n. 214/2005 "Controlli sulla produzione e commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione".**

I controlli sono effettuati regolarmente almeno una volta all'anno, sono effettuati in qualsiasi momento in tutte le fasi della filiera produttiva e di commercializzazione, generalmente in fase di produzione dei vegetali, con controllo documentale, ispezione visiva e se necessario con analisi di laboratorio.

Il Servizio fitosanitario regionale effettua i controlli fitosanitari alla produzione e commercializzazione delle piante e del materiale di propagazione, rilascia le autorizzazioni fitosanitarie (*autorizzazione fitosanitaria ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 19/08/05/214 s.m.i per la produzione, commercializzazione e circolazione di vegetali e prodotti vegetali*), notifica al Servizio fitosanitario centrale (SFC) la eventuale presenza sul territorio regionale di organismi nocivi precedentemente non presente.

B) CONTROLLI UFFICIALI SU VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI IN ESPORTAZIONE

I controlli sono finalizzati al controllo fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali in esportazione, sono realizzati con organizzazione e programmazione regionale, sono gestiti con database regionali e nazionali e sono relativi a:

- **Controlli per l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali**, D.Lgs n. 214/2005, art.43 "Controlli all'esportazione di vegetali e prodotti vegetali". I controlli sono effettuati su richiesta dell'esportatore, presso i magazzini di conservazione della frutta presenti sul territorio regionale, con analisi visiva delle merci a campione ed analisi di laboratorio se ritenute opportune dall'Ispettore fitosanitario. Verificata la conformità della merce ai requisiti previsti dalla normativa del paese terzo destinatario, l'Ispettore fitosanitario rilascia il certificato fitosanitario di esportazione o riesportazione conforme alle norme della Convenzione Internazionale per la protezione delle piante ed alle esigenze del paese destinatario.
- **Controlli ufficiali previsti dalle norme statunitensi per l'esportazione di frutta (kiwi e agrumi) - Cold Treatment.**

Il Servizio fitosanitario regionale effettua per la frutta in esportazione il controllo documentale, di identità e fitosanitario. I controlli sono effettuati, su richiesta degli esportatori e presso i magazzini di conservazione della frutta presenti sul territorio regionale, con il controllo della temperatura e dello stato fitosanitario dei frutti, il controllo ed il sigillo del container utilizzato per la spedizione, la predisposizione del certificato fitosanitario.

C) CONTROLLI UFFICIALI SU VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI IN IMPORTAZIONE

I controlli sono finalizzati al controllo fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali in importazione da Paesi terzi, sono realizzati con organizzazione e programmazione regionale, sono gestiti con database regionali e nazionali e sono relativi a:

- **controlli sui vegetali e prodotti vegetali in importazione**, D.Lg. n. 214/2005 e s.m.i. Titolo VIII "Attività di controllo all'importazione di vegetali e prodotti vegetali". I controlli sono effettuati ai punti di entrata frontalieri (PIF) della Comunità Europea, per verificare la conformità della merce in importazione alla normativa fitosanitaria vigente, con ispezione visiva ed eventualmente campionamento ed analisi delle merci. Ogni spedizione o partita costituita da vegetali, prodotti vegetali e altri materiali regolamentati, elencati nell'allegato V, parte B del D.Lgs 214/2005, è ispezionata interamente o per campioni rappresentativi. Le spedizioni di merci non regolamentate sono ispezionate, a

campione, per verificare che non siano veicolo di introduzione di organismi nocivi alle piante. Il Servizio fitosanitario regionale effettua il controllo documentale, di identità e fitosanitario sui vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi, rilascia il nulla osta all'importazione se le merci sono conformi alla normativa fitosanitaria vigente, adotta le misure ufficiali di quarantena, respingimento o distruzione se le merci non sono conformi alla normativa fitosanitaria vigente, notificando l'intercettazione al Servizio Fitosanitario Centrale.

SETTORE 18 – PRODOTTI FITOSANITARI

Il controllo dei prodotti fitosanitari si suddivide in due settori distinti:

1. Controlli sull'immissione in commercio e impiego dei prodotti fitosanitari

Ai sensi dell'articolo 68 del Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, gli Stati membri effettuano controlli ufficiali per garantire il rispetto delle norme in materia.

Tale piano prevede l'effettuazione di ispezioni:

- negli stabilimenti di produzione, deposito, vendite al dettaglio o all'ingrosso di fitofarmaci.
- nelle aziende di produzione primaria agricole/floricola.

Nella prima tipologia di stabilimenti vengono effettuate ispezioni per la verifica della corretta osservanza delle norme sull'immissione in commercio dei fitosanitari, mentre nelle aziende agricole/floricole viene verificato il loro corretto impiego.

L'A.C. a svolgere controlli su tale piano sono i SIAN delle AA.SS.LL. nonché i CC NAS ed i CC Forestali.

2. Controlli sui residui di fitosanitari negli alimenti di origine vegetale ed animale.

All'uopo nei DPAR è previsto il Piano Nazionale e Comunitario di Residui di Fitosanitari nei prodotti alimentari, suddiviso in appositi sottopiani per le norme di riferimento:

- piano di monitoraggio nazionale sui residui di fitosanitari negli alimenti di origine vegetale ed animale Decreto Ministeriale 23 dicembre 1992, che recepisce la Direttiva 90/642/CEE. Per tutelare la salute dei consumatori e per verificare i livelli massimi di residui di prodotti fitosanitari in alimenti stabiliti con il Regolamento CE N. 396/2005 di seguito chiamato regolamento vengono eseguiti i controlli ufficiali dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti. Il regolamento stabilisce che vengano, attraverso programmi nazionali, effettuati campionamenti rappresentativi del mercato, e tenendo in considerazione gli esiti dei controlli dei precedenti anni.
- piano di monitoraggio Programma di Controllo Coordinato Unione Europea (PCCUE) istituito con regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, gli antiparassitari in tali prodotti devono essere monitorati nell'arco di

vari cicli triennali per consentire la valutazione dell'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione. Tale programma è proseguito nel quadro di successivi regolamenti. Nell'Unione i principali componenti della dieta delle persone sono costituiti da trenta/quaranta prodotti.

L'A.C. a svolgere controlli per tali piani sono i SIAN ed i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. nonché i CC NAS.

SEZIONE G - MACROAREA M.S.R., S.O.A. e P.D.
SETTORI 19 e 20 - M.S.R., S.O.A. e P.D.

Le A.C. deputate a svolgere controlli sui S.O.A., P.D. e M.S.R. sono i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL.. Considerato che uno degli obiettivi del presente Piano è quello di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per la salute pubblica e animale, siano essi rischi diretti o indiretti, l'impostazione generale dello stesso si ritiene applicabile anche al settore dei sottoprodotti di origine animale.

I controlli ufficiali sui S.O.A. e sui P.D. si basano sulla:

- verifica del grado di applicazione delle misure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia;
- rilevazione delle principali criticità dei metodi di trasformazione e produzione;
- utilizzo, quando obbligatorio, di apposite check-list da allegare ai Mod 5 di ispezione;

I controlli ufficiali sui M.S.R. si basano sulla verifica della loro corretta gestione e smaltimento. Per quanto riguarda la programmazione, questa è già stabilita a livello nazionale dell'Accordo Stato- Regioni 212/2016 "Linee guida ai sensi del Regolamento CE 882-854/2004" recepito con DGRC 23.1.17, n. 27, che rimarrà in vigore fino all'emanazione delle nuove linee guida ai sensi del regolamento UE 2017/625, così come da disposizioni transitorie indicate dal DGISAN 0069887-P-18.12.2019.

SEZIONE H - MACROAREA FARMACI VETERINARI

SETTORE 21 - FARMACOVIGILANZA VETERINARIA

Il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, N. 193, attuativo della direttiva 2004/28/CE recante il codice comunitario dei medicinali veterinari, all'art. 94, comma 2, prevede l'attivazione a cura delle Regioni dei Centri regionali di farmacovigilanza, con il contributo degli Istituti Zooprofilattici, delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria o di altri centri specializzati. Con decreto dirigenziale del Settore Veterinario Regionale n. 101 del 28 dicembre 2007 è stato approvato il progetto pilota per l'attivazione del *"Centro di riferimento regionale per la Farmacovigilanza Veterinaria"*, allocato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il Centro gestisce un sistema di raccolta, trasmissione e valutazione delle informazioni relative alle reazioni avverse del medicinale veterinario rilevate nel territorio della Campania. Nella prima fase attuativa è stato affidato al Centro anche il compito di avviare un processo di informazione, formazione e aggiornamento rivolto ai medici veterinari, in collaborazione con il servizio sanitario territoriale.

Grazie al lavoro preliminare, svolto in attuazione del progetto, oggi il Centro opera in stretta correlazione con i referenti territoriali della Farmacovigilanza Veterinaria, con la Regione e con il Ministero della Salute ed è composto da personale regionale e della Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli ed è dotato di un proprio regolamento operativo.

Il Centro concorre alla costituzione, in ambito nazionale e comunitario, di un sistema di raccolta, trasmissione e valutazione delle informazioni relative alle reazioni avverse del medicinale veterinario. Chiunque ha motivo di ritenere che dall'utilizzo di un medicinale veterinario siano derivate sospette reazioni avverse, è tenuto a darne comunicazione al Centro. Sono tenuti alla segnalazione i medici veterinari, i farmacisti, gli istituti di ricerca e le cliniche veterinarie delle università, le aziende titolari di A.I.C. e gli operatori professionali sul territorio per il tramite del veterinario. Le segnalazioni sono effettuate utilizzando l'apposita scheda di segnalazione. Le schede di segnalazione devono essere trasmesse via fax, e-mail o posta prioritaria entro quindici giorni dal momento della conoscenza dell'evento. Nel caso in cui le reazioni avverse siano da considerarsi gravi, il predetto termine è ridotto a sei giorni.

Le attività del Centro risultano essere le seguenti:

- raccolta delle segnalazioni di Reazione Avversa - il Centro, ricevuta la segnalazione, assicura:
 - l'esame delle schede di segnalazione pervenute;
 - l'invio delle schede al Ministero della Salute –Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario - Ufficio XI ed alla regione per la successiva gestione delle stesse;
 - lo sviluppo e il mantenimento di un apposito archivio per la Farmacovigilanza in cui si raccolgono le schede di segnalazione;
 - eventuali sopralluoghi sul territorio e aggiornamento del Ministero della Salute sull'attività svolta.

- divulgazione ed informazione sul territorio - oltre ad effettuare l'informazione diretta presso le strutture ambulatoriali, il Centro concorre all'informazione dei Liberi Professionisti attraverso brochure e poster divulgativi;
- promozione di eventi formativi ed informativi - il Centro organizza giornate formative per i Medici Veterinari delle Asl e dei Liberi Professionisti;
- promozione ed informazione telematica - è disponibile un sistema telematico - portale internet ed e-mail www.anagrafecaninacampania.it - farmacovigilanza@unina.it) - per la diretta comunicazione con Enti e/o persone interessate.

Nell'ambito della farmacovigilanza, in Regione vengono svolte inoltre le seguenti attività:

- valutazione dell'efficacia dei vaccini antirabbia mediante la verifica dei rapporti di prova;
- valutazione dell'antibiotico-resistenza dei principali agenti a carattere zoonotico isolati da specie aviare e cunicole nei confronti dell'Enrofloxacin nella Regione Campania;
- incentivazione dell'attività di Farmacovigilanza anche nel settore degli animali da reddito;
- promozione di giornate di informazione per i Medici Veterinari delle Regioni meridionali disponendo di contatti con le istituzioni universitarie ed istituzionali delle altre Regioni limitrofe;
- diffusione delle attività del Centro presso le rivendite autorizzate di farmaci veterinari.

SETTORE 22 - FARMACOSORVEGLIANZA VETERINARIA

Normativa di riferimento:

- Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193
- nota del Ministero della Salute DGSAF-MDS-P 8335-24/03/2023-
- reg. 2019/6
- reg. 2019/4
- nota Regione Campania PG/2023/0176954 del 31/03/2023
- piano Nazionale Farmacosorveglianza (FS 2023)

Con l'introduzione di Classyfarm, che prevede la valutazione degli indicatori di rischio aziendale, con criteri omogenei in ambito nazionale che spaziano dalla valutazione del benessere animale alla biosicurezza, alla valutazione al macello delle lesioni anatomopatologiche riscontrate, fino alla mortalità neonatale in azienda, in aggiunta ad autovalutazioni volontarie dell'allevatore, il concetto di programmazione dei controlli regionale è decaduto lasciando il passo al nuovo principio di rischio in un contesto nazionale, dettando quindi la numerosità (60%) e la tipologia di aziende da sottoporre a controllo per il rischio di utilizzo farmaco, lasciando comunque alle AASSLL, una quota pari al 35 % di controlli da programmare in modo discrezionale in base ai criteri di rischio di cui alla predetta ultima nota ministeriale, oltre alla quota random ministeriale del 5% per tutti gli allevamenti di grandi dimensioni.

Per gli allevamenti che non rientrano come caratteristiche (numerosità di capi) il Ministero ha confermato la volontà di esercitare dei controlli ufficiali in ragione del 1%, demandando alle

Regioni e alle AASSLL l'individuazione delle aziende sempre nel rispetto della valutazione del rischio.

All' A.C. spetta il controllo del corretto impiego dei medicinali veterinari, al fine di garantire lo stato di salute e di benessere degli animali, di contribuire alla sicurezza alimentare per il possibile riscontro di residui di sostanze farmacologicamente attive, nonché a prevenire i rischi per l'ambiente dovuti all'uso improprio dei farmaci nel settore zootecnico ed all'utilizzo razionale degli antibiotici a prevenzione del fenomeno dell'antibiotico resistenza. A queste attività si aggiunge anche il controllo sul rispetto delle norme in materia di produzione e distribuzione dei medicinali veterinari.

Da quanto sopra, la farmacovigilanza deve essere intesa come "sistema di controllo finalizzato al monitoraggio della produzione, distribuzione ed utilizzo del farmaco".

L'intera programmazione dei controlli di farmacovigilanza, negli allevamenti delle specie animali produttori di alimenti destinati all'alimentazione animale, è affidata al sistema Classyfarm e, per gli animali non da reddito compreso le attività veterinarie ad essi collegate, a quanto disposto nel nuovo piano Farmacovigilanza FS 2023 trasmesso in allegato alla nota ministeriale del 2023, mediante l'utilizzo dell'applicativo ministeriale "ricetta veterinaria elettronica e farmacovigilanza" (REV), presente in vetinfo.

I controlli possono essere svolti da remoto sul sistema informativo ministeriale della ricetta elettronica (REV) o anche presso gli impianti di cura, allevamento e custodia, e presso i veterinari libero professionisti dove vanno verificati, la corretta gestione delle scorte, le confezioni rimaste inutilizzate o scadute e la gestione dei campioni gratuiti. L'introduzione del sistema elettronico unico nazionale della ricetta veterinaria permette di effettuare una serie di controlli da remoto per la verifica puntuale sulla tracciabilità del farmaco veterinario a partire dalla prescrizione, vendita (farmacia e distributori), utilizzo presso gli allevamenti animali zootecnici, facilitando notevolmente le attività ufficiali di controllo e riservando ispezioni mirate presso i destinatari dei farmaci e non solo. Queste preventive indagini informatiche saranno prodromiche a verifiche ispettive in loco, potendo quindi ridurre il numero di controlli ma aumentando l'efficacia e l'efficienza degli stessi.

SEZIONE I - MACROAREA ALTRO

SETTORE 23 – ZONOSI NELL’UOMO E M.T.A.

In Regione i dati sulle zoonosi nell’uomo afferiscono dal territorio all’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER), che analizza i dati delle malattie ed il loro andamento.

Le Malattie Trasmissibile con gli Alimenti sono patologie legate al consumo di alimenti o acqua contaminate da agenti patogeni di varia natura, come batteri virus, tossine, parassiti ecc. e possono essere così suddivise:

1. intossicazioni, nelle quali l'alimento ingerito contiene già le sostanze tossiche, che possono essere chimiche (metalli pesanti, pesticidi, sostanze vasoattive, ecc.) o essere state prodotte da microrganismi (es. *Staphilococcus aureus*, *Clostridium botulinum*) precedentemente al consumo dell'alimento (tossine); sono intossicazioni anche quelle causate dalle cosiddette micotossine (aflatossine, ocratossine, ecc.), prodotte da muffe che si sviluppano in prodotti agricoli in campo od immagazzinati in cattive condizioni di umidità e temperatura. Tra le intossicazioni si collocano anche i quadri acuti causati da diverse tossine contenute in talune specie fungine, sostanze chimiche del tipo ciclopeptidi (amanitine), biperidine (orellanina), muscimolo, acido ibotenico, muscarina, ecc., le quali possono causare stati morbosi variabili da una sintomatologia gastrica o neurologica fino a quadri clinici molto gravi anche mortali.

2. tossinfezioni vere e proprie, nelle quali con l'alimento vengono ingerite sia le tossine che i microrganismi (es. *Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens*), i quali si riproducono all'interno del nostro organismo continuando a produrre tossine; 3. infezioni provocate dall'invasione di microrganismi che si moltiplicano nelle mucose intestinali o in altri tessuti (es. *Salmonella* spp.), potendo anche produrre sostanze tossiche (enterotossine

Scopo del presente P.C.R.P. è quello di dettare le procedure per implementare il grado di integrazione tra l’OER, l’OERV e l’ORSA al fine di consentire un efficace incrocio dei dati relativi alla segnalazione di pericoli riscontrati negli alimenti, i casi di zoonosi e quelli di M.T.A. nell’uomo e negli animali; ciò al fine di ottenere un quadro epidemiologico più completo e di mirare i controlli ufficiali rendendoli più efficaci.

In relazione a tale esigenza è Stato istituito presso l’O.R.S.A. il **Centro regionale di riferimento sulle Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA)** quale sistema efficace di comunicazione fra i diversi attori coinvolti e per la raccolta centralizzata dei dati sulle indagini epidemiologiche svolte dalle AASSLL, con la funzione di attivare un sistema di sorveglianza in grado di:

- descrivere quali-quantitativamente il fenomeno;
- uniformare le modalità di gestione degli episodi di malattie trasmesse da alimenti nell’intero territorio regionale;
- fornire supporto alle diverse professionalità coinvolte (medici, veterinari, tecnici della prevenzione, infermieri, assistenti sanitari) al fine di integrare gli interventi e ottimizzare la qualità dei risultati, in particolare nell’identificazione dell’alimento responsabile e nell’analisi della relativa tracciabilità;

- consentire risposte tempestive e adeguate alla gestione degli episodi di malattie trasmesse da alimenti e il controllo del rischio;
- implementare un sistema informatico di registrazione delle informazioni in grado di comunicare e cooperare con i sistemi nazionali;
- realizzare un sistema di formazione e confronto degli operatori sanitari, a qualunque livello essi intervengano nell’investigazione degli episodi di malattia trasmissibile da alimenti (MTA), nonché campagne d’informazione destinate all’utenza mirate alla prevenzione delle MTA;
- attivare sinergie con altre strutture nazionali e regionali preposte alla notifica delle MTA;
- uniformare i dati raccolti agli standard europei secondo quanto previsto dai documenti Efsa sulla comunicazione dei dati relativi ai focolai di malattie veicolate da alimenti.

SETTORE 24 – AMBIENTE

I controlli sull’ambiente che abbiano attinenza con la sicurezza alimentare, la sanità pubblica veterinaria e la salute delle piante vengono svolti a livello regionale dall’ARPAC, dai CC NOE, nonché dai Carabinieri Forestali. L’ARPAC effettua sia campionamenti che analisi. Le matrici di tali controlli sono costituite sia da materiale di varia natura (terreno, acqua, aria) e da alimenti di origine non animale.

Tuttavia, ai sensi di quanto già disposto in passato dal Ministero della Salute, in occasione del “Piano di Monitoraggio dei contaminanti ambientali in alimenti di origine animale prodotti nei siti di interesse nazionale”, ove fu data attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 14 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, risulta necessario anche indagare circa la presenza di contaminanti negli alimenti al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli ormai noti episodi legati alla contaminazione ambientale verificatisi in alcune aree della regione hanno confermato la necessità di definire interventi a salvaguardia della salute umana, affrontando il tema della sicurezza alimentare derivante dagli alimenti prodotti nelle aree con criticità ambientali.

Inoltre, la normativa Europea impone agli stati membri controlli sui livelli di contaminanti ambientali in alimenti e mangimi ed in particolare:

- RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 2014 che modifica l'allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti;
- REGOLAMENTO (UE) N. 2023/915 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006.

L’analisi dei dati raccolti negli anni precedenti nel corso dei piani di monitoraggio regionali sulla contaminazione da diossine e PCB-dl ha evidenziato un maggior rischio di contaminazione nella zona del basso casertano e hinterland napoletano rispetto alle altre province campane.

È stato inoltre evidenziato che gli episodi di contaminazione registrati nel recente passato risultano legati quasi sempre ad episodi “spot” dovuti a combustioni illecite ed incontrollate di rifiuti ed altri materiali. Tuttavia, è importante sottolineare come la ricerca di tale inquinante debba essere continuata nel tempo e nello spazio, a scopo precauzionale, su tutto il territorio regionale, senza trascurare però l’analisi del rischio elaborata nel corso degli anni precedenti.

Allo stato attuale tale attività di sorveglianza si espleta sull’intero territorio regionale in occasione di roghi e incendi; a tal fine sono state all’uopo istituite le “Istruzioni operative da attivare in sicurezza alimentare in caso di roghi” che prevedono un protocollo operativo con i Vigili del Fuoco e sono di guida per i servizi territoriali (Veterinari e SIAN) grazie all’ausilio di opportuna cartografia approntata da ORSA.

Per quanto attiene al c.d. “Piano Terra dei Fuochi Nazionale”, la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 46 del 1 marzo 2019 “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii” ha posto particolare enfasi nella classificazione delle aree agricole in relazione alla sicurezza alimentare, dando un nuovo impulso alla prosecuzione del piano di campionamenti coordinato dal Tavolo Tecnico Nazionale.

SETTORE 25 – IGIENE URBANA VETERINARIA (IUUV) E LOTTA AL RANDAGISMO

L’Igiene Urbana Veterinaria (IUUV) comprende attività istituzionali di Sanità Pubblica Veterinaria riconosciute dal legislatore nazionale quali Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) considerando tale materia una priorità da gestire con adeguati strumenti organizzativi, al fine di garantire un accettabile livello di assistenza sanitaria nell’ambito della “prevenzione”.

In particolare, la L.R. n. 3/2019 e ss.mm.ii., applicativa della Legge Quadro n. 281/91 in materia di prevenzione del randagismo, nonché il DPCM del 28.02.03 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, hanno definito le modalità di gestione e le competenze su problematiche che in alcune aree delle Regione hanno assunto negli anni i connotati di una vera e propria emergenza.

Di seguito ulteriori atti normativi hanno attinenza con le attività comprese nell’igiene urbana e nella gestione e prevenzione del randagismo:

- la DGRC n° 593 del 12/05/2006 di recepimento dell’Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy;
- la DGRC n. 1940 del 30/12/2009 di istituzione del Centro di Riferimento per l’Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV);
- la DGRC n. 211/2012 di approvazione del Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali; in esso è stata introdotta l’attività di diagnostica necroscopica sugli animali sinantropi ed istituito presso il CRIUV il Registro dei Tumori Animali (RTA);

- il Regolamento Regionale n. 4 del 30 marzo 2012 che disciplina il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura della fauna selvatica in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania);
- la DGRC n° 209 del 27 giugno 2014 che recepisce l'Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione";
- la Legge Regionale n. 9 del 25/02/2014 recante modifiche alla Legge Regionale n. 19/2012 "Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania", che ha introdotto l'art. 6 comma g, che prevede lo scambio di informazioni tra registro tumori di popolazione e registro tumori animali.
- DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n.53.
- Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, alimentari e forestali, n. 580 del 21/12/2021: individuazione delle attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni previste dal Piano di Gestione e Controllo della specie cinghiale in Campania

Nell'ambito dell'IUV sono comprese le seguenti attività:

- anagrafe canina e movimentazione in Banca Dati Regionale;
- pronto soccorso agli animali senza padrone;
- sterilizzazione degli animali senza padrone quale strumento di controllo delle popolazioni vaganti;
- censimento e monitoraggio sanitario delle colonie feline;
- verifica degli inconvenienti igienico- sanitari da animali d'affezione;
- gestione delle emergenze territoriali provocate da sinantropi;
- controllo sanitario sui concentramenti di animali d'affezione ai fini delle malattie infettive, del benessere, della corretta identificazione nonché della valutazione dei requisiti strutturali ed igienici sanitari dei ricoveri;
- controllo sul commercio degli animali d'affezione;
- certificazione e controllo ai sensi del Reg CE 576/2013 e 577/2013;
- applicazione della Legge 201 del 4 novembre 2010;
- epidemiologia veterinaria applicata ai sinantropi;
- accertamenti di diagnostica cadaverica sugli animali da compagnia ed a vita sinantropica;
- accertamenti diagnostici sulle patologie infettive e non dei sinantropi e dei cani e gatti senza padrone;
- attività del Registro Tumori Animali (RTA);

- controlli sui cani stazionanti degli insediamenti zootecnici, finalizzati all'applicazione dell'anagrafe nonché ai rilievi di tipo zoo epidemiologico;
- educazione sanitaria finalizzata alla conoscenza del corretto rapporto uomo- animale- ambiente;
- gestione di programmi di formazione professionale destinati ad operatori del settore;
- gestione di programmi di formazione ed aggiornamento professionale rivolti agli operatori di Sanità Pubblica;
- gestione di programmi di informazione sulle tematiche di IUV;
- controllo su programmi di IAA (Interventi Assistiti con gli animali);
- Gestione e Controllo della specie cinghiale in Campania.

STANDARD ASSISTENZIALI DI PRIMO LIVELLO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

In Regione Campania lo standard delle prestazioni sanitarie erogate in materia di Igiene Urbana Veterinaria non risulta uniforme in tutte le aziende sanitarie locali. Le carenze evidenziate, sia in termini di risorse umane ed in alcuni casi di organizzazione del servizio, unitamente alla mancanza di una rete interaziendale realizzata secondo il modello Hub/Spoke (strutture di eccellenza dove vengono erogate prestazioni specialistiche di elevata complessità e strutture periferiche per le prestazioni sanitarie di primo livello), compromette l'efficacia dell'azione complessiva del SSR, determinando situazioni critiche localizzate che inevitabilmente vanificano gli interventi anche nelle aree contigue. A causa di dette criticità l'indicatore nazionale adoperato per valutare l'effettiva diminuzione della popolazione canina randagia e, quindi, la corretta gestione del randagismo, risulta non in linea con il valore atteso dall'indicatore nazionale

Risulta pertanto prioritario standardizzare il livello prestazionale di primo livello garantendo sul territorio un'efficace azione di sistema a fronte degli attuali interventi disomogenei.

1. Attività

- 1.1. Anagrafe – identificazione degli animali con il microchip (anagrafe “passiva” presso le strutture dell'ASL) e registrazione nella banca dati dell'anagrafe canina regionale informatizzata.
- 1.2. Sterilizzazione – attività chirurgiche effettuate sistematicamente su tutti i cani vaganti non identificati, prima dell'invio alla destinazione finale (rifugio – adozione – reimmissione).
- 1.3. Primo soccorso – terapie clinico-chirurgiche di primo livello sui cani senza padrone in occasione di interventi di soccorso aventi carattere di urgenza e stabilizzazione dei soggetti da trasferire per interventi di alta specializzazione.
- 1.4. Primo ricovero sanitario – breve degenza dei soggetti soccorsi, sottoposti a terapie clinico-chirurgiche di I livello.
- 1.5. Controlli ufficiali nei canili – attività di controllo effettuate sui requisiti strutturali e

gestionali delle strutture di ricovero di cani.

- 1.6. Formazione/informazione – attività di formazione interna agli operatori sanitari delle AASSLL e informazione all'utenza in materia di gestione dei sinantropi e di igiene urbana veterinaria.

2. Sedi

- 2.1. Ambulatori pubblici territoriali delle AASSLL conformi ai requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi definiti con la DPGR n° 459/2006: in ciascuna ASL almeno 25 posti/degenza distribuiti in una o più strutture adeguate clinico/chirurgiche;
- 2.2. struttura mobile di supporto per ambulatorio nelle aree disagiate ex Legge 25 luglio 1952 n. 991;
- 2.3. Canili.

La competenza in materia di controlli sulle materie sopraelencate è dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., dei CC NAS nonché delle Guardie zoofile accreditate presso la Regione per quanto riguarda l'anagrafe canina; per ogni aspetto diagnostico strumentale, di raccolta ed elaborazione dei dati la competenza è dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

L'identificazione dei cani, gatti e furetti avviene mediante inserimento di un microchip nel sottocute della regione del collo. Il segnalamento degli animali nonché i dati del proprietario sono caricati nella Banca Dati Regionale Unificata Anagrafe Cani Gatti e Furetti (BDU) in cooperazione applicativa con la Banca dati Ministeriale degli Animali di Affezione SINAC (Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia)

I Controlli Ufficiali sono svolti nei canili pubblici e privati, negli allevamenti, nelle pensioni, nei centri di addestramento, nelle toelettature, nelle attività di commercio e presso privati, secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente. Il personale delle AA.SS.LL. registra i dati del controllo nel sistema GISA e redige il Mod. 5 di ispezione.

Le attività sanitarie erogate agli animali senza padrone presso le strutture ambulatoriali pubbliche nonché le attività necroscopiche sugli stessi animali sono registrate obbligatoriamente nel sistema informativo regionale VAM (Veterinary Activity Management).

SETTORE 26 – SISTEMA RAPIDO D'ALLERTA

Il Sistema di allerta rapido (RASFF o Rapid Alert System for Food and Feed), istituito dall'art. 50 del Reg. CE n. 178/2002, è un sistema organizzato sotto forma di rete gestito dalla Commissione i cui membri sono gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che ha lo scopo di scambiare rapidamente informazioni a seguito di riscontro di alimenti, mangimi o materiali a contatto che rappresentano un rischio diretto e indiretto per la salute umana, animale e per l'ambiente.

Con DGRC n. 1745 del 20.11.2009, di recepimento dell'Intesa del 13 novembre 2008 (rep. Atti n. 204/CSR), è stato istituito presso l'Assessorato alla Sanità il "Nodo Regionale" per la gestione delle notifiche di allerta di alimenti, mangimi e materiali ed oggetti destinati ad

entrare in contatto con gli alimenti.

Il Nodo regionale è il punto di contatto per lo scambio di informazioni con altri componenti della rete (punti di contatto regionali e punto di contatto nazionale istituito presso il Ministero della Salute) e gli organi di controllo sul territorio (Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. – Servizi Veterinari e SIAN) presso i quali sono individuati punti di contatto locali.

Con successiva DGRC n. 593 del 28.12.2021 è stata recepita l'Intesa Stato Regioni del 5 maggio 2021 concernente le nuove "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti" REP. ATTI N. 50 CSR del 5 maggio 2021 (di modifica dell'Intesa del 13 novembre 2008 - Rep. Atti n. 204/CSR). Tutte le notifiche relative all'attivazione di stati di allerta riguardanti alimenti, mangimi e materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, sono trasmesse ai membri della rete utilizzando il sistema informatico iRASFF della Commissione Europea. Le notifiche comprendono tutte le informazioni disponibili in merito al rischio ed al prodotto da cui tale rischio deriva, nonché tutte le informazioni relative alla distribuzione del prodotto.

In caso di coinvolgimento nella rete di commercializzazione di un prodotto oggetto di allerta di OSA insistenti sul territorio regionale, il nodo regionale informa i punti di contatto interessati, trasmettendo le schede di notifica e tutta la documentazione utile al rintraccio dei prodotti non conformi.

I Servizi Veterinari ed i SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. sono deputati a svolgere controlli ufficiali presso gli OSA coinvolti nelle liste di distribuzione di prodotti oggetto di allerta al fine di verificarne la corretta applicazione delle procedure di ritiro/riciamo dal mercato. La verifica presso grossisti/primi destinatari/importatori deve essere svolta sistematicamente anche al fine di acquisire ulteriori liste di commercializzazione; può essere condotta, invece, a campione presso operatori che svolgono attività di vendita di alimenti o di somministrazione diretta al consumatore finale, sulla base di valutazioni che tengano conto della gravità del rischio, del periodo di vita commerciale del prodotto e dell'ampiezza della rete di commercializzazione.

In caso di riscontro di inadempienze sono intraprese azioni sostitutive (sequestro cautelativo del prodotto reperito sul mercato non soggetto a provvedimento di ritiro) necessarie ai fini della tutela della salute pubblica nonché i provvedimenti sanzionatori previsti dal Decreto Legislativo n. 190/2006. Inoltre, l'accertamento di non conformità relativo alle procedure di ritiro (mancata comunicazione del rischio, informazioni inesatte e/o incomplete della lista di distribuzione, etc.) che coinvolgono OSA non insistenti nel proprio ambito territoriale, devono essere comunicate alle AA.SS.LL. interessate e/o al nodo regionale, al fine di consentire ulteriori verifiche e provvedimenti di competenza.

Tutte le informazioni acquisite nel corso dei controlli ufficiali che richiedono l'attivazione di una notifica di allerta o la comunicazione di ulteriori azioni di follow up da intraprendere (a seguito ad esempio di acquisizione di ulteriore lista di distribuzione o di informazioni integrative utili alla gestione del rischio e/o del ritiro del prodotto non conforme) devono essere trasmesse entro il più breve tempo possibile ai membri della rete locali ed al nodo regionale, tramite posta certificata dedicata alla gestione delle notifiche di allerta. Inoltre, ove tali comunicazioni vedano il coinvolgimento di OSA operanti fuori dal territorio regionale,

occorre implementare la piattaforma informatica iRASFF ai fini della validazione del nodo regionale e della dovuta informazione ai membri della rete coinvolti.

SETTORE 27 – OGM

Il Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti rappresenta la realizzazione di una pianificazione unitaria e armonizzata dei controlli per questo specifico settore sia sul territorio che all'importazione. Ciò in applicazione dei due Regolamenti quadro (CE) nn. 1829/2003 e 1831/2003 e del Regolamento UE 2017/625 in quanto il Piano è parte integrante del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) previsto dall'art.109 del regolamento relativo ai controlli ufficiali.

Obiettivi: il Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti, tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2017/625, ha come principale scopo quello di garantire il controllo sull'attuazione della legislazione dell'UE nel settore degli alimenti GM, attraverso l'elaborazione di strategie appropriate al fine di perseguire tale scopo.

L'attuazione del Piano per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza è affidata:

- alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per la programmazione e il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo sul territorio di competenza;
- alle ASL per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo;
- ai PCF (ex PIF, USMAF-SASN) per le attività di controllo sui prodotti di origine non animale destinati all'alimentazione umana presentati all'importazione;
- ai laboratori designati dalle Autorità competenti per il controllo ufficiale (IZS, ARPA, ASL) per l'effettuazione delle analisi di laboratorio;
- al CROGM per quanto riguarda la raccolta e gestione dei dati relativi alle attività di controllo – database CROGM e CRS - e il supporto tecnico per le procedure di analisi in qualità di Laboratorio nazionale di riferimento ai sensi del Regolamento UE 2017/625;
- all'ISS per le revisioni di analisi su campioni di alimenti non conformi.

Il Piano ha validità quinquennale 2023-2027 in linea con la programmazione del Piano di controllo nazionale pluriennale.

Ogni Regione e Provincia Autonoma deve elaborare, in ottemperanza al Piano nazionale, un Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza degli OGM negli alimenti ed individuare un referente ai fini del coordinamento regionale/provinciale del Piano stesso.

Il Piano regionale/provinciale predisposto ed il nominativo del referente devono essere trasmessi al Ministero della Salute – Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio 6 e al CROGM.

CAPITOLO 4 - PIANI DI INTERVENTO ED ASSISTENZA RECIPROCA

SEZIONE A - PIANI DI INTERVENTO

I Piani di Intervento vengono approntati per far fronte alle emergenze che possono sorgere sul territorio regionale.

Per quanto concerne i sistemi d'allarme rapido con delibera di Giunta Regionale n. 1745 del 20.11.2009 si è provveduto ad impartire ai SIAN ed ai Servizi Veterinari le disposizioni da adottarsi in caso di riscontro sul mercato di alimenti e mangimi che non rispondono ai criteri di sicurezza alimentare, così come previsto dal Reg. CE n. 178/2002.

Con la citata delibera è stato istituito nell'ex AGC Assistenza Sanitaria, oggi Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, la sede logistica del "*Nodo Unico Regionale*", dotandolo delle necessarie attrezzature informatiche, tra cui la PEC, e di personale specificamente dedicato che assicura il servizio H 24, compresi i giorni prefestivi e festivi.

Inoltre, per la gestione delle notifiche di allerta, sia il nodo regionale che quelli istituiti a livello Dipartimentale delle ASL territoriali, utilizzano il sistema GISA.

Lo scopo del sistema è quello di consentire una rapida risposta per quanto attiene alle procedure di ritiro e/o richiamo dal mercato del prodotto non conforme, e di registrare in tempo reale i controlli ufficiali presso gli OSA coinvolti nell'allerta.

In Regione Campania è stato approntato, inoltre, dalla ex AGC Assistenza Sanitaria con Decreto Dirigenziale n. 101 del 13.11. 2008, in attuazione del Reg. CE n. 2017/625 l'Unità di crisi per le emergenze relative alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi che non possono essere gestite con le normali procedure sopradescritte.

Allo scopo di garantire una corretta gestione delle emergenze veterinarie, epidemiche e non, e delle emergenze relative alla sicurezza alimentare la Conferenza Permanente fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con l'Intesa dell'8 aprile 2020, Rep. Atti n. 61/CSR, in attuazione dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300, ha approvato il nuovo Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi nel quale, fra l'altro, vengono stabiliti i principi fondamentali d'intervento. Per la gestione di tali emergenze il Ministero, le Regioni e Province Autonome e le Aziende Sanitarie si avvalgono delle seguenti unità di crisi appositamente istituite a livello centrale, regionale e periferico: Unità di Crisi Nazionale – U.C.N., Unità di Crisi Regionale U.C.R. e Unità di Crisi Locale – UCL.

La medesima Intesa 61/CSR ha, inoltre, stabilito nel dettaglio la composizione delle stesse.

La Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26.06.2020 ha recepito l'Intesa n. 61/CSR e con successivo Decreto Dirigenziale n. 296/2020 ha adeguato la composizione dell'Unità di Crisi Regionale per le Emergenze Veterinarie e in Sicurezza Alimentare (UCREVSA) e delle Unità di Crisi Locali (UUCLL) a quanto stabilito dall'Intesa,

integrando le competenze delle stesse con quelle relative alla gestione delle Emergenze non Epidemiche.

Altro strumento fondamentale nella gestione delle emergenze in Regione Campania è rappresentato dal Manuale operativo per la gestione delle emergenze epidemiche, non epidemiche e di quelle connesse alla sicurezza alimentare, ai cui principi basilari si ispirano i Manuali operativi locali istituiti presso le UU.CC.LL., in essere nelle 7 Aziende Sanitarie Locali della Regione.

SEZIONE B - COOPERAZIONE ED ASSISTENZA RECIPROCA

Per la Cooperazione e l'assistenza reciproca, si rimanda alle comunicazioni e disposizioni comunitarie e nazionali.

CAPITOLO 5 – SISTEMA REGIONALE DI AUDIT E VERIFICA DELL’EFFICACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI

Il sistema regionale di audit comprende sia quelli sulle A.C. che gli audit sulle imprese. Si ritiene necessario ed utile descrivere anche le procedure adottate per la verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali. In ogni caso gli audit interni e le supervisioni costituiscono lo strumento principale per verificare la qualità dei controlli svolti e pertanto la qualità delle performance delle A.C.

SEZIONE A – SISTEMA REGIONALE DI AUDIT

La presente sezione descrive il sistema di audit regionale che prevede l’effettuazione di:

1. Audit effettuati dai Servizi dipartimentali delle AA.SS.LL. sulle proprie strutture;
2. Audit effettuati dalla U.O.D. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” della Regione sulla propria struttura;
3. Audit di sistema effettuati dalla U.O.D. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” della Regione sul sistema di gestione dei controlli ufficiali dei Dipartimenti di Prevenzione dell’ASL;
4. Audit di settore effettuati dalla U.O.D. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” della Regione sui Servizi dipartimentali delle AA.SS.LL.;
5. Audit effettuati dai Servizi dipartimentali delle AA.SS.LL. negli stabilimenti/aziende.

Gli audit di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, svolgendosi all’interno del Sistema Sanitario Regionale, sono da considerarsi audit interni e, pertanto, per le modalità della loro effettuazione si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme contenute nella Decisione CE 677/2006 che detta le linee guida per l’effettuazione degli audit di cui all’6 del Reg. (UE) 2017/625. L’obiettivo di tali audit è quello di verificare il grado di efficienza, efficacia ed appropriatezza:

- dei sistemi di gestione delle strutture;
- delle attività di controllo svolte (1.2).

Poiché tutti i Servizi Medici e Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. nonché l’U.O.D. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” della Regione hanno ottenuto la certificazione ISO 9001, gli audit interni si intendono effettuati anche ai fini del sistema di gestione della qualità ISO 9001. Lo scrutinio indipendente stabilito dal punto 2 dell’art. 6 del Reg. (UE) 2017/625 è effettuato dall’ORSA. I rapporti finali degli audit interni sono pubblicati sul sito dello stesso, in modo da garantirne la prescritta trasparenza. Inoltre, il programma di audit e la sintesi delle evidenze riscontrate sono inviate annualmente al Ministero della Salute.

SEZIONE A.1. - AUDIT EFFETTUATI DAI SERVIZI DIPARTIMENTALI DELLE AA.SS.LL. SULLE PROPRIE STRUTTURE;

Con tali tipi di audit i Servizi afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. verificano il funzionamento delle proprie strutture in relazione alle norme generali sul funzionamento delle P.A. oppure per verificare l'efficienza, efficacia ed appropriatezza dei controlli svolti in uno o più dei settori previsti dall'audit universe di cui al precedente Cap. 3. Il campo di tale audit può essere quindi limitato a singole strutture operative ovvero alla intera organizzazione.

I criteri cui fare riferimento per tale tipo di audit sono:

- quelli previsti dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7.2.2013 (standard di funzionamento);
- quelli previsti dalle norme cogenti in materia di pubblico impiego, di procedure della P.A. e di altre norme cogenti che stabiliscono procedure documentate;
- quelli previsti dalle procedure documentate stabilite nel presente P.C.R.P.;
- quelli previsti dalla norma ISO 9001 per quanto applicabili.

Il responsabile del Servizio che commissiona l'audit interno, non può ricoprire l'incarico di auditor né di lead auditor.

SEZIONE A.2. - AUDIT EFFETTUATI DALLA U.O.D. "PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA" DELLA REGIONE SULLA PROPRIA STRUTTURA

Con tali tipi di audit l'U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" della Regione verifica il funzionamento delle proprie strutture. Il campo di tale audit può essere limitato a singole strutture operative ovvero alla intera organizzazione.

I criteri cui fare riferimento per tale tipo di audit sono:

- quelli previsti dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7.2.2013 (standard di funzionamento);
- quelli previsti dalle norme cogenti in materia di pubblico impiego, di procedure della P.A. e di altre norme cogenti che stabiliscono procedure documentate;
- quelli previsti dalle procedure documentate stabilite nel presente P.C.R.P. e dalla Regione;
- quelli previsti dalla norma ISO 9001 per quanto applicabili.

Per l'effettuazione di tali audit, l'U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" della Regione si avvale del Nu.Re.C.U..

Il dirigente dell'U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" della Regione:

- non può ricoprire l'incarico di auditor né di lead auditor essendo il committente dell'audit interno
- è il responsabile del programma di audit
- si avvale del Nu.RE.C.U. per l'effettuazione di tali audit interni

SEZIONE A.3. - AUDIT DI SISTEMA EFFETTUATI DALLA U.O.D. “PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA” DELLA REGIONE SUL SISTEMA DI GESTIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELL’ASL

Con tali tipi di audit l’U.O.D. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” della Regione verifica l’efficienza, efficacia e l’appropriatezza delle attività svolte dalle A.C. territoriali costituite dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione con competenza sulla sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. Il campo di tale audit può essere limitato a singole strutture operative ovvero all’intero Dipartimento.

I criteri cui fare riferimento per tale tipo di audit sono:

- quelli previsti dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7.2.2013 (standard di funzionamento);
- quelli previsti dalle norme cogenti in materia di pubblico impiego, di procedure della P.A. e di altre norme cogenti che stabiliscono procedure documentate;
- quelli previsti dalle procedure documentate stabilite nel presente P.C.R.P.;
- quelli previsti dalla norma ISO 9001 per quanto applicabili.

Il dirigente dell’U.O.D. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” della Regione:

- non può ricoprire l’incarico di auditor né di lead auditor essendo il committente dell’audit interno
- è il responsabile del programma di audit
- si avvale del Nu.RE.C.U. per l’effettuazione di tali audit interni

L’U.O.D. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” della Regione predispone annualmente un programma di audit progettato in modo che nell’arco di cinque anni tutti i Dipartimenti di Prevenzione siano sottoposti ad almeno n. 1 audit interno di sistema.

I risultati di tali audit concorrono all’assegnazione del rating delle ASL.

SEZIONE A.4. - AUDIT DI SETTORE EFFETTUATI DALLA U.O.D. “PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA” DELLA REGIONE SUI SERVIZI DIPARTIMENTALI DELLE AA.SS.LL.

Con tali tipi di audit l’U.O.D. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” della Regione verifica l’efficienza, efficacia e l’appropriatezza delle attività svolte dalle A.C. territoriali in uno degli specifici settori previsti dall’audit universe di cui al precedente Cap. 3. Il campo di tale audit può essere limitato a singole strutture operative ovvero all’intero Dipartimento.

I criteri cui fare riferimento per tale tipo di audit sono:

- le norme cogenti che stabiliscono obblighi di fare, non fare, e procedure documentate
- le procedure documentate stabilite nel presente P.C.R.P.;
- quelli previsti dalla norma ISO 9001 per quanto applicabili

Il dirigente dell’U.O.D. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” della Regione:

- non può ricoprire l’incarico di auditor né di leader auditor nella qualità di committente dell’audit
- è il responsabile del programma di audit
- si avvale del Nu.RE.C.U. per l’effettuazione di tali audit interni

Il programma annuale di audit di settore è predisposto in base:

- al progetto quadriennale di audit di settore che prevede i seguenti due criteri minimi:
 - effettuazione di almeno n. 1 audit nell’arco di quattro anni per ogni settore riportato nello schema di audit universe di cui al Cap. 3
 - effettuazione di almeno n. 1 audit nell’arco di quattro anni per ogni ASL
 - al rating delle AA.SS.LL.;
 - alla necessità dell’esecuzione di audit di follow up per verificare il grado di risoluzione delle osservazioni e raccomandazioni di audit precedenti;
- I risultati di tali audit concorrono all’assegnazione del rating delle ASL.

SEZIONE A.5. - AUDIT EFFETTUATI DAI SERVIZI DIPARTIMENTALI DELLE AA.SS.LL. NEGLI STABILIMENTI/AZIENDE.

Tali audit vengono svolti dalle AA.SS.LL. negli stabilimenti/aziende per verificare se le procedure adottate siano atte e sufficienti ad assicurare un livello di rischio accettabile in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.

La frequenza di tali audit è diversa per ogni tipologia (registrato o riconosciuto) e categoria di rischio dello stabilimento auditato.

Il fatto che tutti i Servizi di Igiene degli alimenti ed i Servizi Veterinari delle ASL campane sono in possesso della certificazione ISO 9001, non comporta che per l’effettuazione di tale tipo di audit vengano utilizzate le procedure della norma ISO 19011; tale norma resta applicabile solo all’interno di un sistema di certificazione di qualità che, evidentemente, non può essere imposto alle imprese private. Pertanto, le procedure da utilizzare sono quelle contenute nelle norme cogenti e quelle contenute nei Regolamenti del cosiddetto “pacchetto igiene”. Nemmeno la Dec. CE 677/06 risulta applicabile in tale tipo di audit essendo la norma di riferimento specifica per gli audit interni. In ogni caso, al fine di uniformare il linguaggio da utilizzare, verranno utilizzate le definizioni delle norme ISO.

In particolare, tali audit vengono effettuati nei seguenti casi:

- quando sono previsti dalla categoria di rischio dello stabilimento/azienda;
- su indicazione regionale ovvero quando gli stessi Servizi territoriali, in base ad una valutazione del rischio, intendano rivolgere l’attenzione su un particolare settore produttivo.

SEZIONE B - VERIFICA DELL'EFFICACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI (SUPERVISIONI)

Ai sensi del D.C.A. 2/10/03, n. 97, la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali si attua mediante l'effettuazione di supervisioni.

Lo scopo dell'attività di supervisione è, nel breve periodo di porre rimedio ad eventuali carenze dei

controlli ufficiali attraverso la verifica dell'efficacia degli stessi e, nel medio e lungo periodo, di migliorare il livello medio di efficacia attraverso attività collaterali quali la formazione/simulazione e/o affiancamento.

Il Reg. (UE) 2017/625 stabilisce, al paragrafo 2, art. 12 che le autorità competenti dispongono di procedure di verifica dei controlli. Il co. 3. prevede che le autorità competenti:

- a) adottino azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevino carenze;
- b) aggiornano secondo necessità le procedure documentate.

In Regione Campania sono state decretate le procedure operative delle attività di supervisione A3 e verifica dell'efficacia controlli ufficiali, previste dall'art. 8, punto 3 del Reg. CE n. 882/2004 e che, come da Tavola di concordanza di cui all'All. V del Reg (UE) 2017/625, aderisce al dettato del paragrafo 2, art. 12 del Reg. (UE) 2017/625.

In sostanza i due momenti concorrono entrambi al raggiungimento di un elevato ed omogeneo livello di efficienza ed efficacia dei controlli ufficiali.

Una efficace attività di supervisione deve prevedere il controllo di tutte e tre le fasi del processo "controllo ufficiale" e, precisamente, prima dei controlli (supervisione ex ante), durante i controlli (supervisione in tempo reale) e dopo i controlli (supervisione ex post).

Le attività di supervisione hanno come oggetto del controllo le attività ispettive svolte in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria dagli operatori sanitari delle AA.SS.LL. (medici, medici veterinari, TT.PP.AA.LL., altri funzionari laureati) che rivestono il ruolo di Autorità Competente territoriale nelle materie sopracitate.

Le attività di supervisione vengono svolte:

- dai Responsabili di Struttura Semplici e Complesse delle AASSLL che, al fine di incrementare il livello scientifico delle attività di supervisione, possono effettuarla anche attraverso l'interazione con uno dei Centri di Riferimento del Polo Integrato;
- dal Nu.Re.C.U.

I supervisori utilizzano le norme comunitarie, nazionali e regionali, nonché le procedure documentate regionali o territoriali come criteri per valutare l'appropriatezza, l'efficacia e la qualità dei controlli ufficiali.

Le attività di supervisione vengono distinte in:

- Tipo 1 - attività di supervisione su controlli ufficiali svolti nei sette giorni precedenti dal personale incaricato che abbiano avuto esito favorevole o il rilievo di non

conformità esclusivamente formali (supervisione ex post);

- Tipo 2 - attività di supervisione per la verifica del livello di know how del personale addetto ai controlli ufficiali in merito all'applicazione delle procedure (supervisione in tempo reale);
- Tipo 3 - attività di supervisione *documentale* (supervisione ex post);
- Tipo 4 - attività di supervisione *mediante simulazioni* (supervisione ex ante).

Il Nu.Re.C.U. effettua soltanto le supervisioni di tipo 2.

Le modalità di espletamento delle supervisioni sono riportate nell'apposita procedura documentata: Procedura attività A3 (a-b-c-d) – SUPERVISIONI- rev.1/2022.

CAPITOLO 6 - CRITERI OPERATIVI E PROCEDURE

(CAPITOLO APPLICABILE SOLO ALLE AA.SS.LL.)

Nel presente capitolo vengono descritte:

1. le linee di indirizzo regionali affinché le A.C. garantiscano il rispetto dei criteri operativi previsti dal Reg. (CE) n. 2017/625 e dalla Decisione 2021/C 78/01
2. le procedure documentate che le A.C. devono seguire nel corso dei controlli ufficiali e degli adempimenti d'ufficio
3. le modalità di registrazione dei controlli ufficiali.

SEZIONE A – RISPETTO DEI CRITERI OPERATIVI

I criteri operativi che le AA.SS.LL. devono applicare sono stabiliti dalla Regione mediante l'adozione di atti normativi tra i quali il presente P.C.R.P..

SEZIONE A.1. - CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI

La programmazione e la gestione dei controlli da parte delle A.C. sono imperniata sui seguenti criteri:

1. ottenimento di una anagrafica completa degli stabilimenti/aziende e delle linee d'attività in essi svolte;
2. categorizzazione di rischio "quantitativa" delle linee di attività svolte negli stabilimenti;
3. categorizzazione di rischio "qualitativa" degli stabilimenti/aziende;
4. identificazione e quantificazione delle risorse esistenti;
5. identificazione degli obiettivi operativi e loro classificazione in base alle priorità (DPAR);
6. approntamento di un sistema per la quantificazione delle performance minime ad personam;
7. approntamento di un sistema per la quantificazione delle performance minime di struttura;
8. assunzione della competenza ad effettuare i controlli pianificati a livello regionale con il DPAR;
9. programmazione dei controlli a farsi in base al numero delle performance minime in possesso (DPAT);
10. svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo ufficiale (profilassi di Stato, certificazioni export, ecc.);
11. identificazione delle modalità del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.

SEZIONE A.1.1. – OTTENIMENTO DI UNA ANAGRAFICA COMPLETA DEGLI STABILIMENTI/AZIENDE E DELLE LINEE D'ATTIVITÀ IN ESSI SVOLTE

Presupposto fondamentale per la programmazione e l'organizzazione dei controlli è il censimento degli stabilimenti, sia in sede fissa che mobile, dei privati possessori di animali e di qualsiasi altra attività soggetta a controllo; il censimento ha come obiettivo la costituzione di una anagrafica completa e aggiornata.

L'ottenimento di una anagrafica completa degli stabilimenti soggetti a controllo deve necessariamente basarsi su presupposti specifici e univoci. Questi presupposti sono imperniati sui concetti di

- impresa
- stabilimento
- linea d'attività

IMPRESA (soggetto fisico o giuridico o associazione che conduce lo stabilimento) caratterizzata da:

- nome del titolare/ditta/ragione/denominazione sociale
- residenza del titolare o sede legale
- identificativo fiscale (C.F. o P. IVA)
- rappresentante legale (se associazione o persona giuridica)

STABILIMENTO (luogo fisico dove viene svolta l'attività lavorativa) caratterizzato da:

- coordinate geografiche
- indirizzo

(N.B. una impresa può condurre uno o più stabilimenti)

LINEA D'ATTIVITÀ (caratterizzazione specifica dell'attività svolta) caratterizzata da:

- denominazione della o delle linee di attività svolte nello stabilimento. L'elenco di tutte le linee d'attività coinvolte nel Sistema di Gestione dei controlli ufficiali di cui al presente P.C.R.P. è contenuto nelle master list previste dalla DGRC n. 318/15 e s.m.i. (N.B. in uno stabilimento possono essere svolte una o più linee di attività).

Il sistema informatico GISA e quello BDU "Anagrafe canina" sono gli strumenti informatici unici regionali dove sono presenti le anagrafiche e dove sono registrati tutti i dati relativi ai controlli ufficiali effettuati. Le procedure per la notifica degli stabilimenti da registrare ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e il rilascio dell'approval number per gli stabilimenti da riconoscere ai sensi dei Regolamenti CE n. 852/2004, 853/2004, 183/2005 e 1069/2009, sono stabiliti dalla DGRC 318/15 e s.m.i.

Si proseguirà ad ampliare lo strato di interoperabilità di GISA al fine di automatizzare il più possibile le interazioni con gli sportelli SUAP.

SEZIONE A.1.2. - CATEGORIZZAZIONE DI RISCHIO “QUANTITATIVA” DELLE LINEE DI ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI STABILIMENTI

(Il nuovo sistema di classifica del rischio delle imprese è stato elaborato in collaborazione con gli esperti dell’OCSE, nell’ambito del **Progetto RAC** - Rating Audit Control)

Ai fini di una corretta programmazione dei controlli ufficiali, tutte le linee di attività svolte negli stabilimenti/aziende devono essere categorizzate in base al rischio accertato sul campo o in base alla tipologia di attività; l’assegnazione del “rating” stabilito dall’art. 3 punto 31 del Reg (UE) 2017/625 è sinonimo di “categorizzazione di rischio”. La categorizzazione di rischio delle linee d’attività è “quantitativa” in quanto ottenuta esclusivamente mediante la somma dei punteggi dei fattori di rischio rilevati e delle non conformità.

Le tre classi di rischio previste dall’Accordo Stato-Regioni 212/2016 e dalle altre norme ministeriali in merito, sono state valutate insufficienti a rimarcare la differenza di rating tra le linee d’attività in base al loro rischio “ipotetico”; a puro titolo d’esempio era necessario ampliare la forbice del rating tra un piccolo bar ed una grande industria che lavora alimenti per bambini. Pertanto, in applicazione della legittima autonomia gestionale, in Regione Campania il numero delle classi di rischio è ampliato a cinque, fermo restando che sia in fase di rendicontazione per i flussi dati ministeriali, sia in fase di programmazione dei controlli, si opererà una necessaria aggregazione secondo il seguente schema:

Classe di rischio nazionale	Classe di rischio regione Campania
Bassa	1
	2
Media	3
	4
Alta	5

Tale sistema classifica il rischio delle imprese alimentari in due fasi: una prima fase, basata su criteri statici, utile a definire una categorizzazione preliminare o di default e una seconda fase, basata su criteri dinamici e tecnici (checklist), utile a definire una categorizzazione definitiva (per definitiva si intende una categorizzazione della durata stabilita dalla normativa vigente).

I **CRITERI STATICI** sono dati da:

- Tipologia di attività
- Entità produttiva
- Ambito di commercializzazione

La tipologia di produzione è definita dalla masterlist (versione più recente) dove per ciascuna linea categorizzabile viene definito un valore di default.

Questa categoria, che corrisponde alla ex-ante attuale, deve comparire sulla linea di attività nel momento in cui entra nell’anagrafica di GISA.

Tutte le linee di attività che non hanno avuto una categorizzazione, ma che già sono presenti

in anagrafe, devono riportare la categoria stabilita dalla masterlist. (Circolare Ministeriale n. DGISAN 13/3/6238/P del 31.5.2007).

All'atto del controllo ufficiale per la categorizzazione del rischio, le A.C. devono procedere all'assegnazione del rating definitivo per ogni singola linea d'attività svolta attraverso la redazione degli allegati alla procedura documentata:

- Entità produttiva - prevede 15 domande a risposta esclusiva SI o NO. Ad ogni risposta è associato un punteggio.
- Ambito di commercializzazione - varia a seconda della tipologia di produzione.

I **CRITERI DINAMICI** sono dati da:

– **caratteristiche strutturali e produttive + PARTE SPECIALE**

Si tratta della checklist vera e propria, con 14 capitoli, ciascuno contenente un numero variabile di domande per un totale di 104. Le risposte a ciascuna domanda prevedono tre opzioni:

- COMPLETAMENTE CONFORME
- NON COMPLETAMENTE CONFORME
- NON CONFORME

Ogni risposta avrà un punteggio associato.

Tale checklist verrà utilizzata per la maggior parte delle linee di attività.

Per alcune tipologie di attività, potranno essere aggiunte delle domande specifiche che costituiranno la "PARTE SPECIALE".

– **provvedimenti adottati in corso di controllo ufficiale**

Nel caso durante la categorizzazione del rischio siano stati presi dei provvedimenti questi dovranno essere indicati tra quelli elencati nell'allegato de quo. La parte prevede 11 domande a risposta esclusiva SI o NO. Ad ogni risposta è associato un punteggio.

A ciascun criterio della categorizzazione viene attribuito un peso percentuale che contribuirà alla definizione della categoria di rischio e dunque alla frequenza di controllo.

La formula per il calcolo della categorizzazione è la seguente:

$$\text{Categoria di rischio} = [(A+B) \times 0.3] + (C \times 0.1) + [(D + E) \times 0.4]$$

- A. tipologia attività
- B. criteri statici - mercato
- C. criteri statici – entità di produzione (in caso di commercio valore 0)
- D. provvedimenti (presi in corso di controllo per categorizzazione)
- E. criteri dinamici (per alcune linee di attività vengono fornite delle domande aggiuntive che si aggiungono al punteggio ottenuto da E).

Una volta completati tutti gli allegati della procedura documentata si applicherà la formula categorizzazione del rischio. I risultati possono essere fra due estremi: valore minimo e valore massimo.

- Valore minimo calcolato nella formula $[(50+50) \times 0.3] + (50 \times 0.1) + [(50 + 50) \times 0.4] = 75$
- Valore massimo calcolato nella formula $[(200+200) \times 0.3] + (200 \times 0.1) + [(200 + 200) \times 0.4] = 300$

Da cui si ottiene:

- Rischio basso= da 75 a 149
- Rischio medio= da 150 a 225
- Rischio alto= > 225

Classe	Punteggio
1	≤ 112
2	$112 < x < 149$
3	$150 < x < 188$
4	$188 < x < 225$
5	≥ 225

L'ispezione per la categorizzazione del rischio rappresenta la tecnica maggiormente idonea ad attribuire la categoria di rischio delle linee d'attività e, conseguentemente, degli stabilimenti che ineriscono le materie di competenza del presente P.C.R.P. e può validamente rappresentare il migliore strumento per l'attribuzione della categoria di rischio delle linee d'attività degli stabilimenti (cosiddetto "rating"). In effetti, nel Regolamento UE 2017/625 viene introdotto il termine "*screening mirato*" assimilabile al concetto di ispezione per la categorizzazione del rischio. Ciò in quanto nel corso dell'ispezione per la categorizzazione del rischio devono essere espletate tutte le possibili verifiche per accertare la conformità degli alimenti, dei prodotti primari, dei mangimi, dello stato di salute e benessere degli animali, delle strutture e delle attrezzature, della sanità delle piante nonché la rilevazione dei fattori di rischio, con la sola esclusione della verifica ispettiva dell'autocontrollo, per il quale si ritiene sia più appropriato l'audit.

All'assegnazione del rating fanno eccezione:

- alcune linee di attività a sede fissa per le quali non si è ravvisato opportuna l'assegnazione del rating in quanto scarsamente influenti sul S.G.C.U. come, ad esempio, le attività temporanee (sagre, fiere, ecc.);
- linee d'attività che, non avendo una sede fissa, non possono soggiacere a controlli programmati in ragione della peculiarità della linea di attività espletata; tali linee, quali ad esempio il trasporto, gli ambulanti (sia in forma itinerante che a posto fisso), le imbarcazioni da pesca, i circhi, etc. non sono inquadrabili in una categoria di rischio;

- gli allevamenti zootecnici il cui rating viene generato dal sistema nazionale Classyfarm.

Gli stabilimenti dove vengono svolte tali linee d'attività non sono sottoposti ad ispezione per la categorizzazione del rischio, ma solo ad ispezioni.

Una volta effettuata l'ispezione per la categorizzazione del rischio dello stabilimento, i risultati numerici delle check list comporteranno l'attribuzione del reale livello di rischio delle linee di attività. Da quel momento in poi, le linee d'attività saranno sottoposte ai controlli ufficiali previsti per una delle cinque classi di rischio in cui è stato compreso.

Nel corso degli anni, il rating delle singole linee d'attività e conseguentemente dell'intero stabilimento può essere riconfermato o può subire variazioni in positivo od in negativo. L'ispezione per la categorizzazione del rischio rappresenta pertanto una sorta di punto "0" utilizzato per fare il punto della situazione in base alle risultanze di tutti i controlli effettuati tra una categorizzazione del rischio e l'altra.

Criteri e modalità da utilizzare per l'attribuzione del rating in tutti i tipi di stabilimento sono riportati in apposita procedura operativa.

Al sistema descritto fa eccezione la categorizzazione del rischio degli stabilimenti SOA. I SOA sono classificati in base al loro rischio sanitario in tre categorie (1, 2 e 3), secondo un'unica checklist appositamente redatta.

AGGIORNAMENTO ANNUALE: L'aggiornamento della categoria di rischio verrà condotto in automatico nel sistema GISA annualmente sulle imprese/linee, che hanno avuto almeno un controllo ufficiale nel corso dell'anno:

- **nel caso di contestazione di non conformità verrà incrementato il punteggio di rischio.**
- **Nel caso di controlli ufficiali con esito positivo** ossia assenza di non conformità, sanzioni, provvedimenti, diffide e follow up, **il punteggio andrà ridotto.**

Tale aggiornamento, condotto annualmente, è indipendente dal numero di controlli ufficiali effettuati. Nel caso di più controlli con esiti differenti verrà considerato lo scenario peggiore (ad esempio 2 cu con esito positivo e 1 con esito negativo comporterà solo l'aumento di punteggio).

MECCANISMO PREMIANTE:

Il servizio digitale GISA Autovalutazione consente, agli operatori attivi, di effettuare una autovalutazione delle linee di attività del proprio stabilimento, utilizzando le stesse check list applicate dall'Autorità Competente durante i controlli ufficiali effettuati per la categorizzazione del rischio. Ogni check list mostra le domande riferite all'attività produttiva scelta e ha associato un valore numerico che è tanto più alto quanto maggiore è il rischio ad esso correlato. In base alle risposte fornite alle domande della check list, l'applicativo calcolerà in automatico un punteggio relativo alla specifica check list ottenuto sommando i

valori numerici che scaturiscono da ciascuna risposta.

In prospettiva futura, in occasione del Controllo Ufficiale di categorizzazione del rischio, qualora l'AC riscontri un miglioramento, o almeno un'invarianza, del punteggio relativo alla stessa check list utilizzata durante il suo ultimo self assessment, ridurrà il punteggio della classe di rischio ottenuto durante l'effettivo controllo ufficiale di assegnazione della categoria del rischio. Viceversa, l'incongruenza, anche in una sola risposta, tra l'ultimo self assessment e la check list del controllo ufficiale farà perdere il vantaggio del meccanismo premiante. Seguiranno circolari esplicative in merito.

SEZIONE A.1.3. - CATEGORIZZAZIONE DI RISCHIO “QUALITATIVA” DEGLI STABILIMENTI/AZIENDE

Oltre alla categorizzazione di rischio delle linee d'attività è necessario procedere anche ad un rating dell'intero stabilimento ove vengono svolte le linee d'attività. Tale categorizzazione è definibile come “qualitativa” e ovviamente deve scaturire dal rating delle singole linee di attività. Il rating degli stabilimenti traduce in termini qualitativi il rating quantitativo delle linee di attività secondo il seguente schema:

Categoria di rischio media quantitativa	Categoria di rischio qualitativa
0 – 3.5	Rischio basso
3.5 – 4.4	Rischio medio
4.5 – 5 (0 >5)	Rischio alto

SEZIONE A.1.4. – IDENTIFICAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI

È necessario che ogni Servizio e struttura operativa delle A.C. territoriali faccia una ricognizione delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali. A tal proposito è cura del loro responsabile:

- approntare e tenere aggiornato un organigramma;
- approntare e tenere aggiornata una lista dei beni strumentali in uso, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, ai computer, ed ai telefoni e fax;
- identificare le risorse finanziarie (se disponibili), rendicontare le spese sostenute e programmare le esigenze secondo le procedure in uso all'Azienda.

Quanto sopra deve essere inserito nei DPAT secondo le procedure stabilite dalla Regione.

SEZIONE A.1.5. – IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI E LORO CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLE PRIORITÀ (DPAR);

Come anticipato al Cap. 1, il presente P.C.R.P. prevede la redazione dei Documenti di Programmazione Annuale Regionale (DPAR) redatti dal Punto di Contatto regionale. Tali DPAR

contengono la maggioranza degli obiettivi operativi ideati quali strumenti per il raggiungimento degli obiettivi strategici. Gli obiettivi operativi contenuti nei DPAR sono suddivisi in:

- Piani di Monitoraggio
- Attività

Ogni obiettivo è qualificato in base al fatto se prevede l'esecuzione di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali.

Inoltre, gli obiettivi operativi sono suddivisi in base alla priorità assegnata. Tale priorità è data in ordine decrescente:

Inoltre, gli obiettivi operativi sono suddivisi in base alla priorità assegnata. Tale priorità è data in ordine decrescente:

- alle attività obbligatorie che sono compiti specifici ed inderogabili del SSR (Attività Obbligatorie – **AO**)
- ai piani di monitoraggio ed attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione come inseriti nel Nuovo Sistema di Garanzia nazionale per il monitoraggio dei LEA (Sez. **A** del DPAR);
- agli altri piani di monitoraggio ed attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione (Sez. **B** del DPAR);
- alle residuali attività e piani di monitoraggio conoscitivi (Sez. **C** del DPAR);

SEZIONE A.1.6. – APPRONTAMENTO DI UN SISTEMA PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE PERFORMANCE MINIME AD PERSONAM

Il Sistema Sanitario Regionale deve reggersi sulla individuazione di obiettivi di salute raggiungibili attraverso azioni efficienti e misurabili. Questo processo richiede un grande impegno che vede protagonisti gli operatori sanitari pubblici. L'erogazione del servizio reso dai singoli operatori e, conseguentemente, i volumi prestazionali delle strutture delle AA.SS.LL. cui essi appartengono deve essere pianificato e programmato in ambito territoriale perseguendo livelli di ottimizzazione e di efficienza. D'altronde:

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni (su base triennale);
- la legge 208/2015, art. 1, comma 541 (finanziaria 2016) prevede, tra l'altro che le Aziende Sanitarie predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- il D.Lgs. 150/2009 ha recato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevedendo, tra l'altro, disposizioni concernenti la misurazione, valutazione e trasparenza della

performance e la valorizzazione del merito dei dipendenti. Tuttavia, gran parte delle norme contenute nel citato decreto, ai sensi del D.Lgs. 74/2017 che modifica il predetto D.Lgs. 150/2009, non hanno trovato ancora diretta applicazione nei confronti degli enti territoriali ed in particolare delle amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale essendo necessario un adeguamento da parte delle Regioni.

Compito della Regione è quindi quello di fornire alle strutture organizzative territoriali criteri omogenei affinché esse possano stabilire gli obiettivi minimi ad personam del personale afferente ai Servizi Veterinari (SV) ed ai SIAN, e conseguentemente delle strutture/unità organizzative nelle quali i S.V. ed i SIAN sono organizzati (performance individuali e di struttura).

La difficoltà nello stabilire tali criteri è causata soprattutto dal fatto che l'offerta in termini prestazionali è strutturata in maniera completamente atipica rispetto alle altre strutture delle aziende sanitarie. Infatti, mentre negli ambulatori medici distrettuali o negli ospedali le prestazioni vengono svolte in loco attraverso l'affluenza nei relativi reparti/ambulatori degli utenti, nel Dipartimento di Prevenzione, ed in particolare nei S.V. e SIAN, gli operatori svolgono la preponderante parte delle loro prestazioni all'esterno delle strutture dell'azienda sanitaria recandosi presso gli stabilimenti ove di fatto vengono svolte le attività di vigilanza e controllo. Dunque, di norma, è l'operatore sanitario che si reca presso le strutture soggette a controllo con tutte le conseguenze operative immaginabili (disponibilità di automezzi, difficoltà nello spostamento etc).

In considerazione del fatto che:

- ad oggi, non sono ancora state emanate dal Ministero della Salute linee generali di indirizzo finalizzate all'individuazione delle performance minime, né è stato ancora formalizzato un accordo con le OO.SS. a livello regionale;
- il sistema adottato dalla Regione Campania in via sperimentazione nei precedenti Piani Regionali Integrati deve ormai essere considerato un vero e proprio *benchmark* come testimoniato dall'interessamento a livello nazionale ed al relativo trasferimento del know-how già in atto in alcune realtà di altre Regioni;
- ai sensi dell'art. 24 comma 1 del CCNL 19/12/2019 Dirigenza area Sanità prevede tra l'altro che *"...i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure previste dal presente CCNL in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, anche ai fini dell'erogazione dei premi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi..."*

possono continuare ad essere applicati, sempre in via sperimentale e con le opportune modifiche migliorative, i criteri del precedente PCRP 2020-2022.

Tali criteri, come di seguito dettagliati, sono funzionali ad effettuare la programmazione delle attività da parte della Regione e rappresentano il modello medio di base, ai fini della definizione del valore finale delle performance individuali e di struttura (U.I.P. e U.P.S.), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 40 del D. Lgs n. 165/2001 e dagli artt. 5, 7 comma 5, lett. b), 14 e 24 del CCNL area Sanità del 19/12/2019.

Uno dei principi cardini, ormai consolidato grazie all'esperienza maturata in questi anni di sperimentazione, è che il calcolo delle performance minime delle strutture delle AA.SS.LL. deve scaturire direttamente e proporzionale alle performance minime delle singole persone afferenti a tali strutture.

L'individuazione delle performance minime richieste alla dirigenza, agli specialisti ambulatoriali ed al personale del comparto, nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, è finalizzato, tra l'altro, a:

- definire tra gli organi di vertice aziendali, la dirigenza, gli specialisti ambulatoriali ed il comparto, nell'ambito delle rispettive competenze, le prestazioni minime quali-quantitative da assegnare ai singoli operatori per lo svolgimento dei compiti d'istituto;
- definire le prestazioni aggiuntive quali-quantitative da assegnare ai singoli dirigenti, in aggiunta a quelle assegnate ed espletate di cui al precedente punto, e correlate a prestazioni aggiuntive di cui all'art. 24 comma 6 del CCNL 19/12/2019 Dirigenza area Sanità;
- definire le prestazioni aggiuntive quali-quantitative da assegnare ai singoli specialisti ambulatoriali, in aggiunta a quelle assegnate ed espletate di cui al primo punto, e correlate a prestazioni aggiuntive ex Accordo integrativo Regionale del 5/8/2020;
- dare, in via sperimentale, un elemento basilare per la misurazione delle performance sia dei singoli operatori che delle strutture cui essi appartengono.

Tenuto conto:

1. dell'assenza di indicazioni legislative tese a stabilire i tempi medi per l'effettuazione dei controlli;
2. della variabilità del tempo necessario all'espletamento dei controlli che è causata:
 - dalle innumerevoli possibili azioni da svolgersi nel corso del controllo ufficiale;
 - dalla variabilità dell'intensità del controllo causata dalla innumerevole diversità delle linee d'attività controllate;
 - dalla differenza intrinseca delle varie tecniche di controllo (ispezione - audit - ispezione per la categorizzazione del rischio);
 - del tempo necessario al raggiungimento dello stabilimento oggetto del controllo, che varia in funzione dell'orografia, del mezzo di trasporto utilizzato, della facilità di raggiungimento, del traffico veicolare ecc.
3. delle attività istituzionali non legate all'espletamento di controlli ufficiali quali ad esempio la ricezione del pubblico, l'educazione alla salute, l'inserimento dati nel sistema informatico, la necessità di partecipare a riunioni, la necessità di esplicitare le più svariate attività burocratiche, la partecipazione a cause giudiziarie, ecc.
4. delle attività di Polizia Giudiziaria sia pre che post ispettive,

si ritiene di stabilire quale unità di misura base per la quantizzazione delle attività di controllo ufficiale svolto dal personale della A.C. *l'unità/ispezione di persona* (U.I.P.), cioè il tempo stimato affinché un funzionario dell'A.C. mediamente effettui una ispezione che può

essere definita “semplice”. Tale impegno orario è comprensivo anche del tempo necessario all’espletamento di attività non propriamente legate al controllo, ma facenti parte dei compiti istituzionali (punti 3 e 4 sopradescritti). L’U.I.P. è quantizzata in n. 4 ore. Dividendo il monte ore annuale di ogni operatore (ad es. 1454 ore equivalenti alle ore medie lavorate in un anno dal personale dirigenziale, come da indicazioni ministeriali) per n. 4 ore, si definisce il numero di U.I.P. attribuito al singolo operatore.

La U.I.P. rappresenta, quindi, l’unità di misura per la quantizzazione dei controlli cui il singolo operatore deve partecipare nell’anno. Il numero di controlli espresso in U.I.P. cui il singolo operatore deve partecipare costituisce la performance minima ad personam.

Ogni ispezione semplice determina l’impegno di n. 1 U.I.P. del personale che ha effettuato l’ispezione, a prescindere dalla tipologia di azienda ovvero operatore che ha ispezionato, dall’intensità del controllo e, dalle operazioni che ha effettuato durante e dopo il controllo. Il sistema nazionale e regionale delle master list prevede che in uno stabilimento possano essere svolte una o più linee d’attività (terza colonna delle master list). Tutti i controlli ufficiali (ispezione, audit, etc) non si riferiscono allo stabilimento in toto, ma alle singole linee di attività in esso svolte, nel senso che ad ogni singola linea d’attività controllata corrisponde l’effettuazione di un controllo.

Poiché le U.I.P. sono un indicatore di performance ad personam, nel caso in cui l’ispezione sia stata effettuata congiuntamente da più persone, ognuna di loro ha impegnato una propria U.I.P.

Si riporta di seguito lo schema delle tecniche di controllo e il loro relativo impegno in U.I.P.:

TECNICA	DURATA ORARIA MEDIA	NOTE
Ispezione “semplice”	n. 1 U.I.P. (4 ore)	L’effettuazione da parte di una squadra di più ispezioni semplici nello stesso giorno su diverse linee di attività del medesimo stabilimento comporta il consumo di: • n. 1 U.I.P. per ogni persona della squadra relativamente alla prima ispezione semplice • n. 0.5 U.I.P. per ogni persona della squadra per ogni ispezione semplice successiva alla prima
Ispezione per la categorizzazione delle imprese	n. 1.48 U.I.P. (circa 6 ore)	L’effettuazione da parte di una squadra di più ispezioni “complesse” nello stesso giorno su diverse linee di attività del medesimo stabilimento comporta il consumo di: • n. 1.48 U.I.P. per ogni persona della squadra relativamente alla prima ispezione complessa • n. 0.74 U.I.P. per ogni persona della squadra per ogni ispezione complessa successiva alla prima
Ispezione “fast”	0.25 U.I.P. (1 ora)	n. 0.25 U.I.P. per ogni persona della squadra.
Attività giornaliera di ispezione carni al macello	n. 1 U.I.P. (4 ore) per sessione di macellazione	All’ispezione per macellazione non si applica l’abbattimento per l’ispezione “semplice” di cui alla nota sopra riportata.
Audit	n. 3.7 U.I.P. (14.8 ore)	L’effettuazione da parte di una squadra di più audit nello stesso giorno su diverse linee di attività del medesimo stabilimento comporta il consumo di: • n. 3.7 U.I.P. per ogni persona della squadra relativamente alla prima linea sottoposta ad audit • n. 1.85 U.I.P. per ogni persona della squadra per ogni audit successiva alla prima
Supervisione mediante simulazioni (supervisione tipo 4)	n. 1.5 U.I.P. (6 ore)	Le supervisioni tipo 1 e 2 sono equiparate ad “ispezioni semplici”

Restano fermi i livelli di contrattazione e l’autonomia aziendale di cui all’art. 40 del D.lgs 165/2001 s.m.i. nonché quanto previsto dai predetti artt. 5, 7 comma 5, lett. b), 14 e 24 del CCNL area Sanità del 19/12/2019 Dirigenza area Sanità per quanto attiene i volumi prestazionali. In tal caso, fermo restando le U.I.P. sopra indicate ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole Aziende sanitarie, il numero totale di U.I.P. per singole equipe od operatore possono essere rimodulate in ambito aziendale.

SEZIONE A.1.7. – APPRONTAMENTO DI UN SISTEMA PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE PERFORMANCE MINIME DI STRUTTURA

Per il calcolo dei volumi prestazionali delle Strutture ovvero degli incarichi di altissima specializzazione laddove gli stessi sono assegnati e gestiscono risorse umane, viene stabilita come unità di misura *l'unità di performance di struttura* (U.P.S.). Le U.P.S. di ogni struttura si ottengono sommando (con opportune formule riduttive) le U.I.P. delle persone ad essa afferenti; per stabilire i criteri per le formule riduttive è necessario tenere conto anche della deliberazione n.72/2013 dell'ANAC, all. 4, ove si prescrive che di norma i controlli sono affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. La U.P.S. costituisce quindi l'unità di misura per la quantizzazione dei controlli che devono essere espletati da ogni struttura. Con tale meccanismo si ottiene l'evidenza oggettiva della capacità di espletamento dei controlli di ogni struttura semplice e di ogni struttura complessa. Infatti, in tal modo viene definita la quantità minima di controlli in

U.P.S. che ogni Struttura semplice deve svolgere nell'anno. Il numero di U.P.S. costituisce, pertanto, la performance di struttura.

La somma delle U.P.S. di ogni struttura semplice, ovvero delle singole unità, afferenti ad una Struttura Complessa, definisce la quantità minima di controlli in U.P.S. che tale Struttura Complessa deve svolgere nell'anno.

Le ispezioni semplici e gli audit non si riferiscono allo stabilimento in toto, ma alle singole linee di attività in esso svolte, nel senso che ad ogni singola linea d'attività controllata corrisponde l'effettuazione di una ispezione semplice o di un audit.

Tutte le tipologie di ispezione sono svolte sulle singole linee di attività presenti negli stabilimenti e comportano un consumo di UPS pari al valore assegnato in programmazione ai singoli motivi del controllo. Nel caso un controllo sia svolto per due o più motivi il consumo di UPS sarà pari alla somma del valore assegnato in programmazione a ciascun motivo (per motivo di intendono i piani e le attività programmate nel DPAR). Poiché l'audit viene svolto quasi sempre da due auditors ed in misura meno frequente da tre auditors, si ritiene corretto che determini l'impegno di n. 3.7 U.P.S..

La verifica del raggiungimento delle performance delle strutture viene svolta rapportando le U.P.S. svolte/U.P.S. minime da svolgere nell'anno.

Al fine di consentire il costante monitoraggio sul corretto ed esaustivo svolgimento delle attività assegnate è stata implementata nell'applicativo Di.Ge.Mon. del sistema GISA la funzionalità **"Performance"**. Tale funzionalità si basa sul sistema di calcolo delle performance e consente di verificare costantemente lo stato di avanzamento delle attività effettuate dalle singole articolazioni dei Dipartimenti di Prevenzione competenti in materia di Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare e del relativo personale: la funzionalità riporta puntualmente sia lo stato di utilizzo delle U.P.S. che delle U.I.P.

SEZIONE A.1.8. – ASSUNZIONE DELLA COMPETENZA AD EFFETTUARE I CONTROLLI PIANIFICATI A LIVELLO REGIONALE CON IL DPAR;

Annualmente nella redazione del proprio DPAT, ogni struttura identifica quali sono i piani di monitoraggio e le attività per i quali riveste il ruolo di A.C. a svolgerne i controlli.

SEZIONE A.1.9. – PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI A FARSI IN BASE AL NUMERO DELLE PERFORMANCE MINIME IN POSSESSO (DPAT);

Una volta stabilita la disponibilità minima dei volumi prestazionali in U.P.S., ogni Struttura a carattere gestionale delle AA.SS.LL. procederà alla quantificazione dei propri obiettivi conformemente agli obiettivi regionali riportati nei DPAR.

La programmazione degli obiettivi è comunque soggetta a possibili variazioni a causa di emergenze e per variazioni delle risorse disponibili.

SEZIONE A.1.10. – SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

Le AA.SS.LL. rappresentano le A.C. a svolgere controlli ufficiali ed altre attività ufficiali nelle materie di cui al Reg UE 2017/625. Tale tipologia di controlli rappresentano la mission delle strutture dipartimentali delle AA.SS.LL. e sono mirati al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al Cap. 2.

La frequenza, l'intensità e la tecnica dei controlli nelle linee di attività degli stabilimenti, vengono programmati in base alla categoria di rischio secondo quanto indicato nelle specifiche Procedure Regionali, così come richiamate nel Capitolo 6, Sezione B.

SEZIONE A.1.11. – IDENTIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI E DI STRUTTURA

Per il controllo del raggiungimento degli obiettivi, ogni struttura territoriale e regionale, si avvale della reportistica offerta dal sistema informatico GISA nel quale devono obbligatoriamente essere riversati tutti i dati dei controlli ufficiali effettuati.

Con periodicità almeno trimestrale ogni struttura dovrà interrogare il sistema informatico utilizzando l'apposito campo "reportistica".

Per quanto riguarda le performance ad personam si possono presentare tre casi:

- la persona/operatore è riuscita a svolgere controlli per un numero di U.I.P. inferiore a quelle attribuitegli ad inizio anno e pertanto non ha raggiunto gli obiettivi di performance individuale
- la persona/operatore è riuscita a svolgere controlli per un numero di U.I.P. uguale a quelle attribuitegli ad inizio anno e pertanto ha raggiunto gli obiettivi minimi di performance individuale,
- la persona/operatore ha svolto controlli per un numero di U.I.P. superiore a quelle attribuitegli ad inizio anno e pertanto ha raggiunto e superato gli obiettivi minimi di performance individuale

Per quanto riguarda le performance di struttura si possono presentare tre casi:

- la struttura ha effettuato controlli impegnando un numero di U.P.S. inferiore a quelle attribuitegli ad inizio anno, e pertanto non ha raggiunto gli obiettivi di performance,
- la struttura ha effettuato controlli impegnando un numero di U.P.S. uguale a quelle stabilite ad inizio anno e pertanto ha raggiunto gli obiettivi minimi di performance,
- la struttura ha effettuato controlli impegnando un numero di U.P.S. superiore a quelle stabilite ad inizio anno e pertanto ha raggiunto e superato gli obiettivi minimi di performance.

Nel caso in cui la struttura abbia raggiunto gli obiettivi minimi di performance in termini di U.P.S. completando la programmazione assegnata nel DPAT ma il personale deve raggiungere ancora gli obiettivi ad personam è possibile programmare un numero ulteriore di controlli ufficiali che daranno priorità agli obiettivi assegnati dal DPAR ed in secondo luogo sulla base di una valutazione dei rischi.

SEZIONE A.2. - PERSONALE DELLA A.C. CHE EFFETTUA CONTROLLI UFFICIALI

SEZIONE A.2.1. - INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE CHE EFFETTUA I CONTROLLI UFFICIALI

Il D.lgs. 27/2021, all'articolo 2 comma 11 stabilisce che "al personale delle Autorità competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. In ogni caso, almeno uno dei componenti delle squadre che effettuano controlli deve avere la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ex art. 55 CPP. Pertanto, nel caso il controllo sia effettuato da un singolo addetto, questi deve avere la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Al fine di chiarire l'attribuzione di tale specifica qualifica al personale operante nell'ambito del SSR, si deve premettere che:

- tutti i dirigenti, TPAL e specialisti ambulatoriali possono trovarsi a svolgere le funzioni proprie dell'UPG, ai sensi degli artt. 55 e 57 terzo comma CPP;
- nessun atto normativo indica a quale Autorità, Organo o Amministrazione spetti la formalizzazione dell'attribuzione della qualifica di UPG;
- tale ruolo viene esercitato nel momento e nelle situazioni in cui la Legge obbliga il Pubblico Ufficiale a svolgerne le correlate funzioni.

In ogni caso tale qualifica non discende dalla mera sussistenza del rapporto subordinato (dirigenza e TPAL) o parasubordinato (specialisti ambulatoriali), ma dall'effettivo ruolo e dall'effettivo incarico assegnato al singolo funzionario. Ad esempio, ai funzionari che per qualsiasi legittimo impedimento non svolgono controlli ufficiali, non può essere attribuita la qualifica di UPG non svolgendo alcuna attività nel corso delle quali possa rilevare un reato. La formalizzazione della qualifica di UPG è comprovata dal rilascio delle relative tessere di riconoscimento.

SEZIONE A.2.2. - COMPORTAMENTO, INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTI D'INTERESSE

Il personale afferente alle A.C. addetto all'effettuazione dei controlli ufficiali deve:

1. svolgere il proprio operato con la giusta diligenza comportamentale ed una condotta idonea, adeguata, appropriata e rispettosa delle norme comportamentali stabilite per i dipendenti pubblici dal D.P.R. n. 62/2013;
2. esercitare le proprie funzioni e mansioni tecnico-professionali con adeguata autonomia, scienza e coscienza, a maggior ragione nel caso rivesta un ruolo dirigenziale ex art. 15 co. 3 del D.Lgs 502/1992;
3. assicurare al cittadino ed alle imprese la dovuta imparzialità, competenza, coerenza, trasparenza, riservatezza ed integrità;
4. essere libero da qualsiasi pregiudizio o conflitto di interesse; nello specifico è considerato come conflitto d'interesse l'eventualità che egli stesso, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al quarto grado nonché gli affini fino al terzo grado:
 - abbiano rapporti di lavoro o economici con imprese titolari di stabilimenti, di cui si può ragionevolmente supporre che rientrino nella propria sfera di controllo
 - effettuino consulenze per imprese che conducono stabilimenti, di cui si può ragionevolmente supporre che rientrino nella propria sfera di controllo
 - siano titolari o avere quote societarie ovvero avere interessi finanziari diretti o indiretti in imprese che conducono stabilimenti, di cui si può ragionevolmente supporre che rientrino nella propria sfera di controllo
 - abbiano rapporti di frequentazione abituale con titolari di stabilimenti, di cui si può ragionevolmente supporre che rientrino nella propria sfera di controllo
 - abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi con imprese di cui si può ragionevolmente supporre che rientrino nella propria sfera di controllo
 - sia tutore, curatore, procuratore o agente di imprese o di titolari di imprese di cui si può ragionevolmente supporre rientrino nella propria sfera di controllo
 - sia amministratore o gerente o dirigente di organizzazioni, di enti, associazioni anche non riconosciute o comitati che conducano stabilimenti di cui si può ragionevolmente supporre rientrino nella propria sfera di controllo
5. agire nel rispetto delle regole procedurali stabilite dalle norme cogenti, dalla Regione e dall'A.S.L., assicurando al cittadino ed alle imprese la legittimità dell'azione svolta, e dando comunicazione all'ufficio di appartenenza qualora si appalesino gravi ragioni di convenienza diverse da quelle di cui al punto precedente;
6. non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
7. evitare dolose o colpose trasgressioni degli obblighi di servizio o delle regole di

condotta;

8. in casi di contestazione dell'azione svolta, dar prova di aver agito senza negligenza, imprudenza o imperizia;
9. rispettare le gerarchie funzionali della struttura in cui opera, nonché ottemperare alle indicazioni ed alle disposizioni impartite;
10. mantenere il segreto sull'attività di controllo svolta nelle imprese, né comunicare ad alcuno gli esiti al di fuori di comprovate ed autorizzate necessità di divulgazione;
11. mantenere il segreto sugli atti e sulle operazioni di Polizia Giudiziaria;
12. mantenere il segreto sulle procedure produttive adottate negli stabilimenti, sia che esse abbiano o meno le caratteristiche di segreti industriali;
13. mantenere il segreto sulle caratteristiche di composizione dei prodotti trattati e le loro modalità di preparazione, né giudicare o comparare in pubblico le imprese o i loro prodotti.
14. dare prova della propria competenza attuando il principio del "sapere", "saper fare", "saper essere".

Per far sì che sia alle imprese soggette a controllo che agli stakeholder sia garantita la "terzietà" dell'azione del personale afferente alle A.C., è necessario che questi dichiarino esplicitamente l'assenza di incompatibilità e l'inesistenza di conflitti di interessi nei confronti dell'impresa o del cittadino la cui attività è soggetta al controllo. A tal fine, la procedura documentata denominata Mod. 5 da utilizzare obbligatoriamente da parte dell'A.C. per la descrizione delle ispezioni, contiene una dichiarazione in tal senso. Analoga dichiarazione dovrà essere inserita nei verbali di audit. Se viceversa esistessero motivi di incompatibilità e/o conflitto di interessi, gli addetti al controllo ufficiale si asterranno dall'effettuazione del controllo stesso, relazionando in merito alle figure gerarchicamente superiori.

In ogni caso, affinché i responsabili delle strutture delle A.C. possano essere in possesso di tutti i dati utili all'approntamento di una corretta programmazione delle attività di controllo, è prevista la sottoscrizione annuale del Mod. 8 denominato "*Dichiarazione di presenza/assenza di conflitti d'interesse*" tramite il quale ogni addetto ai controlli, non escluso il livello dirigenziale, comunica la sussistenza o meno di incompatibilità e/o l'esistenza o meno di conflitti di interessi nei confronti di una o più imprese di cui si può ragionevolmente supporre rientrino nella propria sfera di controllo. Il responsabile della struttura cui afferisce il dichiarante, terrà conto della dichiarazione ai fini della programmazione dei controlli. Al personale che, in presenza di accertata incompatibilità e/o esistenza di conflitti di interessi, ha ommesso la dichiarazione obbligatoria ovvero questa risulta mendace, si applicano le sanzioni previste dal combinato disposto del Contratto Nazionale di Lavoro e dagli artt. da 55 a 55 sexies del D.Lgs. 165/01.

SEZIONE A.2.3. - ACCESSO AGLI ATTI/TRASPARENZA

Usualmente negli uffici che si occupano di sicurezza alimentare, di sanità pubblica veterinaria o sanità delle piante, non esiste documentazione riservata, fatti salvi:

- gli atti inerenti attività di P.G.;
- gli eventuali dati sensibili riportati in alcune documentazioni.

Pertanto, al di fuori dei due casi sopra descritti, la documentazione deve essere accessibile a qualsiasi addetto ai controlli ufficiali obiettivamente motivato, stante l'utilità della stessa allo svolgimento delle attività di controllo. Viceversa, sarà cura del responsabile della struttura operativa o di un suo delegato tenere chiusa e inaccessibile l'eventuale documentazione riservata.

La trasparenza e conoscibilità delle check list, che fanno parte del Sistema Ufficiale di Valutazione del Rischio e che sono utilizzate dalle A.C. durante i controlli ufficiali, è garantita anche tramite un meccanismo di compliance volontaria attuato dalle imprese tramite il servizio digitale *GISA Autovalutazione*. Il servizio, rivolto a imprese già attive o in procinto di avviare la loro attività, utilizza il digitale per informare e formare le imprese sui rischi connessi alle loro linee di attività favorendo la consapevolezza dei rischi, la prevenzione, la salute pubblica e la crescita economica del settore produttivo. La trasparenza, standardizzazione e pubblicazione delle check list utilizzate durante i controlli ufficiali è in linea con il Regolamento UE 625/2017 e con l'art. 27 della Legge 118/2022.

SEZIONE A.2.4. - RAPPORTI CON ALTRE AUTORITÀ

I rapporti con altre Autorità, Enti, Forze dell'ordine etc sono tenuti dal responsabile della competente struttura del Dipartimento di Prevenzione ovvero dal personale all'uopo delegato, con atto formale o da atti normativi interni.

SEZIONE A.3 – CONTROLLI UFFICIALI

I controlli ufficiali effettuati dalle A.C. nei settori di cui all'audit universe vengono effettuati utilizzando le tecniche ed i metodi di controllo ufficiale elencati nel Reg. UE 2017/625.

Tutte le diverse forme di metodi e tecniche di controllo ufficiale hanno come elemento base la "verifica", intendendo con questa il controllo di un singolo requisito specifico. L'operatore, quindi "verifica" la corrispondenza del quid sottoposto a controllo con la normativa in vigore, oppure verifica la presenza di un "fattore di rischio" anche se non codificato in normativa. Le check list per la categorizzazione del rischio sono un tipico esempio dei due tipi di verifiche sopradescritti: poste sotto forma di domande, alcune di esse sono tese a "verificare" se siano presenti non conformità a norme cogenti, mentre altre acquisiscono solo elementi per una migliore valutazione del rischio nello stabilimento, pur se tali elementi non sono codificati da alcuna normativa.

Stabilito ciò, tutti i principali metodi e tecniche di controllo ufficiale previsti dalla normativa cogente, al di fuori del campionamento per analisi, possono essere ricondotti e ricompresi in due tipologie:

1. Ispezione

2. Audit

Quale evidenza dei controlli ufficiali espletati e delle attività collegate (campioni, sanzioni) è utilizzata la modulistica approvata da apposito Decreto Dirigenziale Regionale.

SEZIONE A.3.1. ISPEZIONE

L'ispezione corrisponde all'accesso presso una struttura (stabilimento, azienda zootecnica, mezzo di trasporto, etc) per effettuare il controllo di un qualsiasi aspetto, attività o processo svolto nella stessa.

Sebbene il Reg UE 2017/625 non ne faccia menzione, la Regione Campania, nell'ambito della propria autonomia gestionale derivata dal Titolo V della Costituzione ed al fine di ottenere una maggiore efficienza del S.G.C.U., ha identificato, come già riportato precedentemente, le tre seguenti tipologie di ispezione:

1. Ispezione "semplice"
2. Ispezione "complessa" altrimenti denominata "ispezione per la definizione del ranking dello stabilimento"
3. Ispezione "fast" le quali variano solo per l'intensità ed il tempo medio necessario al loro espletamento.

Di norma l'ispezione viene effettuata senza preavviso; pur tuttavia è considerato lecito preavvisare l'impresa in merito all'ispezione da effettuare qualora:

- l'AC ritenga indispensabile la presenza del titolare dello stabilimento
- il mancato preavviso può molto probabilmente inficiare l'esecuzione stessa dell'ispezione (ad es. negli stabilimenti che operano saltuariamente, in aziende agricole o zootecniche dove spesso non sono presenti gli addetti, etc)

L'ispezione consta di una o più verifiche.

Il monitoraggio e la categorizzazione del rischio rappresentano, rispettivamente, una forma di aggregazione di ispezioni e un metodo particolare di effettuazione di ispezioni; nel monitoraggio viene controllato uno specifico aspetto in più stabilimenti (in ognuna di esse, pertanto, viene effettuata un'ispezione per il controllo di quello specifico aspetto). Prendendo spunto dall'ormai abrogato Reg CE 882/04, la categorizzazione del rischio invece è un'ispezione durante la quale vengono sottoposte a controllo tutte le attività svolte in uno stabilimento/azienda. Nel Reg. UE 2017/625 si introduce il concetto di screening mirato.

Come ormai stabilito anche a livello nazionale, ogni ispezione corrisponde al controllo di una delle linee d'attività svolte in uno stabilimento (terza colonna delle master list previste dalla DGRC 318/15 e s.m.i.). Ad esempio, se nel corso del medesimo accesso presso uno stabilimento nel quale vengono svolte più linee d'attività, sono state ispezionate due di queste linee, risulterà che sono state effettuate due ispezioni. Il sistema informatico GISA è predisposto per l'inserimento di più ispezioni effettuate nel corso di un unico accesso presso uno stabilimento che svolga più linee d'attività; ciò è fondamentale per ottenere una reportistica distinta per linea d'attività sul:

- numero dei controlli ufficiali effettuati;
- numero dei campioni prelevati;
- numero e grado di non conformità accertate.

Tale reportistica a sua volta è ovviamente basilare per la valutazione del rischio locale e regionale. In proposito si specifica che le redazioni di più Mod. 5 di ispezione (ed il contemporaneo inserimento di più ispezioni in GISA) differenti tra loro solo per motivi del controllo (allerta, piano di monitoraggio, ect.) per ispezioni effettuate:

- presso la medesima linea d'attività di uno stabilimento
- da parte del medesimo personale
- nel corso della stessa giornata lavorativa

deve essere considerata come una **grave inefficienza del personale della P.A.** che in tal modo opera in contrasto con i dettami dell'art. 1 della L. 241/90; in tal caso la struttura gerarchicamente superiore al personale che ha operato in difformità della presente norma dovrà contestare tale grave inefficienza, riportandola anche nella valutazione della performance individuale.

La Regione svolge attività di "ispezione" in stabilimenti/aziende avvalendosi del "Nucleo Regionale di Controllo Ufficiale" (Nu.Re.C.U.).

Le ispezioni effettuate dal Nu.Re.C.U. vengono svolte esclusivamente:

- in casi di emergenza,
- in stabilimenti che effettuano l'esportazione dei loro prodotti,
- su indicazione ministeriale
- allorquando l'UOD 01 lo ritenga opportuno

SEZIONE A.3.2. – ISPEZIONE PER LA DEFINIZIONE DEL RANKING DELLO STABILIMENTO (CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO)

La differenza tra una ispezione "semplice" ed una effettuata per la definizione del ranking dello stabilimento, consiste nel fatto che nel corso della prima le verifiche possono limitarsi anche solo ad uno o alcuni aspetti, mentre nel caso della categorizzazione del rischio devono essere verificati tutti gli aspetti che attengono le attività svolte nella linea d'attività dello stabilimento, ad eccezione del controllo dell'autocontrollo per il quale si ritiene più appropriato l'audit.

Nel corso di tale tipologia di ispezione si dovrà procedere a raccogliere ogni evidenza utile alla valutazione del rischio dello stabilimento.

L'ispezione per la categorizzazione del rischio è compito esclusivo dei Servizi Medici e Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, che preferibilmente dovranno effettuarla congiuntamente quando uno stabilimento/azienda svolge linee di attività di competenza di entrambi i Servizi; la mancata effettuazione congiunta di tale ispezione è considerata come "*bad practice*". Analogamente le ispezioni per la categorizzazione del rischio svolte in aziende zootecniche dove vengono trattati linee di attività di competenza di strutture veterinarie diverse (benessere, anagrafe, farmacosorveglianza, profilassi delle malattie infettive etc), devono essere effettuate in maniera congiunta dal personale afferente a tali strutture. Qualora non fosse possibile per oggettivi e irrimediabili motivi organizzativi, il medico veterinario che svolge tale ispezione per la categorizzazione della linea d'attività effettua tutte le verifiche previste, a prescindere dall'area di appartenenza.

In entrambi i casi, alla linea d'attività viene attribuita la categoria di rischio così come scaturita dal punteggio accumulato nel corso dell'ispezione per la categorizzazione del rischio, senza possibilità di integrazione con i punteggi di altre check list redatte in ispezioni successive anche se effettuate a breve distanza di tempo.

Al fine di facilitare, uniformare e guidare gli addetti all'effettuazione delle verifiche durante l'ispezione nella fase della categorizzazione del rischio, sono state predisposte delle schede contenenti check-list relative alle linee d'attività che possono essere svolte negli stabilimenti. Le check-list sono articolate in modo da avere un risultato numerico finale. Tale risultato farà inserire la linea d'attività in una delle cinque categorie di rischio previste. Ad ogni categoria di rischio corrisponderanno la tipologia, la frequenza e l'intensità dei successivi metodi e tecniche di controllo ufficiale da effettuarsi in quelle linee d'attività dello stabilimento.

Sarà cura della U.O.D. 01 sottoporre a revisione le check list in considerazione delle esigenze ed osservazioni degli operatori sanitari e dei progressi scientifici e tecnici.

Al fine di giungere ad una definizione quanto più possibile obiettiva del livello di rischio degli stabilimenti riconosciuti, viene considerata come best practice:

- far effettuare le ispezioni per la categorizzazione del rischio da personale diverso da quello impegnato solitamente ad effettuare ispezioni semplici nello stesso stabilimento;
- far partecipare all'ispezione, a supporto dei controllori, il medico o veterinario ufficiale referente di uno stabilimento riconosciuto.

SEZIONE A.3.3. - AUDIT

L'audit è una tecnica di controllo ufficiale che si attua previo preavviso all'impresa.

L'audit deve consentire di verificare che l'impresa ed il personale dell'impresa, osservino le procedure, le istruzioni e le linee guida poste a tutela della salute pubblica, e che le stesse siano efficaci. L'audit, pertanto, è uno strumento insostituibile per accertare che:

1. l'impresa abbia ben chiaro gli obiettivi di salute e di tutela della leale concorrenza da raggiungere;
2. le modalità di svolgimento delle attività operative siano appropriate e idonee a raggiungere gli obiettivi prestabiliti;
3. le modalità di svolgimento delle attività operativo/produttive siano conformi alla normativa ed a quanto stabilito dall'impresa stessa in autocontrollo;
4. le modalità di svolgimento delle attività operative siano sufficientemente descritte, siano state diffuse al personale e siano state da loro comprese.

Attraverso le ispezioni, quindi, è possibile valutare la conformità dello stabilimento sottoposto a controllo nel momento stesso dell'ispezione, mentre attraverso l'audit, valutando le procedure messe in atto, si può verificarne l'efficacia e prevederne il rischio in base ai dati acquisiti.

Per quanto riguarda esclusivamente gli audit, le parole "pianificazione" e "programmazione" invertano il loro significato rispetto a quanto riportato nell'introduzione al presente P.C.R.P., in modo da conformarsi alle definizioni della norma ISO 19011.

SEZIONE A.3.4. – PIANI DI MONITORAGGIO

Sebbene il Reg UE 2017/625, a differenza dell'abrogato Reg CE 882/2004, non contempli espressamente la tecnica del monitoraggio ma utilizza il termine screening, pur tuttavia la Regione Campania nella sua autonomia gestionale intende ancora avvalersi di tale tecnica che indubbiamente offre procedure che ben si attagliano al SGCU regionale.

I piani di monitoraggio vengono pianificati allorché la valutazione del rischio, nazionale, regionale o locale, rilevi la necessità o l'opportunità di avere un controllo sistematico della conformità di un aspetto inerente la sicurezza alimentare o la sanità pubblica veterinaria, procedendo alla verifica di un dato ad esso riferibile. I Piani pertanto prevedono sempre l'effettuazione di ispezioni in più stabilimenti per verificare determinati aspetti che sono l'oggetto del piano. La verifica può essere visiva o potrà avvalersi di rilievi effettuati con l'ausilio di strumentazioni o di esami di laboratorio previo campionamento.

Al fine del loro approntamento, i piani di monitoraggio devono illustrare:

1. i motivi della loro pianificazione, indicando:
 - gli scopi
 - le A.C. incaricate dei controlli ufficiali da svolgere
 - gli aspetti da sottoporre a verifica
 - le istruzioni operative
 - i modelli da utilizzare
 - le attrezzature necessarie
 - il laboratorio ufficiale
 - la durata
 - i costi e i benefici
2. la programmazione, indicando:
 - la frequenza delle verifiche
 - il numero delle verifiche suddiviso per ASL
3. la verifica dei risultati, indicando se:
 - gli scopi siano stati raggiunti,
 - si valuta utile la sua prosecuzione o sia necessario apportare modifiche

SEZIONE A.3.5. - CAMPIONAMENTI PER ANALISI

I campionamenti per analisi da effettuarsi durante la vigenza del presente P.C.R.P. 2023-2027 saranno effettuati quando:

- a) siano previsti dai Piani di monitoraggio,
- b) insorga un sospetto durante le ispezioni o gli audit,
- c) per qualsiasi altra motivazione (da specificare obbligatoriamente sul verbale).

SEZIONE A.4. – ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI

Il Reg. UE 2017/625 all'art. 2 prevede che, oltre ai controlli ufficiali, le A.C. procedono all'effettuazione anche di «altre attività ufficiali», attività che, sebbene possano essere svolte anche con le stesse tecniche dei controlli, come ad esempio le ispezioni, i monitoraggi etc, sono diverse dai controlli ufficiali stessi. Sebbene il regolamento non dia una definizione precisa di tali attività, ne include come esempio quelle tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, ad eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali. Da ciò è desumibile che nelle “altre attività ufficiali” sono comprese tutte quelle attività di contrasto alle malattie infettive degli animali, le certificazioni per l'esportazione di prodotti, i controlli da remoto etc.

Nel DPAR, che rappresenta la summa dei controlli delle AA.SS.LL., ogni piano di monitoraggio ed ogni attività viene inquadrata come “controllo ufficiale” o come “altra attività ufficiale”.

A.5. - GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Si definisce “non conformità” la mancata corrispondenza di una azione, attività, alimento, attrezzatura, struttura, documento, stato di un animale, etc, ai requisiti di una normativa, oppure una procedura errata che, a giudizio del valutatore, aumenta il rischio inteso come funzione della probabilità della presenza di un pericolo; esse possono essere identificate anche come “carenze” o “errori” o “omissioni” dolose o colpose, e denotano in ogni caso un limite sulle capacità di valutazione del rischio da parte dell'operatore e sulla sua capacità di approntare correttamente le procedure di autocontrollo.

Nel rispetto della ratio dei Reg. CE 178/02 e 852/04 che danno la completa responsabilità delle attività svolte in uno stabilimento/azienda all'impresa, non è compito dell'A.C. indicare le azioni correttive da adottare. Queste sono lasciate alla libera scelta dell'impresa nel rispetto degli obiettivi della norma e dei tempi stabiliti dall'autorità competente stessa. Quest'ultima deve solo verificare l'adozione, la completezza e l'efficacia delle azioni correttive adottate dall'impresa entro i termini prescritti. In considerazione dell'appropriatezza di tale procedura ed al fine di non creare disparità di comportamento all'interno delle A.C., si stabilisce che tale concetto è comune ed applicabile sia alla sicurezza alimentare che alla sanità pubblica veterinaria.

Le non conformità possono essere accertate attraverso una qualsiasi tecnica o metodo di controllo ufficiale (ispezione, audit, campionamento).

Della rilevazione bisogna darne opportuna conoscenza all'operatore affinché questi possa mettere in atto tutte le azioni correttive per annullare la non conformità ed i suoi effetti.

Il presente P.C.R.P. non prevede l'adozione di una scheda di non conformità specifica in quanto sia il Mod. 5 che il rapporto finale di audit ricomprendono in maniera esaustiva tutte fasi di identificazione, valutazione del rischio e risoluzione della non conformità accertata.

Le non conformità possono essere distinte a seconda del grado di gravità in:

- 1) significative o minori: sono quei comportamenti o situazioni che, sebbene non riferite ad un requisito cogente, possono essere valutate dall'A.C. come fattore di aumento del rischio in misura maggiore rispetto alle n.c. formali, e comportano, pertanto, la necessità di idonee azioni correttive; è compito del sanitario valutare il tempo necessario e sufficiente da concedere all'operatore per la risoluzione della stessa.

Ai fini della determinazione del punteggio storico delle non conformità, ogni non conformità significativa accertata avrà un punteggio numerico di 7 (sette);

- 2) gravi o maggiori: sono quei comportamenti o situazioni che hanno un impatto notevole sul rischio; esse rappresentano spesso violazioni a norme cogenti incriminatrici che prevedono in astratto la fattispecie rilevata durante i controlli e conseguentemente ne prevedono la punibilità; alla loro rilevazione corrisponde sempre l'adozione di uno o più delle seguenti azioni di follow up:

- provvedimenti restrittivi dell'attività produttiva (sospensioni, chiusure, ecc.);
- sequestri;
- contestazione di illeciti amministrativi;
- diffide;
- trasmissione di notizie di reato.

La rilevazione di una n.c. grave comporta la necessità di una revisione attenta dei piani di autocontrollo e delle procedure HACCP e/o BPI.

SEZIONE A.5.1. - FOLLOW UP E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLE NON CONFORMITÀ

Nel caso le conclusioni dell'audit o delle ispezioni, nonché il referto delle analisi di campioni, evidenzino delle non conformità formali o significative, l'A.C. adotta provvedimenti amministrativi, aventi la valenza di atti autoritativi ex L. 241/90, con i quali impone la risoluzione delle non conformità.

Nel caso invece siano state accertate delle non conformità gravi, le azioni che in linea generale l'A.C. può mettere in atto sono:

- adozione di provvedimenti amministrativi restrittivi dell'attività produttiva (sospensioni, chiusure, sequestri sanitari ecc.), aventi sempre la valenza di atti autoritativi ex L. 241/90, con i quali impone anche la risoluzione delle non conformità
- contestazione di illeciti amministrativi con eventuale sequestro amministrativo della merce confiscabile
- diffide
- adozione di atti a valenza penale (notizie di reato, sequestri penali etc).

A titolo d'esempio si riporta di seguito l'elenco più dettagliato delle possibili azioni di follow up e dei provvedimenti consequenziali adottabili dall'AC, come scaturiti dal combinato disposto degli artt. 137 e 138 del Reg UE 2017/625, della L. 241/90, della L. 689/81, del C.P.P.:

FOLLOW UP	VALENZA DEL PROVVEDIMENTO	DIRITTO AL RICORSO
Imposizione di: - trattamenti sulle merci - modifica delle etichette - fornitura di informazioni correttive da fornire ai consumatori	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	1. richiesta all'ufficio di annullare/modificare il provvedimento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/80 2. presentazione ricorso gerarchico ex DPR 1199/71 entro 30 giorni 3. ricorso al TAR entro 60 giorni 4. presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
Limitazione o divieto di immissione in commercio di alimenti animali o merci	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	
Imposizione del: - divieto di spostamento di animali e di merci - divieto di ingresso nell'Unione di animali e di merci - divieto di esportazione di animali e di merci - ritorno nello Stato membro di spedizione di animali o merci	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	
Imposizione dell'aumento della frequenza dei controlli da parte dell'operatore	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	
Imposizione dell'isolamento o chiusura per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte dell'attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	
Imposizione della cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato e se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	
Imposizione della sospensione o ritiro della registrazione, dell'autorizzazione o riconoscimento dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	
Imposizione della macellazione o l'abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere animali	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	
Imposizione della risoluzione della non conformità	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	

FOLLOW UP	VALENZA DEL PROVVEDIMENTO	DIRITTO AL RICORSO
Imposizione della modifica delle procedure di HACCP, GMP, GHP, con relativa modifica dei piani di autocontrollo	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	1. Richiesta all'ufficio di annullare/modificare il provvedimento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/80 2. presentazione ricorso gerarchico ex DPR 1199/71 entro 30 giorni 3. ricorso al TAR entro 60 giorni 4. presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
Imposizione della modifica o implementazione delle procedure di sanificazione	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	
Imposizione del richiamo e/o del ritiro, la distruzione di merci o il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	
Ordina o esegue trattamenti su animali	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	
Imposizione di: • scarico e trasbordo degli animali su un altro mezzo di trasporto • la detenzione e cura degli animali • periodi di quarantena • rinvio dell'abbattimento di animali • ricorso ad assistenza veterinaria	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	
Sequestro sanitario di animali, alimenti, di locali, di attrezzature, di materiali destinati al contatto con gli alimenti, etc	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	
Notifica di un sistema d'allarme rapido	provvedimento amministrativo (L. 241/90) adottato per motivi sanitari	

FOLLOW UP	VALENZA DEL PROVVEDIMENTO	DIRITTO AL RICORSO
Contestazione di un illecito amministrativo ex L. 689/81	Provvedimento amministrativo disciplinato dalla L. 689/81	Autorità varie. All'U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria nelle materie previste dalla DGRC 623/14
Sequestro amministrativo di merce o animali confiscabili ex art. 13 L. 689/81	Provvedimento cautelare di natura amministrativa disciplinato dalla L. 689/81 e dal D.P.R. 571/52	Autorità varie. All'U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria nelle materie previste dalla DGRC 623/14
Sequestro penale di animali, alimenti, di materiali destinati al contatto con gli alimenti, etc	Atto a valenza penale	Autorità giudiziaria in prima istanza
Trasmissione di una notizia di reato scaturita dalla rilevazione di un illecito di natura penale	Atto a valenza penale	Autorità giudiziaria in prima istanza
Qualsiasi altra misura ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli alimenti, dei mangimi o la conformità alla normativa in materia di sanità pubblica veterinaria	A secondo del provvedimento	A secondo del provvedimento

Ai sensi del D.Lgs 27/2021 e s.m.i. le Regioni e le AA.SS.LL. sono le Autorità Competenti per l'esecuzione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare rispettivamente a livello regionale e locale; ai sensi della normativa vigente e come ribadito nel P.C.N.P., tale concetto è esteso anche alla sanità pubblica veterinaria.

Per A.C. deve intendersi il singolo operatore sanitario che effettua il controllo, il quale nell'ambito delle proprie funzioni è delegato ex ante dall'Ente di appartenenza a rappresentarlo e ad assumerne l'autorità giuridica relativamente ai poteri autoritativi. Tale delega ex ante non ha bisogno di preventivo atto formale in quanto stabilito dal presente Piano.

Ai sensi dell'art. 4, punto 3, del D.L.vo 165/01, come singolo operatore sanitario deve intendersi non solo il personale della dirigenza, ma anche gli specialisti ambulatoriali quando possiedono la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi della precedente Sezione A.2.1., nonché i TT.PP.AA.LL. del comparto, cui, in assenza di personale della dirigenza nel corso del controllo, si attribuiscono le funzioni di adozione dei provvedimenti amministrativi, senza la necessità di ulteriori atti formali per tale attribuzione; resta necessario in tali casi la successiva validazione dei provvedimenti amministrativi da parte del diretto Responsabile della struttura di appartenenza ovvero da altro dirigente da questi delegato.

Per quanto sopra, i singoli operatori dei controlli ufficiali sono tenuti ad adottare gli atti autoritativi o qualsiasi altro provvedimento amministrativo resi necessari, rappresentando di per sé l'Ente di appartenenza. In ogni caso i sopracitati Enti conservano il diritto all'autotutela ex art. 21 *nonies* della L. 241/90 (annullamento d'ufficio), avendo la facoltà di apportare modifiche o annullare atti illegittimi per vizi di forma o per qualsiasi altro valido

motivo. L'annullamento d'ufficio è effettuato dai dirigenti così come gerarchicamente collocati nella struttura organizzativa cui appartiene l'operatore che ha effettuato il controllo e ha adottato gli atti considerati illegittimi.

I provvedimenti amministrativi (ad es. le imposizioni della risoluzione di non conformità, i sequestri sanitari, l'ordine di abbattimento di animali, etc) adottati dagli operatori dei controlli ufficiali e rivolti all'impresa che conduce lo stabilimento/azienda, non devono pertanto essere convalidati da altra Autorità, in quanto possono essere considerati di un livello di intervento "ordinario" da un punto di vista sanitario, concernente normali controlli in materia di sicurezza alimentare e tutela della salute animale e umana.

La convalida diviene necessaria solo allorquando la situazione di rischio sanitario non sia limitata allo stabilimento presso il quale è stata accertata la non conformità, in quanto gli effetti di quest'ultima possono influire negativamente sullo stato sanitario della popolazione umana/animale anche delle zone limitrofe. In base alla valutazione del rischio:

- se l'ambito della zona interessata riguarda il solo territorio comunale dove insiste lo stabilimento, il Sindaco rappresenta l'Autorità competente alla convalida dei provvedimenti
- se l'ambito della zona interessata oltrepassa il solo territorio comunale coinvolgendo anche territori di altri Comuni, il Presidente della Regione rappresenta l'Autorità competente alla convalida dei provvedimenti

Come specificato nella Circolare del Ministero della Salute DGSA/1948 del 3/2/2009, trattasi in questi casi, di un livello di intervento "straordinario" da un punto di vista sanitario, adottato ad esempio nei casi di emergenza sanitaria; stante la necessità di mettere in atto misure eccezionali adottando provvedimenti amministrativo-sanitari i cui effetti ricadono necessariamente anche su soggetti terzi allo stabilimento in cui è stata accertata la non conformità, in tali casi va presentata una proposta di provvedimento amministrativo che va trasmessa nei modi di legge al Presidente della Giunta Regionale o al Sindaco, secondo le rispettive competenze, così come previsto dalle LL.RR. 25/83 e 13/85.

Alla stregua di quanto sopra riportato, gli atti impositivi ed i provvedimenti amministrativi adottati dai CC NAS non necessitano di convalida a cura delle A.C. regionali e locali o dei Sindaci, in quanto essi sono direttamente incardinati nella struttura organizzativa del Ministero della Salute che rappresenta il primo dei tre livelli dell'Autorità Competente.

Rimane necessaria la convalida:

- a cura della Regione, nelle materie di propria competenza, dei sequestri amministrativi effettuati in seguito all'accertamento di illeciti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla DGRC n. 623/2014;
- a cura della Autorità Giudiziaria per i sequestri penali.

Conformemente allo spirito del "pacchetto igiene" che assegna all'operatore la responsabilità in materia di sicurezza alimentare, anche nel campo della sanità animale spetta all'impresa stessa la scelta dell'azione da intraprendere per la risoluzione delle non conformità.

Se la valutazione del rischio lo consente, all'impresa può essere concesso un congruo termine per la risoluzione delle non conformità. Tale termine sarà possibilmente concordato con l'impresa e sarà proporzionato al rischio legato alla presenza delle non conformità, tenuto

anche conto dei dati storici dello stabilimento; nel frattempo, se il rischio risulta accettabile, i funzionari possono permettere la prosecuzione dell'attività dello stabilimento/azienda. Se invece il rischio, derivante dalla non conformità, è tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, l'A.C. può autonomamente imporre il rallentamento dell'attività, la sospensione totale o parziale o qualsiasi altro giustificata imposizione. In linea generale i provvedimenti amministrativi vanno adottati previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della 241/90 e con le modalità di cui all'art. 8 stessa Legge; pur tuttavia ai sensi del punto 1 dello stesso art. 7, tale comunicazione non è necessaria laddove ci siano particolari esigenze di celerità del procedimento, come nel caso dei provvedimenti contestuali ad un sopralluogo ispettivo, in quanto finalizzati alla tutela della salute pubblica; inoltre tali provvedimenti hanno efficacia cautelare ed urgente ai sensi dell'art. 21 *bis* e *quater* della L. 241/1990. Pertanto, la comunicazione all'interessato dei provvedimenti amministrativo-sanitari effettuata mediante la redazione di un Mod. 5 di ispezione contestualmente all'ispezione stessa, nel quale sono state regolarmente descritte le non conformità e la loro valutazione del rischio, è sufficiente ad adempiere a tutte le succitate norme in materia di procedimento amministrativo e ad assicurare la loro validità.

SEZIONE A.5.2. - PROCEDURE PER LA VERIFICA DELLA RISOLUZIONE DELLE NON CONFORMITÀ ACCERTATE

Ad ogni accertamento di una non conformità maggiori e minori (strutturale, gestionale, documentale, ecc.), deve seguire una successiva verifica documentata dell'avvenuta risoluzione. Nell'effettuare la nuova ispezione, tesa alla necessaria verifica, le A.C. compileranno un nuovo Mod. 5 compilando la specifica sezione all'uopo prevista.

L'A.C. provvederà a effettuare un'ispezione per la verifica dell'avvenuta risoluzione della non conformità minore solo quando abbia il sospetto che la risoluzione non sia avvenuta o quando l'operatore non abbia comunicato l'avvenuta risoluzione al termine del periodo concesso.

Nel caso l'AC accerti l'avvenuta risoluzione della non conformità, questa può essere considerata chiusa e gli atti possono essere archiviati.

Nel caso l'AC verifichi la mancata risoluzione della non conformità, essa procederà ad una o più delle azioni di follow up descritte nel precedente paragrafo, aumentando gradualmente le misure restrittive a danno dell'impresa nel corso della persistenza della non conformità, anche in considerazione del fatto che il comportamento omissivo dell'impresa rivela una sempre più accentuata mancanza di affidabilità.

Nel campo della sicurezza alimentare, inoltre, la mancata risoluzione è considerata una violazione all'art. 6 paragrafo 1 del Reg. CE 852/04 e pertanto viene sanzionata amministrativamente dall'art. 6, comma 7 del D.Lgs 193/07.

SEZIONE A.5.3. - SISTEMA SANZIONATORIO

Si rimanda alla DGRC n. 623/14 e s.m.i. dove vengono illustrate le procedure in materia di accertamento, contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative.

SEZIONE B - PROCEDURE DOCUMENTATE

Ai sensi dell'art. 12 del Reg UE 2017/625, il presente Piano predispone l'adozione da parte delle A.C. di alcune procedure documentate, contenenti anche istruzioni per il personale, cui le A.C. devono attenersi.

Inoltre, il presente Piano predispone l'adozione da parte delle A.C. di una modulistica che deve essere obbligatoriamente utilizzata dalle A.C. e che sia conforme ai dettami dell'art. 13 del Reg UE 2017/625.

I modelli devono essere redatti con diligenza, secondo il caso concreto; una volta redatti nel corso dei controlli, essi assumono la valenza di atti pubblici ai sensi dell'art. 2699 del C.C. e pertanto godono di una fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 del C.C. nel senso che fanno piena prova, fino a querela di falso, della loro provenienza, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La redazione attestante fatti o circostanze non veritiere comporta, tra l'altro, la contestazione di falso ideologico, mentre l'alterazione materiale degli atti redatti comporta il reato di falso materiale in atto pubblico.

Le procedure ed i modelli sono approvati unitamente ai DPAR o qualora si ritenga necessario una modifica impellente. Approvati con Decreto Dirigenziale della UOD 01 sono resi disponibili al personale delle AA.SS.LL. anche sulla bacheca del Sistema Informativo GISA.

SEZIONE C - REGISTRAZIONI DEI CONTROLLI UFFICIALI

Gli addetti ai controlli ufficiali afferenti alle A.C. hanno l'obbligo di inserire i dati dei loro controlli nel sistema informatico GISA già descritto nell'introduzione. Da tale obbligo consegue, tra l'altro, la possibilità per chiunque sia abilitato ad accedere al sistema informatico, di consultare l'anagrafica degli stabilimenti e la loro categorizzazione in base al rischio; a coloro che posseggono la qualifica di agente o ufficiale di P.G. è consentito l'accesso anche alla visione dei dati dei controlli ufficiali.

Il tempo tra la data di svolgimento dei controlli e il loro inserimento in GISA, costituisce uno dei criteri per la verifica dell'efficienza del personale che effettua i controlli ufficiali e degli uffici cui essi appartengono; tale criterio deve figurare tra quelli utilizzati per la valutazione del personale; si considera nei limiti dell'efficienza un lasso di tempo **non superiore ai 5 giorni lavorativi**, sempre che non vi siano impedimenti non dipendenti dalla volontà del personale che ha effettuato il controllo.

CAPITOLO 7 - RIESAME E ADATTAMENTO DEL PIANO

Il presente Piano è stato predisposto sulla base della valutazione del rischio effettuata sul report delle attività di controllo espletate nel corso del precedente Piano. Esso, pertanto, può definirsi risk based. Purtroppo, nel corso della sua vigenza possono palesarsi problematiche non previste (ad es. emergenze) o semplicemente la necessità di una rimodulazione delle norme in esso contenute. Il Riesame fa infatti parte dell'ACT del ciclo di Deming.

Nel caso in cui si appalesi invece la necessità di apportare modifiche agli allegati al presente Piano, il Punto di Contatto provvede alle stesse con appositi atti.